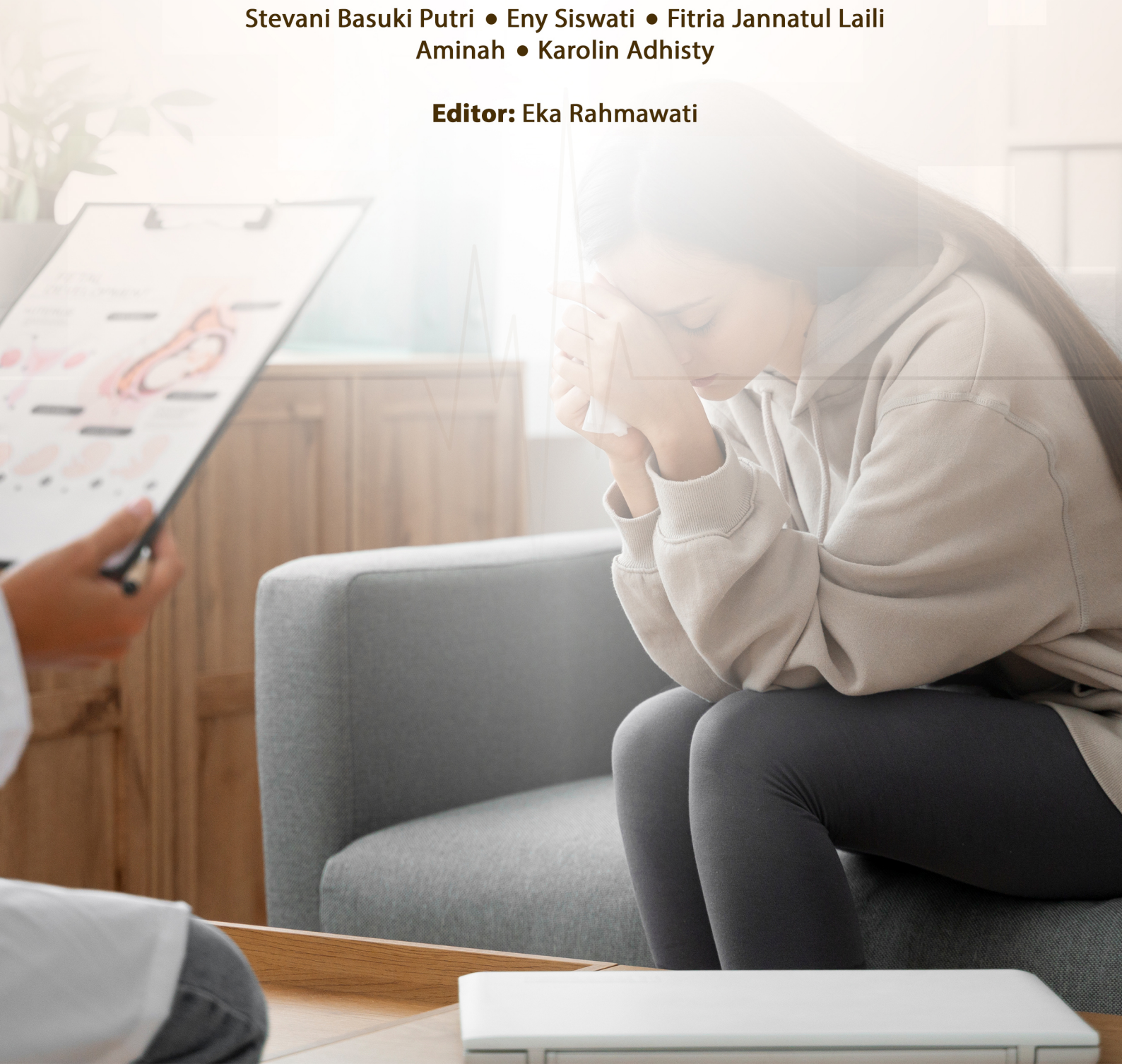


Bunga Rampai

KESEHATAN MENTAL PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF KEBIDANAN DARI MENARKE HINGGA MENOPAUSE

Stevani Basuki Putri • Eny Siswati • Fitria Jannatul Laili
Aminah • Karolin Adhisty

Editor: Eka Rahmawati



BUNGA RAMPAI KESEHATAN MENTAL PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF KEBIDANAN: DARI MENARKE HINGGA MENOPAUSE

Penulis:

Stevani Basuki Putri, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb.
Bdn. Eny Siswati, S.ST., M.Si.
Fitria Jannatul Laili, S.Keb., Bdn., M.M., M.Keb.
Aminah, S.S.T., M.Kes.
Karolin Adhisty, S.Kep., Ns., M.Kep.

Editor:

Eka Rahmawati, S.Tr.Keb., Bdn., M.Tr.Keb.



BUNGA RAMPAI KESEHATAN MENTAL PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF KEBIDANAN: DARI MENARKE HINGGA MENOPAUSE

Penulis: Stevani Basuki Putri, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb.

Bdn. Eny Siswati, S.ST., M.Si.

Fitria Jannatul Laili, S.Keb., Bd., M.M., M.Keb.

Aminah, S.S.T., M.Kes.

Karolin Adhistry, S.Kep., Ns., M.Kep.

Editor: Eka Rahmawati, S.Tr.Keb., Bdn., M.Tr.Keb.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-7426-17-8

Cetakan Pertama : Oktober, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025



PRAKATA



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, kasih, dan karunia-Nya, buku Bunga Rampai Kesehatan Mental Perempuan dalam Perspektif Kebidanan: Dari Menarke hingga Menopause akhirnya dapat terselesaikan. Kehadiran buku ini merupakan bentuk nyata dari komitmen akademisi dan praktisi kebidanan untuk menghadirkan karya ilmiah yang tidak hanya membahas aspek biologis, tetapi juga menyoroti dimensi psikologis dan sosial yang tak terpisahkan dari kehidupan seorang perempuan.

Kesehatan mental perempuan adalah pilar yang sangat menentukan kualitas hidup, tidak hanya pada dirinya sendiri tetapi juga pada keluarga, masyarakat, dan bangsa. Perjalanan kehidupan perempuan dari menarke, masa reproduktif, kehamilan, persalinan, nifas, hingga menopause adalah fase-fase yang sarat dengan dinamika. Setiap fase menghadirkan perubahan biologis yang diiringi dengan tantangan psikologis dan sosial. Tanpa dukungan yang memadai, perempuan berisiko mengalami gangguan kesehatan mental yang dapat memengaruhi keharmonisan keluarga serta perkembangan anak. Oleh karena itu, kesehatan mental perempuan patut menjadi perhatian serius dalam praktik kebidanan.

Bidan, sebagai tenaga kesehatan yang berinteraksi paling dekat dengan perempuan dan keluarga, memiliki peran strategis dalam mendampingi perjalanan panjang ini. Bidan tidak hanya bertugas pada aspek klinis, tetapi juga berperan dalam memberikan dukungan emosional, edukasi, konseling, serta advokasi kesehatan mental. Peran ini sangat penting untuk mendeteksi dini masalah psikologis, mendampingi proses adaptasi, hingga memfasilitasi rujukan bila diperlukan. Buku ini berupaya menggambarkan peran tersebut dengan pendekatan yang menyeluruh, berbasis bukti, dan peka terhadap konteks sosial-budaya.

Buku bunga rampai ini disusun dari beragam perspektif penulis yang memiliki kompetensi di bidang kebidanan, kesehatan masyarakat, dan psikologi. Setiap bab memberikan sudut pandang yang unik mengenai isu kesehatan mental perempuan, mulai dari tantangan remaja saat menarke, dinamika emosional pada masa kehamilan dan persalinan, hingga perubahan psikologis pada masa menopause. Dengan demikian, pembaca diharapkan memperoleh pemahaman yang komprehensif

mengenai bagaimana kebidanan dapat berkontribusi dalam menjaga kesejahteraan mental perempuan sepanjang siklus hidupnya.

Penyusunan buku ini tentu tidak terlepas dari keterbatasan. Namun, kerja sama, dedikasi, dan kontribusi para penulis menjadikan buku ini kaya akan wawasan, analisis, dan pengalaman lapangan. Harapan kami, buku ini dapat menjadi sumber rujukan yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, tenaga kesehatan, maupun pembuat kebijakan dalam mengembangkan praktik kebidanan yang holistik dan humanis. Lebih dari itu, semoga buku ini mampu menginspirasi lahirnya penelitian dan inovasi baru yang semakin memperkuat peran kebidanan dalam mendukung kesehatan mental perempuan Indonesia.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan buku ini. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat luas, membuka ruang diskusi yang lebih dalam mengenai kesehatan mental perempuan, serta menjadi salah satu ikhtiar dalam mewujudkan perempuan Indonesia yang sehat, tangguh, dan berdaya, baik secara fisik maupun mental.

Oktober, 2025

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v

CHAPTER 1 PENTINGNYA KESEHATAN MENTAL DALAM ASUHAN

KEBIDANAN	1
Stevani Basuki Putri, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb.....	1
A. Pendahuluan/Prolog	1
B. Hubungan Kesehatan Mental dan Kehamilan	2
C. Gangguan Mental yang Umum Dialami Ibu Hamil dan Nifas.....	5
D. Deteksi Dini dan Penilaian Kesehatan Mental dalam Kebidanan	7
E. Peran Bidan dalam Dukungan Kesehatan Mental	9
F. Pendampingan Psikososial dalam Asuhan Kebidanan	12
G. Studi Kasus: Dampak Dukungan Kesehatan Mental dalam Keberhasilan Kehamilan dan Persalinan	14
H. Tantangan dan Hambatan dalam Mengintegrasikan Kesehatan Mental ke dalam Praktik Kebidanan.....	16
I. Simpulan.....	18
J. Referensi	19
K. Glosarium	20

CHAPTER 2 KESEHATAN MENTAL PEREMPUAN DI MASA

PRAKONSEPSI DAN KEHAMILAN	23
Bdn. Eny Siswati, S.ST., M.Si.	23
A. Pendahuluan/Prolog	23
B. Pentingnya Kesehatan Mental dalam Periode Prakonsepsi.....	25
C. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kesehatan Mental pada Masa Prakonsepsi.....	27
D. Gangguan Mental yang Umum pada Masa Prakonsepsi	30
E. Hubungan antara Kesehatan Mental dan Kehamilan	32
F. Gangguan Mental selama Masa Kehamilan	35
G. Strategi Deteksi Dini dan Penilaian Kesehatan Mental pada Masa Prakonsepsi dan Kehamilan.....	37
H. Peran Tenaga Kesehatan dalam Menjaga Kesehatan Mental Perempuan pada Masa Prakonsepsi dan Kehamilan	40
I. Pendekatan Psikososial dalam Mendukung Kesehatan Mental Perempuan.....	42

J. Tantangan dan Solusi dalam Mengintegrasikan Layanan Kesehatan Mental dalam Pelayanan Prakonsepsi dan Antenatal	45
K. Simpulan.....	47
L. Referensi	48
M. Glosarium	50
CHAPTER 3 MANAJEMEN DEPRESI POSTPARTUM BERBASIS BUKTI.....	51
Fitria Jannatul Laili, S.Keb., Bd., M.M., M.Keb.....	51
A. Pendahuluan/Prolog	51
B. Etiologi dan Faktor Risiko Depresi Postpartum.....	53
C. Identifikasi dan Skrining Depresi Postpartum Berbasis Bukti.....	54
D. Strategi Intervensi Psikologis Berbasis Bukti.....	57
E. Terapi Farmakologis dalam Manajemen Depresi Postpartum.....	59
F. Pendekatan Non-Farmakologis Tambahan dalam Manajemen Depresi Postpartum.....	61
G. Peran Keluarga dan Dukungan Sosial Berbasis Bukti dalam Manajemen Depresi Postpartum.....	64
H. Tantangan dalam Implementasi Manajemen Depresi Postpartum Berbasis Bukti.....	66
I. Solusi dan Rekomendasi Implementasi Manajemen Berbasis Bukti.....	69
J. Simpulan.....	71
K. Referensi	72
L. Glosarium	73
CHAPTER 4 PERAN BIDAN DALAM MENDUKUNG KESEHATAN MENTAL KELUARGA	75
Aminah, S.S.T., M.Kes.	75
A. Pendahuluan/Prolog	75
B. Peran Bidan Dalam Mendukung Kesehatan Mental Keluarga	77
C. Tantangan dalam Pelaksanaan.....	78
D. Strategi Penguatan Peran Bidan	78
E. Simpulan.....	78
F. Referensi	79
G. Glosarium	80
CHAPTER 5 STRATEGI KEBIJAKAN KESEHATAN MENTAL PEREMPUAN DI INDONESIA	83
Karolin Adhisty, S.Kep., Ns., M.Kep.	83
A. Pendahuluan/Prolog	83
B. Kerangka Hukum dan Kebijakan Nasional	85
C. Strategi Promotif dan Preventif.....	88
D. Strategi Kuratif dan Rehabilitatif.....	91

E. Peran Lintas Sektor dan Kolaborasi	94
F. Pendekatan Berbasis Gender dan Budaya.....	97
G. Tantangan Implementasi Kebijakan	99
H. Inovasi dan Teknologi dalam Kebijakan Kesehatan Mental	102
I. Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Masa Depan	105
J. Simpulan.....	108
K. Referensi	110
L. Glosarium	112
PROFIL PENULIS	117

CHAPTER 1

PENTINGNYA KESEHATAN MENTAL DALAM ASUHAN KEBIDANAN

Stevani Basuki Putri, S.Tr.Keb., M.Tr.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Kesehatan mental merupakan sebuah kondisi kesejahteraan psikologis, emosional, serta sosial seseorang, yang memungkinkan individu untuk menyadari potensi dirinya, mampu mengelola tekanan hidup sehari-hari, bekerja secara produktif, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi lingkungannya. Dalam konteks kebidanan, kesehatan mental memiliki makna khusus yang berhubungan erat dengan pengalaman dan kondisi yang dialami seorang perempuan selama masa kehamilan, persalinan, hingga periode nifas atau setelah melahirkan. Proses kehamilan dan kelahiran bayi merupakan masa transisi yang kompleks, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional dan psikologis. Oleh karena itu, kesehatan mental dalam praktik kebidanan menjadi perhatian penting yang harus diperhatikan dengan serius.

Dalam dunia kebidanan, kesehatan mental tidak hanya mencakup kesejahteraan emosional seorang ibu secara pribadi, tetapi juga mencakup keseimbangan emosional dan psikologis yang secara langsung atau tidak langsung dapat berdampak pada kualitas kehidupan ibu dan perkembangan bayi yang dikandungnya. Banyak studi dan penelitian menunjukkan bahwa kesehatan mental ibu selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas sangat menentukan keberhasilan dan kualitas kehidupan ibu dan anak di masa mendatang. Jika kondisi kesehatan mental ibu terjaga dengan baik, maka kemungkinan besar ibu akan menjalani kehamilan dengan lebih sehat dan tenang, mampu menghadapi tantangan yang mungkin muncul selama kehamilan maupun setelah kelahiran bayi, serta lebih siap secara mental dalam merawat dan membesarkan anaknya.

Sebaliknya, gangguan kesehatan mental yang dialami ibu selama periode tersebut, seperti kecemasan, depresi, atau stres berlebihan, dapat membawa dampak negatif terhadap kehamilan itu sendiri, proses persalinan, kondisi kesehatan fisik ibu setelah melahirkan, dan tumbuh kembang bayi secara umum. Misalnya, ibu hamil yang mengalami stres kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap kelahiran prematur atau berat bayi lahir rendah. Selain itu, gangguan mental seperti depresi postpartum (pasca melahirkan) juga sangat berbahaya, karena dapat

mempengaruhi kualitas hubungan antara ibu dan bayi, yang pada akhirnya berdampak pada perkembangan emosional, kognitif, serta sosial anak secara jangka panjang.

Tidak hanya sampai di situ, kaitan antara kesehatan mental ibu dengan kesehatan fisik juga sangat erat. Ibu yang mengalami gangguan kesehatan mental cenderung memiliki risiko yang lebih tinggi terhadap berbagai masalah kesehatan fisik, seperti hipertensi selama kehamilan (preeklampsia), diabetes gestasional, hingga masalah pada sistem kekebalan tubuh yang menurunkan daya tahan tubuh ibu terhadap penyakit. Hal ini terjadi karena kondisi psikologis yang buruk sering kali memicu berbagai perubahan hormonal serta gangguan sistem fisiologis dalam tubuh, yang selanjutnya berkontribusi terhadap berbagai komplikasi kesehatan yang lebih serius.

Dengan demikian, sangat jelas bahwa kesehatan mental dalam konteks kebidanan tidak hanya sebatas masalah emosional semata, melainkan juga memiliki hubungan yang erat dengan kesehatan fisik dan kualitas hidup ibu maupun bayi yang dilahirkannya. Oleh sebab itu, perhatian terhadap aspek kesehatan mental dalam praktik kebidanan menjadi sebuah kewajiban dan tanggung jawab besar bagi para tenaga kesehatan, khususnya bidan, yang berperan langsung dalam memberikan asuhan kepada ibu hamil hingga masa pasca persalinan. Bidan memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa ibu hamil dan ibu nifas mendapatkan pendampingan psikososial yang tepat, deteksi dini terhadap masalah kesehatan mental, serta intervensi yang cepat dan efektif guna mencegah dampak yang lebih luas dan kompleks terhadap kesehatan ibu dan anak.

memahami kesehatan mental dalam konteks kebidanan bukan hanya tentang mengetahui apa itu kesehatan mental, tetapi lebih kepada menyadari peran vitalnya dalam menciptakan kondisi kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang sehat, aman, nyaman, serta berkelanjutan bagi ibu, bayi, dan keluarga secara umum. Dengan perhatian yang memadai terhadap aspek kesehatan mental, diharapkan akan tercipta lingkungan yang mendukung penuh kesejahteraan ibu dan anak, serta mendorong tumbuhnya generasi yang sehat secara fisik, mental, dan emosional di masa depan.

B. Hubungan Kesehatan Mental dan Kehamilan

Kesehatan mental seorang ibu memiliki hubungan yang erat dan timbal balik dengan kondisi kehamilan yang sedang dijalannya. Kondisi kesehatan mental yang optimal sangat berkontribusi terhadap kelancaran proses kehamilan secara keseluruhan, mulai dari tahap awal konsepsi hingga menjelang proses persalinan. Sebaliknya, apabila seorang ibu mengalami gangguan kesehatan mental seperti

stres, kecemasan, atau bahkan depresi selama kehamilan, hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap dirinya maupun janin yang sedang dikandung.

Dalam kondisi normal, kehamilan adalah suatu peristiwa yang membahagiakan sekaligus penuh tantangan bagi seorang perempuan. Banyak perubahan yang dialami oleh ibu, baik perubahan fisik, psikologis, maupun emosional. Pada tahap ini, kondisi kesehatan mental yang stabil dan positif akan membantu ibu beradaptasi dengan berbagai perubahan yang muncul selama masa kehamilan. Ibu yang secara mental sehat cenderung lebih mampu mengelola stres, mampu berpikir positif, dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan kehamilan, baik tantangan fisik maupun emosional.

Secara fisiologis, kondisi kesehatan mental yang baik akan memberikan pengaruh positif terhadap keseimbangan hormonal dalam tubuh ibu hamil. Keseimbangan hormonal ini penting untuk menjaga kondisi fisik ibu agar tetap sehat dan stabil, sehingga proses pertumbuhan janin dalam rahim dapat berjalan optimal. Selain itu, ibu yang memiliki kesehatan mental yang baik biasanya akan menjaga pola hidup yang lebih sehat, termasuk pola makan bergizi seimbang, istirahat yang cukup, serta rutin melakukan aktivitas fisik yang disarankan selama kehamilan. Semua faktor tersebut secara kolektif akan sangat mendukung kesehatan ibu serta menciptakan lingkungan rahim yang optimal bagi janin untuk tumbuh dan berkembang secara maksimal.

Sebaliknya, kondisi kesehatan mental yang buruk seperti stres kronis, kecemasan berlebihan, atau depresi selama masa kehamilan tidak boleh dianggap remeh, karena memiliki dampak yang signifikan terhadap kehamilan itu sendiri. Ibu hamil yang mengalami gangguan kesehatan mental memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami berbagai komplikasi selama kehamilan, seperti preeklampsia (tekanan darah tinggi selama kehamilan), diabetes gestasional, kelahiran prematur, atau berat badan bayi lahir rendah. Hal ini terjadi karena gangguan mental yang dialami ibu dapat memicu produksi hormon stres seperti kortisol secara berlebihan, yang apabila terjadi dalam waktu lama dapat menyebabkan gangguan pada plasenta serta aliran darah ke janin.

Gangguan kesehatan mental selama kehamilan tidak hanya memengaruhi kondisi fisik ibu, tetapi juga berdampak langsung pada perkembangan janin. Misalnya, stres berkepanjangan yang dialami ibu dapat menyebabkan bayi yang dikandung berisiko lebih tinggi mengalami hambatan pertumbuhan intrauterin (Intrauterine Growth Restriction/IUGR). Kondisi ini terjadi karena plasenta yang mengalami gangguan akibat hormon stres tidak mampu memberikan nutrisi dan

oksigen secara optimal kepada janin, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan dan perkembangan organ janin.

Selain dampak pada pertumbuhan fisik janin, gangguan kesehatan mental ibu juga mempengaruhi aspek perkembangan saraf dan otak janin. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa janin dari ibu yang mengalami stres berat atau kecemasan tinggi selama kehamilan cenderung memiliki perkembangan sistem saraf yang lebih sensitif, serta rentan mengalami gangguan perilaku atau masalah emosional di kemudian hari. Gangguan tersebut antara lain dapat berupa gangguan tidur, kesulitan mengontrol emosi, hiperaktif, atau bahkan peningkatan risiko mengalami kecemasan dan depresi pada masa anak-anak hingga dewasa nanti.

Selain itu, depresi atau kecemasan ibu selama kehamilan juga dapat menyebabkan perubahan dalam aktivitas janin di dalam rahim. Penelitian menunjukkan bahwa janin yang terpapar kondisi stres dari ibu cenderung menunjukkan tingkat aktivitas yang berbeda dibandingkan janin yang ibunya memiliki kondisi mental yang baik. Aktivitas janin yang berlebihan atau terlalu pasif bisa menjadi tanda adanya stres yang diteruskan melalui berbagai mekanisme fisiologis ibu kepada janin. Jika kondisi ini terus berlangsung, perkembangan janin secara umum juga bisa terganggu, sehingga risiko komplikasi dalam kehamilan menjadi semakin besar.

Dalam konteks jangka panjang, janin yang mengalami paparan stres kronis dari ibunya selama masa kehamilan memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami masalah kesehatan di kemudian hari, termasuk penyakit kardiovaskular, gangguan metabolisme, atau gangguan sistem imun. Hal ini disebabkan oleh adaptasi janin terhadap lingkungan intrauterin yang kurang optimal, yang pada akhirnya mengubah cara kerja fisiologis tubuhnya dalam jangka panjang.

Mengingat begitu besarnya dampak dari gangguan kesehatan mental ibu terhadap proses kehamilan dan perkembangan janin, maka perhatian terhadap aspek kesehatan mental dalam asuhan kebidanan perlu diberikan secara khusus. Bidan dan tenaga kesehatan lainnya harus secara aktif melakukan deteksi dini terhadap gangguan kesehatan mental yang mungkin dialami oleh ibu hamil, serta memberikan pendampingan dan intervensi yang tepat guna mencegah atau meminimalisasi dampak negatif terhadap ibu dan janinnya. Dukungan psikososial, konseling yang memadai, serta edukasi kepada ibu dan keluarganya merupakan bagian penting yang harus terintegrasi dalam pelayanan kebidanan, guna memastikan bahwa kesehatan mental ibu selama kehamilan tetap terjaga dengan baik demi kelahiran generasi yang sehat, baik secara fisik maupun mental.

C. Gangguan Mental yang Umum Dialami Ibu Hamil dan Nifas

Selama masa kehamilan hingga masa nifas, ibu mengalami berbagai perubahan yang kompleks baik secara fisik, emosional, maupun psikologis. Perubahan ini sering kali menjadi pemicu munculnya berbagai gangguan kesehatan mental yang umum dialami oleh ibu hamil maupun ibu dalam masa nifas. Gangguan mental yang paling sering muncul dalam periode ini antara lain adalah depresi dan kecemasan selama kehamilan, baby blues dan depresi postpartum, serta gangguan kecemasan postpartum. Pemahaman mendalam mengenai berbagai gangguan mental tersebut sangat penting agar dapat dideteksi secara dini dan mendapat intervensi yang tepat demi keselamatan ibu dan bayi.

Depresi dan kecemasan selama masa kehamilan (prenatal) merupakan kondisi yang sering ditemui pada ibu hamil. Kondisi ini ditandai dengan perasaan sedih, cemas berlebihan, kelelahan, perasaan tidak berharga, hilangnya minat terhadap aktivitas sehari-hari, gangguan tidur, dan bahkan dalam beberapa kasus dapat memunculkan pikiran negatif yang berkaitan dengan kondisi diri maupun janin yang sedang dikandung. Depresi prenatal dapat muncul pada setiap trimester kehamilan dan sering dipicu oleh beberapa faktor seperti perubahan hormon yang signifikan, riwayat gangguan mental sebelumnya, stres yang tinggi akibat kehamilan yang tidak direncanakan atau masalah dalam hubungan keluarga, serta tekanan sosial ekonomi.

Selain depresi, kecemasan selama kehamilan juga sangat umum terjadi. Ibu hamil yang mengalami kecemasan berlebihan sering merasa khawatir yang tidak proporsional terkait kondisi janinnya, proses persalinan yang akan dijalani, hingga ketidakpastian terhadap masa depan pasca persalinan. Kecemasan ini dapat memanifestasikan gejala fisik seperti jantung berdebar, pusing, gangguan tidur, dan perubahan nafsu makan yang dapat berpengaruh buruk terhadap kesehatan ibu maupun janin. Kondisi kecemasan yang berkepanjangan dapat meningkatkan produksi hormon stres dalam tubuh ibu, yang kemudian mengganggu perkembangan janin, meningkatkan risiko kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah, hingga komplikasi persalinan lainnya.

Setelah proses persalinan, sebagian besar ibu juga berisiko mengalami gangguan mental yang disebut dengan baby blues atau sindrom kesedihan pascapersalinan. Baby blues merupakan kondisi psikologis yang umumnya muncul dalam waktu singkat setelah melahirkan, biasanya antara 2 hingga 7 hari pasca persalinan. Kondisi ini ditandai oleh perasaan sedih, mudah menangis tanpa alasan jelas, perubahan suasana hati yang cepat, perasaan cemas ringan, dan rasa lelah yang luar biasa. Baby blues dipicu oleh penurunan hormon estrogen dan progesteron secara drastis pasca melahirkan, serta stres akibat perubahan tanggung

jawab baru sebagai seorang ibu. Walaupun kondisi ini sering kali tidak memerlukan pengobatan khusus dan akan hilang dengan sendirinya dalam waktu sekitar 2 minggu, namun jika tidak teratasi dengan baik, kondisi ini bisa berkembang menjadi gangguan yang lebih serius seperti depresi postpartum.

Depresi postpartum merupakan bentuk gangguan mental yang lebih berat dibandingkan baby blues dan memerlukan perhatian serius serta penanganan yang tepat. Depresi postpartum dapat muncul dalam rentang waktu beberapa minggu hingga beberapa bulan pasca persalinan, bahkan dalam beberapa kasus bisa muncul hingga satu tahun setelah melahirkan. Gejalanya mencakup perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat terhadap bayi, perasaan tidak mampu merawat bayi dengan baik, kelelahan ekstrim yang tidak kunjung membaik, gangguan pola tidur dan pola makan, perasaan bersalah yang terus menerus, hingga pikiran atau bahkan tindakan menyakiti diri sendiri atau bayinya. Penyebab utama depresi postpartum adalah kombinasi dari berbagai faktor seperti perubahan hormon secara ekstrem, kelelahan fisik pasca melahirkan, kurangnya dukungan emosional dari lingkungan sekitar, serta riwayat gangguan mental sebelumnya.

Depresi postpartum memiliki dampak yang sangat besar terhadap ibu maupun bayi jika tidak segera ditangani. Ibu yang mengalami depresi postpartum cenderung memiliki interaksi emosional yang kurang optimal dengan bayi, sehingga hubungan emosional (bonding) antara ibu dan bayi sulit terbentuk. Kondisi ini juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang bayi dalam jangka panjang, seperti gangguan perkembangan sosial-emosional, keterlambatan bicara, hingga masalah perilaku di kemudian hari. Oleh karena itu, deteksi dini dan penanganan cepat sangat diperlukan, yang meliputi dukungan psikologis, konseling, hingga terapi obat pada kasus-kasus yang lebih berat.

Gangguan kecemasan postpartum adalah kondisi mental lain yang umum dialami ibu setelah melahirkan, namun sering kali tidak mendapatkan perhatian yang cukup dibandingkan dengan depresi postpartum. Kondisi ini ditandai oleh kekhawatiran yang berlebihan terhadap keselamatan bayi, ketakutan irasional tentang kemampuan merawat bayi, serangan panik, hingga munculnya pikiran obsesif tentang bahaya atau penyakit yang mungkin menimpa bayi. Gejala-gejala fisik seperti jantung berdebar, gangguan tidur, sulit berkonsentrasi, hingga gangguan pencernaan juga sering menyertai kondisi ini. Gangguan kecemasan postpartum biasanya disebabkan oleh kombinasi perubahan hormon, tanggung jawab baru sebagai ibu, kurangnya dukungan keluarga, serta riwayat kecemasan sebelumnya.

Ibu yang mengalami gangguan kecemasan postpartum cenderung sangat protektif terhadap bayi, namun dalam kondisi ekstrem justru bisa mengalami

kesulitan dalam merawat bayi secara efektif karena terbebani oleh kecemasannya sendiri. Kondisi ini jika tidak mendapat perhatian serius akan memperburuk kondisi mental ibu, bahkan bisa berkembang menjadi gangguan depresi postpartum atau gangguan mental lainnya yang lebih berat. Oleh karena itu, intervensi yang tepat seperti konseling, terapi perilaku kognitif (CBT), dukungan sosial dari keluarga, serta pendampingan profesional dari bidan atau tenaga kesehatan sangat penting untuk mengatasi gangguan kecemasan postpartum.

gangguan mental seperti depresi, kecemasan prenatal maupun postpartum, baby blues, serta gangguan kecemasan postpartum adalah tantangan kesehatan mental yang serius bagi ibu hamil dan ibu nifas. Oleh karena itu, perhatian khusus serta pendekatan holistik dalam asuhan kebidanan menjadi sangat penting, tidak hanya untuk menjaga kesehatan mental ibu tetapi juga untuk menjamin tumbuh kembang bayi secara optimal dan menciptakan hubungan yang sehat antara ibu dan bayinya. Dukungan dari tenaga kesehatan, keluarga, serta lingkungan sekitar merupakan kunci utama dalam mencegah dan mengatasi gangguan mental pada masa kehamilan dan nifas secara efektif.

D. Deteksi Dini dan Penilaian Kesehatan Mental dalam Kebidanan

Deteksi dini gangguan kesehatan mental pada ibu hamil dan ibu dalam masa nifas merupakan salah satu aspek penting dalam asuhan kebidanan yang bersifat preventif. Mengingat dampak signifikan gangguan mental terhadap kondisi ibu dan bayi, maka identifikasi sedini mungkin terhadap gejala gangguan mental menjadi langkah krusial yang perlu diperhatikan dalam setiap pelayanan kebidanan. Semakin awal gangguan mental dapat dikenali, semakin cepat pula intervensi dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya komplikasi lebih lanjut yang berdampak buruk terhadap kesehatan ibu maupun bayi.

Deteksi dini gangguan mental memiliki beberapa manfaat yang sangat penting dalam konteks asuhan kebidanan. Pertama, melalui identifikasi dini, tenaga kesehatan seperti bidan, perawat, atau dokter mampu merancang rencana asuhan yang bersifat holistik dan tepat sasaran untuk ibu yang mengalami risiko gangguan mental. Kedua, deteksi dini juga memungkinkan adanya edukasi dan pemberian informasi yang tepat kepada ibu dan keluarga terkait tanda-tanda awal gangguan mental, sehingga mereka dapat lebih waspada dan responsif terhadap perubahan emosional maupun psikologis yang terjadi selama kehamilan dan masa nifas. Ketiga, deteksi dini gangguan mental membantu dalam mencegah perburukan kondisi kesehatan mental ibu yang lebih berat, seperti depresi postpartum yang berkepanjangan, kecemasan kronis, bahkan kondisi psikotik yang dapat mengancam keselamatan ibu dan bayi.

Dalam praktik kebidanan, deteksi dini gangguan mental dilakukan dengan menggunakan berbagai alat ukur dan metode penilaian kesehatan mental yang sudah terstandarisasi. Alat ukur ini biasanya berupa instrumen kuesioner yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya secara klinis untuk digunakan pada populasi ibu hamil maupun nifas. Salah satu alat ukur yang sering digunakan adalah Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), sebuah instrumen berbentuk kuesioner sederhana yang dirancang khusus untuk mengidentifikasi adanya gejala depresi selama masa kehamilan maupun setelah persalinan. EPDS terdiri dari sepuluh pertanyaan yang menggali perasaan ibu selama tujuh hari terakhir, meliputi suasana hati, rasa cemas, perasaan bersalah, pola tidur, hingga adanya pikiran-pikiran yang mengarah kepada tindakan menyakiti diri sendiri. Penggunaan EPDS relatif mudah, efisien, dan dapat digunakan secara rutin selama kunjungan antenatal maupun postnatal, sehingga gangguan mental dapat diidentifikasi secara tepat waktu.

Selain EPDS, instrumen lain seperti Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS-21) juga sering digunakan dalam praktik kebidanan. DASS-21 merupakan alat ukur yang dapat mengidentifikasi tiga aspek kesehatan mental secara sekaligus yaitu depresi, kecemasan, dan stres yang dialami ibu. Instrumen ini terdiri dari 21 pertanyaan yang mampu mengukur tingkat keparahan gejala yang dialami ibu dalam kurun waktu satu minggu terakhir. Keuntungan utama DASS-21 adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi tidak hanya depresi tetapi juga kecemasan dan stres, yang merupakan gangguan mental umum yang dialami ibu hamil dan nifas. Dengan menggunakan DASS-21, tenaga kesehatan dapat dengan mudah mendeteksi gangguan mental yang kompleks dan memberikan intervensi yang tepat sesuai kebutuhan.

Selain penggunaan alat ukur terstandarisasi, metode penilaian kesehatan mental secara kualitatif juga penting untuk diterapkan oleh tenaga kebidanan. Penilaian kualitatif dilakukan melalui wawancara klinis mendalam yang mencakup observasi perilaku, ekspresi emosi, serta interaksi ibu dengan lingkungannya. Wawancara ini bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai latar belakang psikososial, riwayat kesehatan mental sebelumnya, dukungan sosial yang diterima, serta kondisi keluarga dan rumah tangga ibu. Melalui wawancara yang dilakukan secara empati, penuh perhatian, dan tidak menghakimi, bidan dapat membangun hubungan kepercayaan dengan ibu, sehingga memudahkan ibu untuk mengungkapkan perasaan maupun masalah yang sedang dihadapinya secara terbuka. Informasi yang didapat dari wawancara ini menjadi pelengkap yang sangat berharga dalam melakukan penilaian kondisi mental ibu secara komprehensif.

Lebih lanjut, bidan atau tenaga kesehatan juga harus memahami tanda-tanda klinis yang menunjukkan kemungkinan adanya gangguan mental pada ibu.

Beberapa tanda umum yang perlu diamati antara lain perubahan suasana hati yang drastis, ekspresi wajah yang sedih atau gelisah secara terus menerus, isolasi sosial, gangguan tidur yang signifikan, nafsu makan yang berubah drastis, kesulitan merawat diri sendiri atau bayinya, serta gejala-gejala fisik yang tidak memiliki penjelasan medis yang jelas, seperti sakit kepala kronis atau gangguan pencernaan berulang. Dengan kepekaan tinggi terhadap tanda-tanda ini, tenaga kesehatan dapat melakukan penilaian lanjutan dengan menggunakan alat ukur yang telah disebutkan sebelumnya atau merujuk ibu ke profesional kesehatan mental seperti psikolog atau psikiater jika diperlukan.

Implementasi deteksi dini dan penilaian kesehatan mental dalam kebidanan harus didukung dengan pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan secara rutin. Bidan dan tenaga kesehatan lainnya perlu dibekali dengan pengetahuan terkini mengenai tanda-tanda gangguan mental, teknik komunikasi terapeutik yang efektif, serta keterampilan menggunakan berbagai alat ukur kesehatan mental dengan benar dan tepat waktu. Dengan demikian, deteksi dini dan penilaian kesehatan mental tidak hanya sekadar formalitas, tetapi menjadi bagian integral dalam setiap layanan kebidanan yang diberikan kepada ibu hamil maupun ibu dalam masa nifas.

E. Peran Bidan dalam Dukungan Kesehatan Mental

Bidan merupakan tenaga kesehatan terdepan yang memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan kesehatan mental kepada ibu hamil, ibu dalam masa nifas, serta keluarga secara keseluruhan. Peran bidan tidak terbatas pada asuhan fisik semata, melainkan mencakup perhatian terhadap aspek emosional, psikologis, sosial, hingga spiritual yang mempengaruhi kondisi mental ibu. Sebagai tenaga kesehatan yang paling dekat dan paling sering berinteraksi dengan ibu, bidan memiliki tanggung jawab penting dalam mengidentifikasi gangguan mental sejak dini, memberikan edukasi, memberikan intervensi awal, serta menjadi penghubung antara ibu dengan layanan kesehatan mental yang lebih khusus jika dibutuhkan.

Dalam konteks tanggung jawab, bidan harus mampu mengenali tanda-tanda gangguan mental seperti depresi, kecemasan, stres, maupun gangguan emosional lainnya yang kerap dialami ibu hamil maupun ibu pasca persalinan. Dengan pendekatan yang bersifat holistik, bidan diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi ibu untuk berbicara secara terbuka mengenai perasaan dan kondisinya. Tugas utama bidan terkait kesehatan mental mencakup deteksi dini gangguan mental melalui observasi klinis dan wawancara empati, memberikan edukasi kesehatan mental kepada ibu dan keluarga, memberikan dukungan emosional secara langsung selama masa kehamilan,

persalinan, hingga masa nifas, serta melakukan rujukan ke tenaga profesional kesehatan mental jika situasi ibu memerlukan penanganan khusus.

Selain itu, bidan memiliki tanggung jawab penting dalam mengedukasi ibu dan keluarganya tentang pentingnya kesehatan mental selama kehamilan dan masa nifas. Edukasi ini meliputi pemahaman tentang perubahan psikologis dan emosional yang wajar selama kehamilan, tanda-tanda awal gangguan mental seperti baby blues, depresi postpartum, kecemasan berlebihan, serta cara-cara sederhana untuk mengatasinya di rumah. Dengan edukasi yang baik, ibu dan keluarga akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan emosional yang muncul selama masa perinatal, sehingga risiko gangguan mental yang berat dapat diminimalkan secara signifikan.

Strategi intervensi yang dilakukan bidan dalam mendukung kesehatan mental ibu mencakup berbagai pendekatan yang bersifat preventif, promotif, kuratif, hingga rehabilitatif. Strategi preventif meliputi upaya edukasi dan konseling rutin untuk memberikan pemahaman dasar tentang perubahan emosi selama masa kehamilan dan nifas. Dalam intervensi ini, bidan harus mampu menciptakan komunikasi terbuka dengan ibu, menunjukkan empati, serta mendorong ibu untuk mengungkapkan segala keluhannya tanpa takut dihakimi. Dengan komunikasi yang efektif, ibu merasa didengarkan, dipahami, serta merasa didukung secara emosional, sehingga perasaan cemas atau depresi ringan dapat dicegah atau setidaknya dikelola sejak awal.

Intervensi promotif dilakukan dengan cara memperkuat jaringan dukungan sosial ibu melalui edukasi kepada keluarga terdekat, termasuk pasangan, orang tua, maupun anggota keluarga lain yang terlibat langsung dalam proses perawatan selama kehamilan dan pasca persalinan. Bidan perlu menginformasikan kepada keluarga tentang pentingnya memberikan dukungan emosional yang kuat, baik secara fisik maupun psikologis, serta memahami bahwa kesehatan mental ibu adalah faktor krusial dalam menjaga kesehatan ibu dan bayi secara keseluruhan. Dengan demikian, keluarga mampu memberikan dukungan praktis seperti membantu tugas sehari-hari, memastikan ibu memiliki waktu istirahat yang cukup, serta secara aktif membantu mengurangi stres yang dialami ibu.

Pada level intervensi kuratif, bidan memiliki peran penting dalam melakukan tindakan awal atau pertolongan pertama psikologis (psychological first aid) bagi ibu yang mengalami tanda-tanda gangguan mental seperti kecemasan tinggi atau depresi ringan hingga sedang. Tindakan ini dapat berupa sesi konseling pendek yang bersifat suportif, relaksasi sederhana, teknik napas dalam, ataupun praktik mindfulness sederhana yang bertujuan membantu ibu meredakan kecemasan, stres, atau perasaan negatif yang dialaminya. Melalui intervensi ini, bidan tidak hanya berusaha membantu ibu secara emosional, tetapi juga memberikan pemahaman

kepada ibu tentang perlunya menjaga keseimbangan emosional dalam menghadapi berbagai tantangan kehamilan dan masa nifas.

Apabila gangguan mental yang dialami ibu tergolong serius atau kompleks, maka intervensi rehabilitatif menjadi strategi berikutnya yang penting untuk dilakukan. Pada tahap ini, bidan berperan sebagai tenaga kesehatan yang menghubungkan ibu dengan sumber bantuan profesional yang lebih spesifik, seperti psikolog atau psikiater. Bidan harus mampu mengenali batas kemampuannya dalam memberikan intervensi psikologis, dan segera merujuk ibu kepada tenaga kesehatan mental yang memiliki keahlian lebih tinggi. Rujukan yang tepat waktu akan mempercepat ibu mendapatkan penanganan yang sesuai, sehingga risiko komplikasi serius dari gangguan mental tersebut dapat dicegah.

Lebih jauh lagi, peran bidan dalam dukungan kesehatan mental juga mencakup monitoring jangka panjang terhadap kondisi mental ibu. Hal ini terutama penting dilakukan pada ibu-ibu yang telah mengalami gangguan mental selama masa kehamilan atau nifas sebelumnya, ataupun pada ibu yang memiliki riwayat gangguan mental sebelumnya. Dengan memantau kondisi ibu secara berkala, bidan dapat dengan cepat mengidentifikasi kemungkinan kambuhnya gangguan mental, memberikan intervensi dini, serta menjaga agar kondisi mental ibu tetap stabil dan terjaga dengan baik dalam jangka panjang.

Selain berbagai strategi yang telah dijelaskan, penting juga bagi bidan untuk memiliki keterampilan komunikasi terapeutik yang tinggi. Komunikasi terapeutik melibatkan kemampuan bidan untuk mendengarkan secara aktif, memahami perasaan dan pikiran ibu, serta memberikan respons yang empati dan mendukung tanpa adanya sikap menghakimi. Dengan komunikasi terapeutik yang baik, hubungan antara bidan dan ibu menjadi lebih kuat, sehingga intervensi kesehatan mental yang diberikan akan lebih efektif dan tepat sasaran.

Secara keseluruhan, peran bidan dalam mendukung kesehatan mental sangatlah krusial dalam konteks asuhan kebidanan. Dengan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal serta menerapkan berbagai strategi intervensi yang tepat, bidan tidak hanya membantu ibu melewati masa-masa sulit secara emosional, tetapi juga memberikan kontribusi penting dalam menjaga kesehatan fisik dan mental ibu serta bayi secara menyeluruh. Dalam menjalankan peran ini, bidan perlu didukung oleh pelatihan berkelanjutan, pengetahuan terbaru tentang kesehatan mental maternal, serta sistem rujukan yang efektif dan terintegrasi. Dengan begitu, dukungan kesehatan mental dalam asuhan kebidanan dapat berjalan secara maksimal dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi ibu, bayi, keluarga, serta komunitas secara luas.

F. Pendampingan Psikososial dalam Asuhan Kebidanan

Pendampingan psikososial merupakan aspek integral dalam asuhan kebidanan yang bertujuan memberikan dukungan emosional dan sosial kepada ibu hamil, ibu dalam masa nifas, serta keluarganya. Pendampingan ini menggunakan pendekatan holistik yang tidak hanya memperhatikan kondisi fisik ibu, namun juga secara mendalam mengakomodasi aspek psikologis, emosional, sosial, bahkan spiritual. Melalui pendekatan ini, diharapkan ibu hamil dan postpartum dapat menghadapi berbagai tantangan yang muncul dalam periode kehamilan maupun masa nifas dengan lebih baik, sehingga meningkatkan kesejahteraan mental dan kualitas hidup ibu secara keseluruhan.

Pendekatan psikososial dalam perawatan ibu hamil dan postpartum dimulai dari menciptakan hubungan interpersonal yang kuat dan positif antara bidan dengan ibu. Hubungan interpersonal yang baik merupakan dasar dari keberhasilan pendampingan psikososial. Hubungan ini dibangun melalui sikap empati, penerimaan tanpa syarat, serta komunikasi yang efektif, sehingga ibu merasa dihargai, dipahami, dan tidak sendirian dalam menghadapi tantangan emosionalnya. Bidan juga harus mampu mengidentifikasi berbagai kebutuhan emosional yang spesifik dari setiap ibu, karena setiap individu memiliki latar belakang, pengalaman, serta persepsi yang berbeda terhadap kehamilan dan persalinan.

Dalam pendekatan psikososial ini, bidan memainkan peran kunci dalam membantu ibu mengenali dan memahami berbagai perubahan emosional serta sosial yang dialami selama masa kehamilan dan postpartum. Hal ini meliputi memberikan edukasi secara aktif mengenai kondisi-kondisi emosional yang umum terjadi seperti kecemasan, stres, rasa takut menghadapi persalinan, serta perubahan suasana hati yang fluktuatif. Bidan perlu mengedukasi ibu bahwa perubahan tersebut adalah normal, namun juga perlu memberikan pemahaman mengenai kapan perubahan emosional tersebut sudah melewati batas normal dan membutuhkan bantuan tambahan.

Selain memberikan edukasi, pendekatan psikososial juga mencakup berbagai bentuk intervensi dukungan sosial yang dapat melibatkan pasangan, keluarga besar, dan komunitas sekitar ibu. Dengan melibatkan keluarga dan pasangan dalam proses pendampingan, bidan tidak hanya memberikan penguatan bagi ibu tetapi juga memperluas jaringan dukungan ibu, yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan emosional dan mentalnya. Dukungan sosial ini juga berfungsi sebagai buffer atau penyangga emosional yang membantu ibu mengelola stres dengan lebih baik, meningkatkan rasa percaya diri, serta mengurangi perasaan cemas dan isolasi yang kerap dialami selama masa kehamilan maupun masa nifas.

Salah satu komponen penting dalam pendampingan psikososial adalah penggunaan teknik-teknik konseling yang efektif dalam pelayanan kebidanan. Konseling dalam kebidanan merupakan interaksi dua arah yang berfokus pada membantu ibu mengatasi berbagai persoalan emosional, psikologis, dan sosial yang dialaminya. Teknik konseling efektif yang sering diterapkan dalam praktik kebidanan antara lain teknik mendengarkan aktif, empati reflektif, pertanyaan terbuka, serta pendekatan pemecahan masalah secara kolaboratif.

Teknik mendengarkan aktif merupakan langkah awal yang paling dasar dan penting dalam proses konseling. Dalam teknik ini, bidan perlu menunjukkan perhatian penuh terhadap apa yang disampaikan ibu, melalui kontak mata, ekspresi wajah yang menunjukkan ketertarikan, serta bahasa tubuh yang terbuka. Mendengarkan aktif membantu ibu merasa bahwa perasaannya dihargai, diakui, dan bahwa ia memiliki ruang yang aman untuk mengekspresikan perasaan tanpa rasa takut dihakimi.

Selanjutnya, empati reflektif adalah teknik konseling di mana bidan mencoba memahami dan merefleksikan kembali apa yang dirasakan ibu secara lebih dalam. Dengan teknik ini, bidan tidak hanya menunjukkan bahwa ia memahami perasaan ibu, tetapi juga membantu ibu untuk menyadari dan mengelola emosinya dengan lebih baik. Misalnya, ketika ibu menunjukkan kecemasan yang tinggi mengenai persalinan, bidan dapat menggunakan empati reflektif dengan mengatakan, "Saya memahami bahwa Ibu merasa khawatir tentang proses persalinan nanti, dan itu memang hal yang sangat wajar dirasakan oleh banyak ibu lain." Melalui refleksi ini, ibu merasa didukung secara emosional dan lebih nyaman dalam membuka diri lebih jauh tentang kekhawatirannya.

Selain itu, penggunaan pertanyaan terbuka dalam proses konseling sangat bermanfaat untuk menggali perasaan dan pikiran ibu secara lebih dalam dan komprehensif. Pertanyaan terbuka memungkinkan ibu untuk berbicara lebih luas mengenai berbagai aspek yang ia rasakan, tanpa merasa terbatas atau diarahkan secara sempit. Misalnya, bidan dapat mengajukan pertanyaan seperti, "Bisakah Ibu ceritakan apa yang paling membuat Ibu khawatir saat ini?" atau "Bagaimana Ibu menghadapi perubahan yang dirasakan dalam keluarga setelah kelahiran bayi?". Pertanyaan seperti ini memberikan kesempatan ibu untuk mengeksplorasi perasaan dan pikirannya secara lebih mendalam, sekaligus memungkinkan bidan untuk memahami permasalahan ibu secara lebih komprehensif.

Teknik konseling efektif berikutnya adalah pendekatan pemecahan masalah secara kolaboratif. Dalam pendekatan ini, bidan tidak langsung memberikan solusi kepada ibu, melainkan membantu ibu secara aktif mengidentifikasi pilihan solusi yang tersedia, mengevaluasi setiap pilihan tersebut, serta membantu ibu membuat

keputusan yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya sendiri. Teknik ini sangat efektif untuk meningkatkan rasa percaya diri ibu, memberdayakan ibu dalam mengambil keputusan terkait kesehatan dirinya dan bayinya, serta memberikan rasa kontrol yang positif terhadap situasi yang sedang dihadapinya.

Dalam praktiknya, konseling psikososial di bidang kebidanan juga sering melibatkan teknik relaksasi seperti latihan pernapasan dalam, mindfulness, atau relaksasi otot progresif yang bertujuan membantu ibu mengatasi kecemasan atau stres akut yang dirasakan. Teknik-teknik ini dapat diajarkan dan dipraktikkan secara sederhana dalam sesi konseling, sehingga ibu dapat mempraktikkan secara mandiri di rumah ketika merasakan kecemasan atau ketidaknyamanan emosional.

G. Studi Kasus: Dampak Dukungan Kesehatan Mental dalam Keberhasilan Kehamilan dan Persalinan

Studi kasus merupakan salah satu metode penting dalam memahami secara nyata dampak dari intervensi kesehatan mental dalam konteks kebidanan. Dengan menggunakan pendekatan ini, bidan dan tenaga kesehatan lainnya dapat mengevaluasi secara langsung bagaimana dukungan psikologis dapat berkontribusi secara signifikan terhadap hasil kehamilan dan persalinan, baik secara fisik maupun psikologis. Studi kasus berikut menggambarkan bagaimana penerapan intervensi kesehatan mental yang tepat mampu meningkatkan kesejahteraan ibu, mendukung perkembangan janin yang optimal, serta memastikan proses persalinan yang aman dan lancar.

Dalam kasus ini, kita mengambil contoh seorang ibu hamil bernama Andini (nama samaran), usia 27 tahun, yang sedang menjalani kehamilan pertamanya. Pada usia kehamilan sekitar 20 minggu, Andini mulai menunjukkan gejala kecemasan yang cukup serius. Ia mengeluhkan sulit tidur, sering merasa gelisah, mengalami palpitasi (detak jantung yang cepat), dan terus-menerus merasa khawatir tentang kesehatan janinnya. Kondisi tersebut semakin buruk karena kurangnya dukungan dari keluarga terdekat dan rasa isolasi sosial yang semakin meningkat akibat jarang berinteraksi dengan lingkungan luar.

Dalam kunjungan antenatal rutin, bidan yang merawat Andini mulai mengidentifikasi adanya risiko gangguan mental berupa kecemasan yang meningkat secara signifikan. Bidan lalu menggunakan instrumen penilaian kesehatan mental seperti Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) dan Generalized Anxiety Disorder-7 (GAD-7) untuk mengevaluasi tingkat keparahan kecemasan yang dialami Andini. Hasilnya menunjukkan bahwa Andini mengalami kecemasan yang berada di atas batas normal dan membutuhkan intervensi khusus untuk menghindari dampak negatif terhadap kehamilan serta janinnya.

Setelah mendapatkan hasil penilaian tersebut, bidan bersama tim kesehatan memutuskan untuk melakukan intervensi psikologis yang menyeluruh. Andini diberikan konseling psikososial secara rutin setiap minggu. Dalam sesi konseling ini, bidan menerapkan teknik-teknik konseling seperti mendengarkan aktif, empati reflektif, serta pendekatan pemecahan masalah secara kolaboratif. Bidan juga mengajarkan Andini berbagai teknik relaksasi seperti latihan pernapasan dalam, mindfulness, dan relaksasi otot progresif untuk mengelola kecemasan dan stres yang dialaminya. Selain itu, tim juga melibatkan pasangan Andini dalam beberapa sesi konseling agar pasangan dapat memahami kondisi emosional Andini dengan lebih baik serta memberikan dukungan emosional yang lebih efektif di rumah.

Setelah dua bulan mengikuti intervensi psikologis ini secara intensif, perubahan positif mulai terlihat secara nyata pada kondisi Andini. Ia melaporkan bahwa intensitas kecemasan yang ia rasakan menurun secara signifikan, gejala fisik seperti palpitasi juga mulai hilang, dan kualitas tidurnya membaik secara drastis. Lebih jauh lagi, melalui konseling, Andini mampu mengidentifikasi sumber utama kecemasannya, yang ternyata terkait erat dengan ketakutan terhadap proses persalinan serta perasaan tidak percaya diri untuk menjadi seorang ibu. Dengan bantuan bidan, Andini dapat secara perlahan membangun kepercayaan diri melalui informasi yang akurat tentang persalinan serta keterampilan praktis dalam merawat bayi baru lahir.

Selama periode akhir kehamilan, kondisi mental Andini terus stabil dan bahkan menunjukkan peningkatan kesejahteraan emosional. Dukungan psikologis yang diberikan tidak hanya meningkatkan rasa percaya diri dan kesiapan emosional Andini untuk menghadapi persalinan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap kondisi fisiknya. Tekanan darah dan kondisi fisik lainnya yang sebelumnya terpengaruh oleh stres, kini berada dalam batas normal, menciptakan kondisi ideal untuk pertumbuhan dan perkembangan janin.

Proses persalinan Andini pun berjalan lancar dan tanpa komplikasi berarti. Ia mampu melalui persalinan secara alami dengan bantuan bidan dan tim medis. Setelah persalinan, Andini melaporkan rasa percaya diri yang tinggi dalam merawat bayinya, serta merasa memiliki koneksi emosional yang kuat dengan sang bayi sejak awal kelahiran. Hal ini sangat kontras dengan kondisi psikologisnya sebelum intervensi dilakukan, di mana ia sempat merasa takut dan tidak yakin dapat menjalani peran sebagai seorang ibu dengan baik.

Analisis hasil intervensi psikologis dalam studi kasus ini menunjukkan bahwa pendekatan kesehatan mental dalam pelayanan kebidanan mampu menghasilkan dampak yang sangat positif, tidak hanya pada kesejahteraan mental ibu tetapi juga terhadap hasil fisik kehamilan dan persalinan. Dukungan psikologis mampu

mengurangi gejala kecemasan dan depresi secara signifikan, memperbaiki kondisi fisik yang terganggu akibat stres, serta membantu ibu membangun ketahanan emosional yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan selama kehamilan, persalinan, dan masa nifas.

Lebih jauh, studi kasus ini menegaskan pentingnya deteksi dini dan intervensi tepat waktu terhadap masalah kesehatan mental pada ibu hamil. Tanpa identifikasi dan intervensi dini, gangguan mental yang dialami Andini berpotensi memperburuk kesehatan fisiknya, meningkatkan risiko komplikasi pada janin, serta menyebabkan kesulitan emosional dan sosial setelah kelahiran bayi. Sebaliknya, dengan dukungan psikososial yang tepat, ibu mampu melalui masa kehamilan dan persalinan dengan lebih baik dan positif.

H. Tantangan dan Hambatan dalam Mengintegrasikan Kesehatan Mental ke dalam Praktik Kebidanan

Mengintegrasikan kesehatan mental dalam praktik kebidanan merupakan upaya yang sangat penting, namun pada kenyataannya, implementasi ini masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan di lapangan. Pemahaman terhadap tantangan-tantangan tersebut diperlukan agar tenaga kesehatan, khususnya bidan, dapat mengembangkan strategi yang efektif untuk mengatasi hambatan serta memberikan pelayanan kebidanan yang komprehensif dan menyeluruh.

Salah satu hambatan umum dalam pelaksanaan asuhan kesehatan mental di kebidanan adalah minimnya pemahaman dan kesadaran tenaga kesehatan mengenai pentingnya aspek psikologis dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Banyak bidan yang masih lebih fokus pada aspek fisik seperti pemantauan kehamilan, tanda-tanda vital, pemeriksaan laboratorium, serta aspek medis lain, sementara aspek kesehatan mental sering kali dianggap sebagai masalah sekunder. Akibatnya, gangguan mental pada ibu hamil atau nifas sering kali tidak terdeteksi secara dini, sehingga berpotensi menjadi lebih serius dan sulit ditangani.

Selain itu, hambatan lain yang signifikan adalah keterbatasan waktu dan beban kerja yang tinggi pada bidan. Dalam praktik sehari-hari, khususnya di wilayah dengan sumber daya terbatas, satu bidan sering kali harus menangani banyak pasien sekaligus, yang menyebabkan waktu untuk melakukan konseling psikososial secara mendalam menjadi sangat terbatas. Kondisi ini menyebabkan asuhan kesehatan mental yang diberikan tidak optimal, bahkan kadang terabaikan sama sekali.

Keterbatasan sumber daya juga menjadi hambatan besar dalam pelaksanaan asuhan kesehatan mental. Sumber daya ini tidak hanya berupa waktu atau tenaga manusia, tetapi juga mencakup fasilitas kesehatan yang belum mendukung,

kurangnya alat ukur atau instrumen deteksi gangguan mental, dan minimnya pelatihan atau pendidikan tambahan mengenai kesehatan mental bagi bidan. Akibatnya, banyak bidan tidak merasa percaya diri atau bahkan tidak memiliki keterampilan khusus dalam melakukan intervensi psikologis, sehingga penanganan gangguan mental pada ibu hamil dan nifas cenderung kurang maksimal.

Selain masalah internal, terdapat pula hambatan eksternal berupa stigma negatif di masyarakat terhadap gangguan mental. Di banyak tempat, ibu hamil atau nifas yang mengalami masalah mental seperti depresi atau kecemasan sering kali enggan untuk mengungkapkan kondisi emosionalnya karena takut dihakimi atau mendapat stigma negatif dari keluarga atau masyarakat. Hal ini menyebabkan banyak kasus gangguan mental yang sebenarnya bisa ditangani secara dini justru terlambat dideteksi, sehingga semakin sulit diatasi.

Untuk mengatasi tantangan dan hambatan tersebut, perlu adanya strategi yang komprehensif dan terintegrasi. Strategi pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran tenaga kesehatan tentang pentingnya kesehatan mental dalam kebidanan melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Pelatihan ini bisa meliputi pengenalan gangguan mental yang umum terjadi pada ibu hamil dan nifas, teknik-teknik konseling dasar, serta penggunaan alat ukur kesehatan mental. Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan ini, bidan akan merasa lebih percaya diri dan mampu memberikan intervensi kesehatan mental yang efektif.

Strategi berikutnya adalah advokasi kebijakan untuk menyediakan sumber daya dan infrastruktur yang memadai dalam pelayanan kebidanan. Upaya ini mencakup pengadaan alat ukur gangguan mental yang standar, peningkatan fasilitas konseling psikososial, dan penambahan tenaga kesehatan terlatih khususnya dalam aspek kesehatan mental. Pemerintah dan institusi terkait perlu terlibat aktif dalam memberikan dukungan kebijakan yang mendorong integrasi pelayanan kesehatan mental dalam kebidanan.

Selanjutnya, strategi yang tidak kalah penting adalah penguatan kolaborasi interprofesional antar tenaga kesehatan. Kolaborasi ini melibatkan bidan, dokter spesialis kandungan, dokter umum, psikolog, serta tenaga profesional kesehatan mental lainnya. Dengan pendekatan ini, tanggung jawab untuk deteksi dini dan penanganan gangguan mental tidak hanya terbebankan pada bidan saja, melainkan didukung oleh tim profesional yang lebih luas, sehingga memberikan hasil yang lebih efektif dan optimal.

Dalam menghadapi keterbatasan waktu, bidan bisa menggunakan strategi pendekatan berbasis komunitas, misalnya melalui kelompok pendukung ibu hamil dan nifas atau penyelenggaraan sesi konseling kelompok. Pendekatan ini efektif

karena memungkinkan bidan memberikan edukasi dan dukungan kesehatan mental kepada beberapa ibu sekaligus dalam waktu yang sama, serta menciptakan lingkungan saling dukung yang membantu mengurangi stigma sosial terhadap gangguan mental.

Terakhir, diperlukan strategi sosialisasi dan edukasi secara luas kepada masyarakat untuk mengurangi stigma negatif terhadap gangguan mental. Kampanye kesehatan mental melalui berbagai media, seminar, ataupun penyuluhan di masyarakat dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya kesehatan mental ibu hamil dan nifas. Dengan berkurangnya stigma negatif, ibu yang mengalami gangguan mental akan merasa lebih nyaman dan terbuka untuk mencari bantuan, sehingga masalah kesehatan mental dapat dideteksi dan ditangani lebih awal.

I. Simpulan

Kesehatan mental merupakan bagian integral yang sangat penting dalam asuhan kebidanan. Kesehatan mental yang baik selama masa kehamilan, persalinan, dan nifas sangat menentukan kualitas kehidupan ibu dan bayi, serta berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan proses kehamilan dan persalinan secara keseluruhan. Sebaliknya, gangguan kesehatan mental seperti depresi prenatal, kecemasan berlebihan selama kehamilan, baby blues, depresi postpartum, hingga gangguan kecemasan postpartum, dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi fisik ibu, perkembangan janin, hubungan emosional ibu-bayi, serta tumbuh kembang anak dalam jangka panjang.

Deteksi dini gangguan mental melalui instrumen terstandardisasi seperti EPDS dan DASS-21 serta wawancara klinis mendalam merupakan langkah penting dalam praktik kebidanan guna mencegah komplikasi serius yang mungkin timbul. Dalam hal ini, bidan memainkan peran strategis sebagai garda terdepan dalam memberikan dukungan kesehatan mental yang komprehensif, mulai dari edukasi, konseling efektif, intervensi awal berupa pertolongan pertama psikologis, hingga merujuk kasus yang lebih kompleks kepada tenaga profesional kesehatan mental.

Pendampingan psikososial dengan pendekatan holistik menjadi aspek krusial dalam memastikan ibu merasa didukung secara emosional, sosial, dan psikologis, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan mental dan kualitas hidup ibu secara menyeluruh. Studi kasus yang dibahas menegaskan bahwa intervensi kesehatan mental yang tepat waktu mampu membawa dampak positif signifikan pada keberhasilan kehamilan dan persalinan.

Namun, implementasi asuhan kesehatan mental dalam kebidanan masih menghadapi berbagai tantangan seperti kurangnya pemahaman tenaga kesehatan,

keterbatasan sumber daya, waktu, serta adanya stigma negatif dalam masyarakat. Untuk itu, diperlukan upaya komprehensif meliputi peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan rutin, advokasi kebijakan terkait kesehatan mental, penguatan kolaborasi interprofesional, pendekatan berbasis komunitas, serta edukasi luas kepada masyarakat.

Dengan perhatian yang serius dan tindakan nyata terhadap aspek kesehatan mental dalam kebidanan, diharapkan tercipta lingkungan yang mendukung ibu menjalani masa kehamilan, persalinan, serta masa nifas secara sehat, aman, nyaman, dan berkelanjutan, sehingga tercapai generasi yang sehat secara fisik, mental, dan emosional di masa depan.

J. Referensi

- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (5th ed.). American Psychiatric Publishing.
- Austin, M. P., Highet, N., & Expert Working Group. (2017). Mental health care in the perinatal period: Australian clinical practice guideline. Centre of Perinatal Excellence (COPE).
- Cox, J. L., Holden, J. M., & Sagovsky, R. (1987). Detection of postnatal depression: Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. *British Journal of Psychiatry*, 150(6), 782–786. <https://doi.org/10.1192/bjp.150.6.782>
- Dennis, C. L., Falah-Hassani, K., & Shiri, R. (2017). Prevalence of antenatal and postnatal anxiety: Systematic review and meta-analysis. *British Journal of Psychiatry*, 210(5), 315–323. <https://doi.org/10.1192/bjp.bp.116.187179>
- Howard, L. M., Khalifeh, H., & Perera, G. (2014). Psychiatric disorders during pregnancy and postpartum. *JAMA*, 311(2), 172–180. <https://doi.org/10.1001/jama.2013.279840>
- Kingston, D., Tough, S., & Whitfield, H. (2012). Prenatal and postpartum maternal psychological distress and infant development: A systematic review. *Child Psychiatry & Human Development*, 43(5), 683–714. <https://doi.org/10.1007/s10578-012-0291-4>
- Murray, L., & Cooper, P. J. (2015). *Postpartum depression and child development*. Guilford Publications.
- O'Hara, M. W., & McCabe, J. E. (2013). Postpartum depression: Current status and future directions. *Annual Review of Clinical Psychology*, 9, 379–407. <https://doi.org/10.1146/annurev-clinpsy-050212-185612>

Schetter, C. D., & Tanner, L. (2012). Anxiety, depression and stress in pregnancy: Implications for mothers, children, research, and practice. *Current Opinion in Psychiatry*, 25(2), 141–148. <https://doi.org/10.1097/YCO.0b013e3283503680>

World Health Organization. (2014). Mental health: A state of well-being. WHO. Retrieved from https://www.who.int/features/factfiles/mental_health/en/

K. Glosarium

- **Kesehatan Mental**

Suatu kondisi kesejahteraan psikologis, emosional, dan sosial yang memungkinkan seseorang menyadari potensinya, mampu mengatasi stres sehari-hari, bekerja secara produktif, dan berkontribusi positif kepada lingkungannya.

- **Depresi Postpartum**

Gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan sedih mendalam, kehilangan minat terhadap bayi, kelelahan ekstrim, gangguan tidur, hingga munculnya pikiran atau tindakan menyakiti diri sendiri atau bayi, terjadi dalam beberapa minggu hingga setahun setelah melahirkan.

- **Baby Blues**

Sindrom kesedihan ringan yang dialami ibu segera setelah persalinan, ditandai oleh perubahan suasana hati, perasaan sedih, mudah menangis, dan kelelahan, biasanya berlangsung singkat sekitar dua minggu pasca persalinan.

- **Kecemasan Prenatal**

Kondisi kecemasan berlebihan yang dialami ibu selama masa kehamilan, ditandai dengan kekhawatiran yang berlebihan terkait kondisi janin, proses persalinan, serta ketidakpastian masa depan pasca persalinan.

- **Kecemasan Postpartum**

Gangguan kecemasan yang dialami ibu setelah melahirkan, ditandai dengan rasa takut irasional terhadap keselamatan bayi, munculnya pikiran obsesif tentang bahaya pada bayi, serangan panik, serta gejala fisik seperti jantung berdebar dan gangguan tidur.

- **Deteksi Dini**

Proses identifikasi dini terhadap gejala gangguan kesehatan mental pada ibu hamil dan nifas, menggunakan instrumen penilaian terstandar seperti EPDS dan DASS-21, dengan tujuan melakukan intervensi dini sebelum masalah berkembang lebih serius.

- **Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)**

Alat ukur berupa kuesioner yang dirancang khusus untuk mengidentifikasi gejala depresi pada ibu selama masa kehamilan dan pasca persalinan, terdiri dari sepuluh pertanyaan yang menggambarkan suasana hati ibu dalam tujuh hari terakhir.

- **Dukungan Psikososial**

Pendampingan yang diberikan kepada ibu hamil dan nifas yang mencakup aspek emosional, sosial, psikologis, serta spiritual untuk membantu ibu mengatasi berbagai tantangan emosional dan perubahan selama kehamilan hingga masa nifas.

- **Konseling Kebidanan**

Proses interaksi terapeutik antara bidan dengan ibu hamil atau nifas yang bertujuan membantu ibu mengatasi masalah psikologis, emosional, dan sosial dengan menggunakan teknik mendengarkan aktif, empati reflektif, pertanyaan terbuka, serta pemecahan masalah secara kolaboratif.

- **Komunikasi Terapeutik**

Kemampuan tenaga kesehatan, khususnya bidan, dalam berkomunikasi secara aktif dan empati dengan ibu untuk membangun hubungan interpersonal yang positif dan mendukung, guna menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi ibu dalam mengungkapkan perasaan maupun masalahnya.

CHAPTER 2

KESEHATAN MENTAL PEREMPUAN DI MASA PRAKONSEPSI DAN KEHAMILAN

Bdn. Eny Siswati, S.ST., M.Si.

A. Pendahuluan/Prolog

Kesehatan mental merupakan bagian yang sangat esensial dari kehidupan seorang perempuan, terutama dalam periode persiapan menuju kehamilan hingga proses menjalani kehamilan itu sendiri. Kondisi mental perempuan dalam masa prakonsepsi hingga kehamilan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas kehidupan pribadi, kesiapan emosional dalam menjalani peran baru sebagai ibu, serta dampak jangka panjang bagi kesejahteraan anak dan keluarga secara keseluruhan. Kesehatan mental yang optimal tidak hanya membantu perempuan melewati berbagai tantangan yang muncul selama masa-masa tersebut, tetapi juga meningkatkan potensi untuk melahirkan generasi yang lebih sehat secara fisik, emosional, maupun sosial.

Masa prakonsepsi, yakni periode sebelum seorang perempuan benar-benar memasuki kehamilan, merupakan masa yang penting untuk membangun pondasi mental yang kuat. Selama periode ini, perempuan perlu mempersiapkan diri secara mental, fisik, dan emosional agar dapat menjalani kehamilan dengan lebih baik. Persiapan mental meliputi kemampuan dalam mengelola stres, membangun pola pikir positif, serta memperkuat kestabilan emosi dalam menghadapi berbagai kemungkinan yang akan muncul selama masa kehamilan nanti. Perempuan yang memiliki kesehatan mental yang baik pada masa prakonsepsi cenderung mampu merencanakan kehamilan secara matang, memiliki kesiapan lebih tinggi terhadap perubahan fisik dan emosional, serta lebih adaptif dalam menghadapi tantangan yang muncul selama proses kehamilan hingga persalinan.

Di sisi lain, masa kehamilan merupakan fase unik yang penuh dengan berbagai perubahan kompleks bagi seorang perempuan. Selama masa ini, perempuan tidak hanya menghadapi perubahan fisik yang signifikan seperti peningkatan berat badan, perubahan hormonal, dan perubahan fisiologis lainnya, tetapi juga mengalami berbagai perubahan emosional serta tantangan psikologis yang tak kalah berat. Sebagai contoh, perempuan mungkin mengalami perasaan cemas tentang kesehatan janinnya, ketakutan akan proses persalinan, hingga munculnya perasaan tidak percaya diri dalam peran barunya nanti sebagai seorang ibu. Oleh karena itu,

stabilitas kesehatan mental perempuan selama kehamilan menjadi hal penting yang tidak boleh dianggap sepele.

Berbagai studi ilmiah telah menunjukkan bahwa kondisi kesehatan mental perempuan selama masa prakonsepsi hingga kehamilan memiliki dampak besar terhadap kesehatan ibu maupun bayi. Perempuan yang mengalami gangguan mental seperti stres berat, depresi, atau kecemasan berlebihan sebelum dan selama kehamilan cenderung menghadapi risiko lebih tinggi terhadap berbagai komplikasi kehamilan. Gangguan mental tersebut juga terbukti dapat mempengaruhi pertumbuhan janin, misalnya menyebabkan kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, dan berbagai gangguan perkembangan fisik maupun kognitif janin di kemudian hari. Selain itu, dampak psikologis yang muncul selama periode ini juga sangat berpengaruh terhadap hubungan emosional yang terjalin antara ibu dan bayi, yang dapat berdampak pada tumbuh kembang anak dalam jangka panjang.

Tidak kalah penting, kondisi kesehatan mental perempuan di masa prakonsepsi dan kehamilan juga berhubungan erat dengan kondisi kesehatan fisiknya. Perempuan yang sehat secara mental cenderung menjalani pola hidup yang lebih sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi seimbang, rutin berolahraga ringan sesuai anjuran, serta memiliki pola tidur yang baik. Sebaliknya, perempuan yang mengalami stres atau depresi sering kali mengalami gangguan pola makan, kurang tidur, hingga penurunan aktivitas fisik, yang pada akhirnya dapat memperbesar risiko berbagai gangguan kesehatan fisik selama kehamilan seperti diabetes gestasional, preeklampsia, atau gangguan sistem kekebalan tubuh.

Karena berbagai alasan tersebut, kesehatan mental perempuan di masa prakonsepsi dan kehamilan bukan lagi menjadi isu sekunder yang bisa diabaikan, tetapi merupakan hal yang harus menjadi prioritas dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Pentingnya perhatian terhadap kesehatan mental dalam periode ini menuntut keterlibatan aktif dari tenaga kesehatan, keluarga, serta masyarakat secara luas. Pendekatan yang dilakukan harus bersifat holistik, yakni tidak hanya memantau kesehatan fisik perempuan, tetapi juga secara proaktif menilai dan memastikan kondisi mental dan emosionalnya tetap stabil sepanjang periode prakonsepsi hingga kehamilan.

Lebih jauh, kesiapan mental dan emosional seorang perempuan sebelum memasuki kehamilan juga turut menentukan bagaimana ia akan mengelola tantangan emosional setelah kelahiran bayi. Perempuan yang memiliki kondisi mental yang baik sejak awal, umumnya lebih siap dalam menghadapi tantangan emosional pascapersalinan seperti baby blues maupun depresi postpartum. Kesehatan mental yang baik sejak periode prakonsepsi hingga kehamilan juga memungkinkan perempuan memiliki hubungan emosional yang lebih baik dengan

pasangannya, keluarga terdekat, dan lingkungannya, yang mana sangat penting sebagai sumber dukungan sosial selama menjalani kehamilan maupun setelah melahirkan nanti.

B. Pentingnya Kesehatan Mental dalam Periode Prakonsepsi

Periode prakonsepsi merupakan tahap yang sangat menentukan dalam kehidupan perempuan, karena pada masa ini perempuan mempersiapkan dirinya secara menyeluruh untuk menghadapi proses kehamilan. Sayangnya, banyak perempuan maupun keluarga yang masih mengabaikan aspek penting ini, terutama mengenai kondisi kesehatan mental. Padahal, kesehatan mental yang baik sejak masa prakonsepsi merupakan kunci penting dalam menentukan tingkat kesuburan, kesiapan psikologis menghadapi kehamilan, serta kelancaran proses perencanaan keluarga secara keseluruhan.

Secara biologis dan psikologis, tubuh perempuan adalah satu kesatuan sistem yang sangat kompleks, di mana kesehatan fisik dan mental saling mempengaruhi secara erat. Kesehatan mental yang baik selama masa prakonsepsi berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan kondisi fisik yang optimal bagi terjadinya kehamilan. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami stres berat, depresi, atau kecemasan tinggi sebelum kehamilan memiliki kemungkinan yang lebih besar mengalami gangguan hormonal yang dapat mengganggu proses ovulasi, siklus menstruasi, hingga akhirnya berpengaruh pada fertilitas. Sebaliknya, perempuan dengan kondisi mental yang stabil, tenang, dan bahagia cenderung memiliki pola hormonal yang lebih seimbang, sehingga mendukung terjadinya proses pembuahan yang optimal.

Hubungan antara kondisi psikologis dan fertilitas ini dikarenakan otak dan sistem reproduksi dihubungkan oleh jalur neuroendokrin, yang secara langsung dipengaruhi oleh kondisi emosional. Ketika seorang perempuan mengalami stres yang berkepanjangan atau tekanan psikologis yang intens, tubuh akan melepaskan hormon stres seperti kortisol secara berlebihan. Hormon kortisol yang tinggi secara kronis dapat menekan fungsi normal dari hipotalamus dan hipofisis, dua bagian otak yang bertanggung jawab mengatur siklus menstruasi dan ovulasi. Akibatnya, siklus menstruasi bisa menjadi tidak teratur, proses ovulasi terhambat, bahkan dapat memicu gangguan fertilitas jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga kestabilan mental sejak periode prakonsepsi agar tubuh bisa siap sepenuhnya untuk proses reproduksi.

Selain dampak biologis terhadap fertilitas, menjaga kesehatan mental sejak periode prakonsepsi juga sangat penting untuk memastikan kesiapan psikologis seorang perempuan dalam menghadapi kehamilan. Kehamilan bukan sekadar

proses biologis, melainkan sebuah transformasi besar yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan perempuan, mulai dari fisik, emosional, hingga sosial. Oleh karena itu, kesiapan mental sejak awal menjadi faktor penting dalam menentukan bagaimana seorang perempuan mampu menghadapi berbagai perubahan ini. Perempuan yang secara psikologis siap untuk hamil biasanya memiliki ketahanan yang lebih tinggi dalam menghadapi tantangan emosional yang muncul selama kehamilan, seperti perasaan takut, cemas, dan ketidakpastian. Dengan kesiapan mental yang baik, perempuan mampu mengelola stres dan kecemasan secara efektif, menjaga keseimbangan emosi, serta membangun pola pikir positif terhadap proses kehamilan yang akan dijalani.

Sebaliknya, perempuan yang memasuki masa kehamilan tanpa persiapan mental yang baik cenderung lebih rentan terhadap berbagai masalah emosional. Kecemasan berlebihan, stres berat, bahkan depresi prenatal sering kali muncul jika perempuan kurang memiliki kesiapan psikologis. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak negatif bagi perempuan itu sendiri, tetapi juga berpengaruh besar terhadap perkembangan janin yang dikandung. Sebagai contoh, berbagai penelitian menunjukkan bahwa stres tinggi atau depresi pada masa awal kehamilan meningkatkan risiko komplikasi serius seperti kelahiran prematur, berat badan bayi lahir rendah, bahkan gangguan perkembangan neurokognitif pada anak di kemudian hari. Dengan demikian, kondisi mental yang baik sejak periode prakonsepsi merupakan modal penting untuk menciptakan kehamilan yang sehat dan aman bagi ibu maupun bayi.

Di sisi lain, kesehatan mental pada periode prakonsepsi juga memiliki dampak besar dalam konteks perencanaan keluarga. Sebuah keluarga yang direncanakan dengan matang secara psikologis akan mampu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis, stabil, dan mendukung bagi tumbuh kembang anak. Kondisi mental dan emosional perempuan yang stabil memungkinkan perencanaan keluarga menjadi lebih realistis, terarah, serta berdasarkan pertimbangan matang. Misalnya, perempuan dengan kondisi psikologis yang baik lebih mampu merencanakan kapan waktu yang tepat untuk memiliki anak, memahami konsekuensi psikologis dari menjadi ibu, serta memiliki visi yang lebih jelas tentang bagaimana menjalani peran barunya nanti dalam keluarga. Hal ini sangat penting karena kehadiran anak dalam keluarga akan mengubah dinamika hubungan pasangan, pola interaksi sosial, hingga tanggung jawab sehari-hari.

Sebaliknya, kondisi mental yang buruk seperti depresi atau kecemasan tinggi selama masa prakonsepsi dapat menyebabkan perencanaan keluarga menjadi terganggu atau bahkan tidak realistis. Sebagai contoh, perempuan yang sedang mengalami stres berat atau kondisi psikologis tidak stabil sering kali membuat

keputusan emosional yang impulsif terkait kehamilan, seperti menunda terlalu lama, memaksakan kehamilan tanpa persiapan matang, atau bahkan menjalani kehamilan tanpa memahami konsekuensi emosionalnya. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menyebabkan konflik dalam keluarga, kurangnya kesiapan emosional menghadapi peran sebagai orang tua, serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental setelah kelahiran bayi seperti depresi postpartum.

Karena pentingnya kesehatan mental pada masa prakonsepsi, maka peran tenaga kesehatan, khususnya bidan dan konselor, sangatlah krusial dalam memberikan edukasi, dukungan emosional, serta konseling yang tepat kepada perempuan yang sedang mempersiapkan kehamilan. Tenaga kesehatan harus mampu mengidentifikasi secara dini berbagai gangguan psikologis yang mungkin dialami perempuan pada masa prakonsepsi, serta memberikan intervensi yang tepat agar gangguan tersebut tidak berlanjut ke dalam masa kehamilan. Dukungan dari keluarga, khususnya pasangan, juga tidak kalah penting dalam menciptakan lingkungan psikologis yang sehat, nyaman, dan mendukung bagi perempuan.

C. Faktor-faktor yang Memengaruhi Kesehatan Mental pada Masa Prakonsepsi

Kesehatan mental perempuan pada masa prakonsepsi tidak terbentuk secara tiba-tiba, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berhubungan secara kompleks. Kondisi psikologis perempuan sebelum kehamilan ditentukan oleh interaksi antara faktor risiko yang dapat memperburuk kondisi kesehatan mental, dan faktor protektif yang dapat menjaga kestabilan emosional serta psikologis perempuan. Mengetahui berbagai faktor ini secara detail sangat penting karena dapat membantu tenaga kesehatan maupun keluarga dalam merancang strategi intervensi yang efektif, sehingga kondisi kesehatan mental perempuan tetap optimal sejak sebelum kehamilan.

Salah satu faktor risiko utama yang sangat mempengaruhi kesehatan mental perempuan pada masa prakonsepsi adalah tekanan sosial. Tekanan ini biasanya berupa ekspektasi tinggi dari lingkungan sekitar seperti keluarga, pasangan, ataupun masyarakat tentang kapan dan bagaimana seorang perempuan harus memiliki anak. Di berbagai budaya, tekanan untuk segera memiliki anak setelah menikah sering kali sangat kuat, yang menyebabkan perempuan merasa tertekan secara psikologis jika belum mampu mewujudkannya dalam waktu singkat. Tekanan ini dapat berujung pada stres berkepanjangan, kecemasan, bahkan depresi, terutama ketika perempuan merasa bahwa dirinya belum siap secara fisik, emosional, ataupun finansial untuk memiliki anak. Selain itu, tekanan sosial terkait standar kecantikan, bentuk tubuh ideal, atau citra diri yang positif juga dapat memicu masalah kesehatan mental, di mana perempuan yang merasa tidak

memenuhi standar tersebut akan mengalami stres kronis dan rendahnya kepercayaan diri yang pada akhirnya mempengaruhi keseimbangan emosinya.

Riwayat kesehatan mental keluarga juga merupakan faktor risiko penting yang harus diperhatikan secara serius dalam periode prakonsepsi. Beberapa gangguan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, atau bipolar memiliki kecenderungan untuk diwariskan dalam keluarga, baik melalui aspek genetika maupun pola asuh. Jika dalam keluarga terdapat riwayat gangguan kesehatan mental, perempuan memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami kondisi serupa sebelum maupun selama kehamilan. Kondisi ini diperparah apabila perempuan tersebut tidak menyadari atau tidak mendapatkan dukungan yang cukup untuk mengatasi masalah emosional yang mungkin timbul. Oleh karena itu, tenaga kesehatan sangat perlu mengidentifikasi riwayat kesehatan mental keluarga ketika melakukan konsultasi prakonsepsi agar dapat memberikan dukungan atau intervensi yang tepat sejak dini.

Selanjutnya, dukungan sosial merupakan faktor yang sangat penting dan memiliki peran signifikan sebagai faktor protektif dalam menjaga kesehatan mental perempuan pada masa prakonsepsi. Dukungan sosial yang kuat, terutama dari pasangan, keluarga, maupun lingkungan sosial yang lebih luas, terbukti mampu mengurangi tingkat stres, kecemasan, bahkan depresi secara signifikan. Perempuan yang memiliki dukungan emosional, fisik, maupun psikologis dari orang terdekatnya cenderung memiliki tingkat ketahanan mental yang lebih tinggi dalam menghadapi berbagai tantangan psikologis sebelum kehamilan. Sebaliknya, perempuan yang kurang mendapatkan dukungan sosial, terutama ketika menghadapi tantangan seperti infertilitas, tekanan pekerjaan, atau konflik keluarga, berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan mental yang serius. Pentingnya peran dukungan sosial ini membuat intervensi pada masa prakonsepsi harus melibatkan pasangan maupun keluarga dalam proses persiapan kehamilan, sehingga perempuan merasa benar-benar didukung dan tidak menghadapi tekanan psikologis seorang diri.

Kondisi ekonomi juga menjadi faktor penting yang berpengaruh besar terhadap kondisi mental perempuan pada masa prakonsepsi. Ketidakstabilan ekonomi atau tekanan finansial dapat menjadi sumber utama stres yang sangat tinggi bagi pasangan maupun individu yang merencanakan kehamilan. Perempuan yang menghadapi kesulitan ekonomi sering kali merasakan kecemasan berlebih tentang bagaimana mereka nantinya akan mencukupi kebutuhan selama kehamilan, biaya persalinan, hingga kebutuhan masa depan anak. Hal ini dapat menciptakan tekanan psikologis yang kronis, yang pada akhirnya dapat menurunkan keseimbangan hormon serta fungsi fisiologis tubuh, sehingga berdampak negatif terhadap fertilitas maupun kesiapan psikologis dalam menghadapi kehamilan.

Sebaliknya, perempuan dengan kondisi ekonomi yang stabil atau memadai biasanya memiliki kondisi mental yang lebih tenang dan terkontrol, karena mereka merasa yakin mampu memenuhi kebutuhan keluarga dan anak di masa depan.

Selain faktor-faktor tersebut, ada pula faktor-faktor lain yang tidak kalah penting untuk diperhatikan, seperti status hubungan pasangan, usia perempuan, dan riwayat gangguan kesehatan fisik yang kronis. Status hubungan pasangan yang harmonis, penuh dukungan, dan terbuka terbukti sangat mendukung kestabilan mental perempuan pada periode prakonsepsi. Sebaliknya, konflik yang sering terjadi dengan pasangan dapat menimbulkan stres kronis dan ketidakstabilan emosi, yang pada akhirnya mempengaruhi kesiapan perempuan dalam menjalani kehamilan. Faktor usia juga memiliki peran signifikan, di mana perempuan pada usia muda atau terlalu tua memiliki kecenderungan mengalami tekanan psikologis lebih tinggi karena kekhawatiran tentang risiko komplikasi selama kehamilan maupun persalinan.

Selain itu, riwayat gangguan kesehatan fisik seperti penyakit kronis (misalnya diabetes, hipertensi, atau gangguan tiroid) juga dapat berkontribusi terhadap kondisi psikologis yang negatif, karena perempuan merasa cemas mengenai dampak penyakit tersebut terhadap proses kehamilan dan perkembangan janin nantinya. Oleh karena itu, penanganan kondisi fisik yang optimal sebelum kehamilan menjadi sangat penting, guna mengurangi kecemasan maupun stres yang bisa muncul akibat kondisi fisik yang belum terkontrol.

Dalam konteks intervensi kesehatan mental prakonsepsi, tenaga kesehatan, khususnya bidan dan tenaga kesehatan mental seperti psikolog, perlu memahami berbagai faktor risiko maupun protektif ini secara mendalam. Mereka harus secara aktif melakukan deteksi dini terhadap perempuan yang berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan mental sebelum kehamilan. Selain itu, pemberian edukasi tentang pentingnya menjaga kesehatan mental, pemberian konseling psikologis, serta memperkuat dukungan sosial maupun keluarga, menjadi langkah penting yang harus dilakukan secara konsisten untuk menciptakan lingkungan psikologis yang sehat dan stabil bagi perempuan.

Dengan mengenali dan memahami secara rinci berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi mental perempuan pada masa prakonsepsi, diharapkan dapat dilakukan berbagai intervensi yang efektif guna meningkatkan kesejahteraan emosional dan psikologis perempuan. Hal ini tidak hanya akan membantu perempuan menjalani masa prakonsepsi secara lebih nyaman dan bahagia, tetapi juga menjadi pondasi yang kuat bagi terciptanya kehamilan yang sehat, persalinan yang aman, serta perkembangan anak yang optimal dalam jangka panjang.

D. Gangguan Mental yang Umum pada Masa Prakonsepsi

Pada masa prakonsepsi, kesehatan mental perempuan menjadi perhatian khusus karena periode ini merupakan awal penting yang menentukan kualitas kehamilan dan kesejahteraan ibu serta janin nantinya. Sayangnya, periode ini juga rentan terhadap munculnya berbagai gangguan mental yang sering kali tidak disadari atau terabaikan. Gangguan mental yang umum terjadi pada masa prakonsepsi meliputi kecemasan terkait infertilitas, depresi prakonsepsi, serta stres kronis yang berkaitan dengan berbagai tantangan psikologis yang dihadapi perempuan sebelum memulai kehamilan.

Kecemasan terkait infertilitas merupakan salah satu gangguan mental yang sangat umum dialami perempuan selama masa prakonsepsi. Perempuan yang mengalami kesulitan dalam proses pembuahan, terutama yang telah mencoba hamil dalam waktu yang lama, cenderung mengalami kecemasan yang tinggi dan persisten. Kecemasan ini biasanya muncul dalam bentuk kekhawatiran berlebih terhadap kemampuan tubuhnya dalam mengandung, perasaan bersalah terhadap pasangan, rasa takut tidak bisa memenuhi harapan keluarga, dan tekanan internal karena merasa tidak mampu menjalankan peran sosialnya sebagai seorang perempuan. Kondisi kecemasan tersebut sering kali diperparah oleh tekanan sosial dari lingkungan yang mempertanyakan atau bahkan menghakimi perempuan yang belum mampu hamil dalam waktu tertentu setelah menikah.

Dampak dari kecemasan terkait infertilitas sangat luas dan signifikan terhadap kondisi fisik maupun emosional perempuan. Secara fisik, kecemasan ini dapat menyebabkan gangguan hormonal yang dapat memperburuk siklus menstruasi atau menghambat proses ovulasi, sehingga memperbesar kemungkinan sulit hamil. Di sisi emosional, perempuan dapat mengalami gangguan tidur, penurunan nafsu makan, hingga mengalami kesulitan dalam menjalani aktivitas sehari-hari secara optimal karena pikirannya selalu tertuju pada keinginan untuk segera memiliki anak. Kecemasan ini jika berlangsung lama, dapat berkembang menjadi gangguan kecemasan umum (*generalized anxiety disorder*) yang membutuhkan intervensi profesional secara lebih intensif.

Selain kecemasan, depresi prakonsepsi juga sering dialami oleh perempuan sebelum masa kehamilan. Depresi pada masa ini ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat terhadap aktivitas yang biasa dinikmati, perasaan putus asa terhadap masa depan, serta penurunan rasa percaya diri yang drastis. Depresi prakonsepsi bisa dipicu oleh berbagai faktor, seperti kegagalan berulang dalam usaha mendapatkan kehamilan, konflik dengan pasangan atau keluarga terkait rencana kehamilan, atau kondisi ekonomi yang tidak stabil. Dalam beberapa kasus, perempuan yang memiliki riwayat depresi atau trauma emosional

sebelumnya juga memiliki risiko lebih tinggi mengalami depresi prakonsepsi ketika menghadapi tekanan psikologis pada periode ini.

Dampak depresi prakonsepsi terhadap kesiapan perempuan menghadapi kehamilan sangat signifikan. Perempuan yang mengalami depresi cenderung memiliki motivasi yang rendah dalam menjaga pola hidup sehat, seperti pola makan bergizi, olahraga rutin, maupun konsumsi vitamin prenatal yang sangat penting bagi kesehatan tubuh dalam persiapan kehamilan. Selain itu, depresi juga berhubungan erat dengan perubahan hormonal yang dapat menurunkan tingkat kesuburan, sehingga secara fisik dapat menghambat terjadinya kehamilan yang diharapkan. Lebih jauh lagi, depresi yang tidak tertangani secara efektif sebelum kehamilan dapat meningkatkan risiko munculnya gangguan mental yang lebih berat selama kehamilan maupun pasca persalinan, seperti depresi postpartum atau kecemasan selama kehamilan.

Selanjutnya, stres kronis juga menjadi gangguan mental yang sangat umum pada masa prakonsepsi. Stres kronis adalah bentuk stres berkepanjangan yang terjadi akibat berbagai tekanan yang dihadapi perempuan secara terus menerus dalam kehidupan sehari-hari, baik terkait pekerjaan, hubungan interpersonal, masalah ekonomi, maupun tekanan untuk segera hamil. Kondisi stres kronis ini dapat menyebabkan perempuan terus berada dalam kondisi "fight or flight," di mana tubuh selalu dalam kondisi tegang yang diikuti oleh peningkatan hormon stres, seperti kortisol. Peningkatan hormon kortisol yang terus menerus ini tidak hanya berdampak negatif terhadap kondisi fisik seperti gangguan metabolisme, peningkatan risiko hipertensi, diabetes, dan gangguan sistem kekebalan tubuh, tetapi juga mempengaruhi keseimbangan hormonal perempuan secara keseluruhan.

Dari sisi emosional dan psikologis, stres kronis pada masa prakonsepsi dapat membuat perempuan merasa sangat lelah secara emosional (emotional exhaustion), mudah marah, sulit berkonsentrasi, dan mengalami gangguan tidur yang cukup serius. Kondisi ini juga berdampak buruk terhadap hubungan interpersonal perempuan, terutama dengan pasangan maupun keluarga, sehingga menciptakan lingkungan emosional yang kurang kondusif bagi kehamilan yang sehat nantinya. Penelitian menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami stres kronis sebelum kehamilan memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi kehamilan seperti kelahiran prematur, berat bayi lahir rendah, serta berbagai masalah kesehatan lainnya yang berhubungan dengan gangguan perkembangan janin.

Lebih lanjut, gangguan mental yang tidak tertangani pada masa prakonsepsi juga dapat mempengaruhi kesiapan emosional perempuan dalam menghadapi kehamilan. Perempuan yang mengalami kecemasan, depresi, atau stres kronis

cenderung memiliki persepsi negatif terhadap kehamilan, merasa tidak yakin akan kemampuannya dalam menjalankan peran sebagai ibu, serta cenderung merasa takut terhadap proses persalinan maupun kehidupan setelah melahirkan. Ketidaksiapan emosional ini dapat memicu berbagai masalah psikologis yang lebih serius selama kehamilan, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap kesehatan fisik ibu dan perkembangan janin dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, deteksi dini terhadap berbagai gangguan mental ini menjadi langkah yang sangat krusial dalam pelayanan prakonsepsi. Perempuan yang merencanakan kehamilan sebaiknya mendapatkan pemeriksaan kesehatan mental secara menyeluruh, terutama jika mereka memiliki faktor risiko seperti riwayat gangguan kesehatan mental pribadi atau keluarga, tekanan sosial yang tinggi, maupun masalah infertilitas yang berkepanjangan. Intervensi berupa konseling psikologis, dukungan sosial yang kuat, serta terapi medis jika dibutuhkan, sangat penting untuk diberikan agar kondisi mental perempuan dapat kembali stabil sebelum memasuki masa kehamilan.

Secara keseluruhan, memahami berbagai gangguan mental yang umum pada masa prakonsepsi secara mendalam menjadi langkah penting dalam menciptakan kehamilan yang sehat secara fisik maupun psikologis. Tenaga kesehatan, khususnya bidan dan psikolog, perlu memberikan perhatian lebih besar terhadap kondisi mental perempuan pada masa ini, sehingga berbagai masalah psikologis dapat dicegah atau diatasi secara efektif. Dengan kondisi kesehatan mental yang baik, perempuan akan memiliki kesiapan yang optimal, baik secara fisik maupun emosional, dalam menghadapi proses kehamilan, persalinan, serta peran baru sebagai seorang ibu di masa mendatang.

E. Hubungan antara Kesehatan Mental dan Kehamilan

Kesehatan mental perempuan selama masa kehamilan merupakan salah satu aspek penting yang tidak boleh diabaikan, karena memiliki hubungan yang erat dan timbal balik dengan kelancaran proses kehamilan, risiko komplikasi fisik maupun mental, serta perkembangan janin secara keseluruhan. Secara umum, kondisi mental ibu yang baik dapat menjadi fondasi kuat bagi kelangsungan kehamilan yang sehat, sebaliknya kondisi mental yang terganggu dapat menimbulkan dampak negatif, tidak hanya bagi ibu, tetapi juga bagi perkembangan janin yang dikandung.

Selama masa kehamilan, seorang perempuan mengalami perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupannya, termasuk fisik, hormonal, emosional, serta sosial. Perubahan hormonal, khususnya peningkatan hormon estrogen dan progesteron secara drastis selama masa kehamilan, menyebabkan perubahan suasana hati yang cukup signifikan pada perempuan hamil. Dalam situasi

ini, jika perempuan memiliki kondisi kesehatan mental yang stabil, maka perubahan suasana hati dan tantangan emosional selama kehamilan dapat dihadapi dengan lebih baik. Sebaliknya, perempuan dengan gangguan mental seperti depresi, kecemasan, atau stres kronis sebelum atau selama masa kehamilan, lebih rentan terhadap tekanan emosional tambahan akibat perubahan hormonal yang terjadi, sehingga risiko gangguan mental yang lebih berat semakin meningkat.

Kesehatan mental ibu yang terganggu selama kehamilan juga secara langsung berhubungan dengan peningkatan risiko berbagai komplikasi kehamilan. Salah satu contoh paling nyata adalah peningkatan risiko preeklampsia, kondisi tekanan darah tinggi yang muncul selama kehamilan, terutama pada ibu yang mengalami stres kronis atau depresi selama masa kehamilan. Penelitian menunjukkan bahwa stres kronis atau depresi berat pada ibu hamil dapat memicu peningkatan produksi hormon stres seperti kortisol, yang kemudian menyebabkan gangguan pada fungsi plasenta serta meningkatkan risiko hipertensi gestasional. Selain itu, ibu yang mengalami kecemasan berat atau depresi selama kehamilan juga lebih rentan mengalami diabetes gestasional akibat terganggunya regulasi insulin dalam tubuh yang dipicu oleh stres kronis. Kondisi ini, jika tidak ditangani secara tepat, berisiko mengganggu kesehatan fisik ibu dan perkembangan janin di dalam rahim.

Tidak hanya komplikasi fisik, kondisi kesehatan mental yang buruk pada ibu hamil juga secara signifikan meningkatkan risiko komplikasi mental yang lebih serius, baik selama kehamilan maupun setelah persalinan. Salah satu gangguan mental yang sangat umum terjadi adalah depresi prenatal dan kecemasan prenatal. Depresi prenatal, yang sering kali diabaikan dibandingkan depresi postpartum, dapat menyebabkan perempuan kehilangan minat dalam menjaga pola hidup sehat seperti pola makan bergizi, olahraga ringan, serta kunjungan rutin pemeriksaan kehamilan. Dampak lebih serius dari depresi prenatal adalah munculnya pikiran negatif atau bahkan pikiran tentang menyakiti diri sendiri maupun janinnya. Kecemasan prenatal, di sisi lain, ditandai dengan ketakutan berlebihan tentang kesehatan janin, proses persalinan yang akan dijalani, atau ketidakpastian masa depan sebagai seorang ibu, yang dapat menyebabkan ibu mengalami gangguan tidur, penurunan nafsu makan, serta ketegangan emosional yang berkepanjangan.

Selain dampaknya terhadap ibu, gangguan kesehatan mental selama kehamilan juga membawa dampak negatif terhadap perkembangan janin dalam rahim. Berbagai studi ilmiah menunjukkan bahwa ibu yang mengalami stres kronis atau depresi berat selama kehamilan cenderung memiliki janin dengan risiko lebih tinggi mengalami hambatan pertumbuhan intrauterin (Intrauterine Growth Restriction/IUGR). Hal ini terjadi karena stres berkepanjangan dapat mengganggu aliran darah ke plasenta, sehingga asupan nutrisi dan oksigen kepada janin menjadi

tidak optimal. Akibatnya, janin mengalami hambatan dalam pertumbuhan fisik maupun perkembangan organ penting seperti otak dan sistem saraf.

Gangguan kesehatan mental ibu hamil juga berpengaruh terhadap perkembangan neurologis janin. Stres yang tinggi pada ibu hamil menyebabkan janin terpapar hormon stres secara berlebihan, terutama kortisol, yang memiliki dampak langsung terhadap perkembangan struktur otak dan sistem saraf janin. Janin yang terpapar stres kronis sejak dalam kandungan cenderung memiliki sistem saraf yang lebih sensitif dan reaktif, yang dalam jangka panjang dapat memengaruhi kemampuan anak dalam mengatur emosi, menghadapi stres, serta berinteraksi sosial. Bahkan, dalam beberapa kasus, anak yang dilahirkan dari ibu yang mengalami gangguan kesehatan mental selama kehamilan memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan kecemasan, depresi, serta gangguan perilaku seperti hiperaktivitas atau gangguan konsentrasi sejak usia dini.

Dari sudut pandang perkembangan psikologis dan emosional, kondisi kesehatan mental ibu selama kehamilan juga berperan dalam membentuk hubungan emosional (bonding) antara ibu dan janin sejak dini. Ibu yang memiliki kondisi mental stabil cenderung membangun hubungan yang positif dengan janinnya, melalui berbagai aktivitas seperti berbicara atau bernyanyi kepada janin dalam kandungan. Sebaliknya, ibu yang mengalami depresi atau kecemasan berat cenderung kesulitan untuk merasakan keterikatan emosional tersebut. Kondisi ini dapat berlanjut hingga masa setelah kelahiran bayi, mengakibatkan ibu kesulitan dalam membangun hubungan emosional yang sehat dan kuat dengan anaknya. Dampak jangka panjang dari kondisi ini adalah peningkatan risiko masalah perilaku dan emosional pada anak di kemudian hari.

Oleh karena itu, penting sekali bagi tenaga kesehatan yang menangani ibu hamil, khususnya bidan, perawat, atau dokter kandungan, untuk selalu memberikan perhatian khusus terhadap kondisi kesehatan mental perempuan selama kehamilan. Upaya deteksi dini gangguan mental melalui skrining psikologis rutin dengan instrumen yang telah terstandar seperti Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) atau Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS-21) sangat penting untuk diterapkan secara luas di fasilitas pelayanan kesehatan antenatal. Jika gangguan mental dapat diidentifikasi lebih awal, intervensi psikologis maupun medis dapat segera diberikan untuk mencegah dampak negatif lebih lanjut terhadap ibu maupun janin.

Intervensi yang efektif seperti konseling psikososial, terapi perilaku kognitif (Cognitive Behavioral Therapy/CBT), pemberian informasi yang akurat dan mendukung terkait kehamilan serta persalinan, hingga dukungan sosial dari pasangan dan keluarga menjadi kunci penting dalam membantu ibu menghadapi

tantangan emosional selama masa kehamilan dengan lebih baik. Dengan intervensi dan dukungan yang tepat, kondisi mental ibu selama kehamilan dapat terjaga dengan baik, sehingga risiko komplikasi fisik dan mental dapat diminimalisir secara signifikan.

F. Gangguan Mental selama Masa Kehamilan

Masa kehamilan merupakan fase yang sangat sensitif dan penuh tantangan bagi seorang perempuan. Selain mengalami perubahan fisik yang signifikan, perempuan juga menghadapi beragam perubahan emosional, hormonal, psikologis, hingga sosial. Dalam kondisi tersebut, perempuan hamil rentan terhadap berbagai gangguan kesehatan mental, yang bila tidak segera diidentifikasi dan ditangani dengan tepat dapat berdampak serius bagi ibu maupun janin. Beberapa gangguan mental yang sering muncul selama masa kehamilan antara lain adalah depresi prenatal, kecemasan yang berlebihan, serta stres berat.

Depresi prenatal merupakan salah satu gangguan mental yang umum terjadi, namun sering kali terabaikan karena fokus perhatian lebih banyak diarahkan pada depresi pasca melahirkan (postpartum). Depresi prenatal ditandai oleh perasaan sedih yang mendalam, hilangnya minat dan gairah terhadap aktivitas sehari-hari, penurunan energi, perubahan pola tidur dan nafsu makan, perasaan tidak berharga, hingga timbulnya pikiran negatif terkait kehamilan dan masa depan. Depresi ini dapat muncul di setiap trimester kehamilan, namun sering kali lebih intens pada trimester pertama dan ketiga, ketika perubahan hormonal dan fisik sedang mencapai puncaknya.

Penyebab depresi prenatal sangat kompleks dan multifaktorial, mencakup perubahan hormon secara drastis, tekanan sosial dan ekonomi, ketidaksiapan emosional menghadapi kehamilan, konflik keluarga atau pasangan, serta riwayat gangguan mental sebelumnya. Perempuan yang mengalami depresi prenatal cenderung tidak mampu merawat diri dengan baik, kurang menjaga pola makan sehat, sering melewatkan kunjungan antenatal, serta lebih berisiko mengalami komplikasi kehamilan seperti preeklampsia, diabetes gestasional, kelahiran prematur, serta berat bayi lahir rendah. Dampak ini terjadi karena depresi menyebabkan gangguan dalam sistem fisiologis tubuh yang dapat memengaruhi fungsi plasenta, aliran darah ke janin, hingga regulasi hormonal dan metabolisme ibu.

Selain depresi prenatal, kecemasan yang berlebihan juga sangat umum terjadi selama kehamilan. Kecemasan prenatal ditandai dengan rasa khawatir yang intens dan tidak terkendali, biasanya berhubungan dengan kesehatan janin, proses persalinan, dan peran baru sebagai seorang ibu. Perempuan hamil yang mengalami

kecemasan tinggi sering mengalami gejala fisik seperti jantung berdebar, gangguan tidur, mual, sakit kepala, hingga gangguan pencernaan yang semakin memperparah ketidaknyamanan selama kehamilan. Kecemasan yang tidak ditangani dengan baik bisa berkembang menjadi gangguan kecemasan generalisasi atau gangguan panik, yang secara signifikan memengaruhi kualitas hidup ibu serta kondisi fisik kehamilan.

Dalam konteks hormonal, kecemasan berat dapat memicu peningkatan produksi hormon stres seperti kortisol secara berkepanjangan. Kondisi ini pada akhirnya dapat mengganggu fungsi plasenta, yang berisiko menyebabkan hambatan pertumbuhan janin, bahkan kelahiran prematur. Selain itu, janin yang terus-menerus terpapar hormon stres dalam kandungan dapat mengalami perubahan pada sistem sarafnya, yang meningkatkan risiko gangguan perkembangan saraf dan perilaku pada masa anak-anak kelak.

Gangguan kesehatan mental lainnya yang umum terjadi selama kehamilan adalah stres berat atau stres kronis. Stres berat biasanya muncul karena faktor eksternal seperti tekanan finansial, masalah dalam hubungan keluarga, lingkungan yang kurang mendukung, atau tuntutan pekerjaan yang tinggi. Stres berat ini tidak sekadar perasaan cemas sesaat, tetapi merupakan kondisi tekanan emosional yang berlangsung lama dan kronis, yang sangat berpengaruh pada keseimbangan fisiologis tubuh perempuan hamil.

Perempuan hamil yang mengalami stres kronis sering kali memiliki kondisi kesehatan fisik yang menurun, seperti peningkatan tekanan darah, gangguan pola tidur, pola makan yang tidak sehat, hingga sistem imun yang melemah. Semua kondisi ini sangat tidak ideal bagi kehamilan, karena dapat memperbesar risiko komplikasi fisik yang serius seperti preeklampsia, diabetes gestasional, atau kelahiran prematur. Di samping itu, stres yang kronis juga meningkatkan risiko gangguan mental lainnya seperti depresi dan kecemasan prenatal.

Efek jangka pendek dari gangguan mental selama kehamilan secara nyata terlihat dalam bentuk penurunan kualitas kesehatan fisik ibu. Perempuan dengan gangguan mental prenatal biasanya mengalami keluhan fisik yang lebih parah dan berkepanjangan, serta memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami komplikasi selama proses persalinan. Sementara dari sisi janin, dampak jangka pendeknya adalah peningkatan risiko berat badan lahir rendah, hambatan pertumbuhan janin (IUGR), serta peningkatan risiko kelahiran prematur.

Namun, efek gangguan mental selama kehamilan tidak hanya terbatas pada masa prenatal dan persalinan saja, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang cukup signifikan. Dalam jangka panjang, anak yang lahir dari ibu dengan gangguan mental selama kehamilan berisiko mengalami berbagai masalah perkembangan, baik secara fisik maupun psikologis. Secara fisik, mereka lebih rentan mengalami

masalah kesehatan kronis seperti penyakit jantung, gangguan metabolisme, hingga penyakit autoimun akibat paparan stres tinggi selama masa intrauterin. Sedangkan secara psikologis, anak-anak ini cenderung memiliki tingkat sensitivitas emosi yang tinggi, lebih mudah mengalami kecemasan, gangguan perilaku seperti hiperaktivitas, kesulitan belajar, hingga gangguan mood seperti depresi di masa pertumbuhan mereka.

Selain itu, hubungan emosional antara ibu dan bayi (bonding) setelah kelahiran juga dapat terganggu secara signifikan akibat kondisi mental ibu selama kehamilan. Ibu yang mengalami depresi, kecemasan, atau stres kronis cenderung memiliki kesulitan dalam membangun hubungan emosional yang erat dan positif dengan bayinya sejak dini. Akibatnya, hubungan ibu-anak menjadi kurang optimal, yang dalam jangka panjang dapat menyebabkan gangguan dalam perkembangan sosial, emosional, bahkan kognitif anak.

Mengingat dampak serius dari gangguan mental selama kehamilan ini, maka penting sekali bagi tenaga kesehatan seperti bidan, dokter kandungan, atau psikolog untuk secara aktif melakukan skrining kesehatan mental pada setiap kunjungan antenatal. Deteksi dini dan intervensi yang tepat dapat membantu perempuan hamil mengatasi gangguan mental yang dialaminya sebelum berdampak lebih buruk. Intervensi ini bisa berupa dukungan psikososial, konseling individual atau kelompok, terapi perilaku kognitif (CBT), hingga pemberian medikasi jika dianggap perlu dan aman bagi kehamilan.

Selain dukungan profesional, peran keluarga dan pasangan juga sangat vital dalam menjaga kesehatan mental ibu hamil. Dukungan sosial dan emosional dari lingkungan terdekat dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan menurunkan tingkat stres secara signifikan, sehingga ibu lebih mampu menikmati masa kehamilannya dengan kondisi emosional yang stabil. Dukungan ini penting tidak hanya sebagai upaya pencegahan, namun juga sebagai faktor protektif utama dalam mencegah gangguan mental yang lebih berat selama kehamilan.

G. Strategi Deteksi Dini dan Penilaian Kesehatan Mental pada Masa Prakonsepsi dan Kehamilan

Deteksi dini serta penilaian kesehatan mental merupakan langkah penting dalam menjaga kualitas hidup perempuan yang sedang dalam masa persiapan kehamilan (prakonsepsi) maupun selama masa kehamilan. Hal ini bertujuan agar gangguan mental yang mungkin muncul dapat segera diidentifikasi dan mendapatkan intervensi yang tepat sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Dalam praktiknya, deteksi dini terhadap gangguan kesehatan mental dilakukan dengan menggunakan berbagai metode dan instrumen yang telah teruji

validitas serta reliabilitasnya secara klinis. Strategi ini mencakup penggunaan alat ukur terstandar seperti Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS-21), serta wawancara klinis mendalam oleh tenaga kesehatan yang terlatih.

Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) merupakan instrumen penilaian gangguan mental yang paling sering digunakan secara internasional dalam konteks kebidanan, baik pada masa kehamilan (prenatal) maupun pasca melahirkan (postnatal). Walaupun nama instrumen ini lebih dikenal dengan istilah "postnatal", EPDS juga efektif digunakan dalam mendeteksi gejala depresi dan kecemasan selama masa kehamilan. EPDS terdiri dari 10 item pertanyaan singkat yang menggali secara mendalam mengenai suasana hati, perasaan cemas, rasa bersalah, perubahan pola tidur, kesulitan menikmati berbagai aktivitas, hingga munculnya pikiran yang berbahaya atau merugikan diri sendiri. Setiap pertanyaan diberi skor, dan skor total yang tinggi menunjukkan risiko depresi atau kecemasan yang signifikan, sehingga memerlukan evaluasi lanjutan serta intervensi khusus. EPDS sangat populer karena mudah digunakan, singkat, dan dapat diberikan dalam berbagai situasi klinis, mulai dari fasilitas kesehatan primer hingga layanan kesehatan spesialis kebidanan.

Instrumen lain yang juga banyak digunakan adalah Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS-21). Berbeda dengan EPDS yang terutama berfokus pada depresi dan kecemasan, DASS-21 mampu mengukur tiga aspek sekaligus, yaitu depresi, kecemasan, dan stres yang dialami oleh perempuan baik sebelum maupun selama kehamilan. Instrumen ini terdiri dari 21 pertanyaan yang dirancang secara khusus untuk menilai tingkat keparahan masing-masing kondisi tersebut dalam kurun waktu satu minggu terakhir. Kelebihan utama DASS-21 adalah kemampuannya memberikan informasi detail tentang kondisi emosional ibu, sehingga tenaga kesehatan dapat lebih tepat dalam menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai. Selain itu, DASS-21 juga mudah digunakan dalam berbagai setting, seperti klinik kebidanan, puskesmas, hingga rumah sakit.

Namun, alat ukur kuantitatif seperti EPDS dan DASS-21 hanyalah sebagian dari strategi deteksi dini kesehatan mental. Selain menggunakan instrumen-instrumen tersebut, tenaga kesehatan seperti bidan, perawat, maupun dokter juga sangat dianjurkan untuk melakukan wawancara klinis mendalam sebagai bagian integral dari proses penilaian kesehatan mental perempuan. Wawancara klinis mendalam bertujuan untuk menggali informasi yang lebih lengkap tentang latar belakang kehidupan perempuan, seperti kondisi keluarga, hubungan interpersonal dengan pasangan, riwayat kesehatan mental pribadi atau keluarga, pengalaman trauma masa lalu, serta kondisi sosial ekonomi. Melalui wawancara ini, tenaga kesehatan

dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang kondisi psikososial perempuan yang tidak selalu terlihat secara eksplisit melalui alat ukur kuantitatif.

Dalam wawancara klinis mendalam, keterampilan komunikasi terapeutik dari tenaga kesehatan menjadi sangat penting. Bidan atau dokter yang melakukan wawancara perlu mampu membangun hubungan yang nyaman dan penuh rasa percaya dengan perempuan, sehingga mereka merasa aman dan terbuka untuk berbagi kondisi emosionalnya secara jujur dan transparan. Pendekatan yang empatik, penuh perhatian, serta non-judgmental (tidak menghakimi) adalah kunci dalam keberhasilan wawancara klinis ini. Melalui proses wawancara yang berkualitas, tenaga kesehatan juga bisa mendeteksi gejala-gejala ringan hingga berat yang mungkin tidak tercakup oleh kuesioner tertulis, seperti kecenderungan isolasi sosial, perasaan cemas yang berkepanjangan, atau bahkan pemikiran melukai diri sendiri.

Lebih lanjut lagi, wawancara klinis mendalam juga berperan penting dalam menilai seberapa jauh faktor risiko dan protektif mempengaruhi kondisi kesehatan mental perempuan selama masa prakonsepsi maupun kehamilan. Faktor risiko yang dimaksud antara lain kurangnya dukungan sosial, tekanan ekonomi, riwayat gangguan mental dalam keluarga, serta adanya tekanan sosial terkait ekspektasi peran perempuan sebagai calon ibu. Di sisi lain, wawancara juga membantu mengidentifikasi faktor protektif yang bisa dimanfaatkan dalam intervensi selanjutnya, seperti dukungan pasangan dan keluarga, kemampuan coping positif perempuan dalam menghadapi tekanan hidup, hingga adanya sistem dukungan sosial yang baik dari lingkungan sekitar.

Selain metode instrumen standar dan wawancara klinis, observasi klinis terhadap perilaku, ekspresi emosional, dan interaksi perempuan dengan lingkungannya juga sangat penting dilakukan secara rutin. Observasi ini memungkinkan tenaga kesehatan untuk melihat secara langsung gejala-gejala nonverbal yang menunjukkan adanya gangguan mental, seperti ekspresi wajah yang sedih atau cemas secara terus menerus, sikap menarik diri dari percakapan atau aktivitas, serta perubahan drastis dalam penampilan fisik atau cara berpakaian yang mengindikasikan penurunan perhatian terhadap perawatan diri. Observasi ini memberikan informasi tambahan yang sangat berharga dalam menentukan intervensi lanjutan yang diperlukan.

Dalam pelaksanaannya, strategi deteksi dini ini harus didukung dengan pelatihan yang intensif dan berkelanjutan bagi tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelayanan kebidanan. Pelatihan tersebut mencakup pengenalan alat ukur standar, teknik wawancara klinis mendalam, komunikasi terapeutik, serta peningkatan kepekaan terhadap tanda-tanda gangguan mental. Dengan peningkatan kapasitas

ini, tenaga kesehatan dapat secara efektif melakukan deteksi dini gangguan kesehatan mental dan memberikan intervensi yang tepat waktu.

Implementasi dari strategi deteksi dini dan penilaian kesehatan mental ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi harus menjadi bagian integral dari setiap layanan kebidanan, baik di tingkat pelayanan primer seperti puskesmas maupun rumah sakit rujukan. Dengan pendekatan ini, diharapkan perempuan yang sedang dalam masa prakonsepsi atau kehamilan dapat memperoleh perhatian menyeluruh terhadap aspek mental dan emosionalnya, sehingga kualitas kesehatan mental mereka dapat dijaga secara optimal. Akhirnya, deteksi dini yang efektif akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup perempuan, menurunkan risiko komplikasi kehamilan, serta menciptakan kondisi terbaik untuk tumbuh kembang janin dan hubungan ibu-anak yang sehat di masa depan.

H. Peran Tenaga Kesehatan dalam Menjaga Kesehatan Mental Perempuan pada Masa Prakonsepsi dan Kehamilan

Tenaga kesehatan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam menjaga kesehatan mental perempuan, baik pada masa prakonsepsi maupun sepanjang periode kehamilan. Dalam konteks ini, tenaga kesehatan tidak hanya bertugas memantau kondisi fisik perempuan, tetapi juga bertanggung jawab secara aktif untuk memastikan bahwa aspek psikologis dan emosional mendapatkan perhatian khusus. Mengingat bahwa gangguan kesehatan mental yang tidak ditangani secara tepat waktu dapat berdampak serius bagi kesehatan ibu dan perkembangan janin, maka keterlibatan aktif dari tenaga kesehatan, khususnya bidan, dokter, dan psikolog, menjadi suatu keharusan.

Peran utama tenaga kesehatan dalam menjaga kesehatan mental perempuan pada masa prakonsepsi dan kehamilan adalah memberikan edukasi yang komprehensif kepada calon ibu dan keluarganya. Edukasi ini mencakup berbagai informasi mengenai perubahan emosional yang lazim dialami selama persiapan kehamilan hingga masa kehamilan berlangsung. Tenaga kesehatan harus mampu menyampaikan dengan jelas tentang tanda-tanda normal maupun abnormal yang perlu diperhatikan, misalnya gejala kecemasan, stres ringan, hingga tanda-tanda depresi yang lebih berat. Melalui edukasi yang baik, perempuan akan memiliki kesiapan mental dan emosional yang lebih baik serta mampu mengenali tanda-tanda dini gangguan mental yang dialaminya. Selain itu, edukasi juga membantu keluarga memahami pentingnya dukungan emosional terhadap calon ibu, sehingga tercipta lingkungan yang mendukung kesehatan mental perempuan secara keseluruhan.

Pendampingan psikososial merupakan peran strategis lainnya yang diemban oleh tenaga kesehatan, terutama bidan dan psikolog. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan dukungan emosional yang efektif kepada perempuan selama masa prakonsepsi hingga kehamilan. Dengan pendekatan psikososial yang empatik dan suportif, tenaga kesehatan membantu perempuan untuk mengenali, mengelola, dan mengatasi berbagai tantangan emosional yang muncul selama periode ini. Pendampingan ini tidak terbatas hanya pada sesi konseling formal, melainkan mencakup interaksi sehari-hari yang memberikan rasa nyaman, aman, dan diterima kepada perempuan, sehingga mereka dapat dengan terbuka mengungkapkan segala kekhawatiran atau kecemasan yang dirasakan. Melalui pendampingan psikososial yang tepat, perempuan akan merasa lebih percaya diri dalam menghadapi masa kehamilan, mampu mengelola stres dengan lebih efektif, serta terhindar dari dampak negatif jangka panjang akibat tekanan emosional yang tidak teratasi.

Selain edukasi dan pendampingan psikososial, tenaga kesehatan juga bertugas melakukan intervensi dini terhadap gangguan kesehatan mental yang teridentifikasi sejak masa prakonsepsi atau di awal masa kehamilan. Intervensi dini sangat penting karena semakin cepat gangguan mental diidentifikasi, semakin besar pula kemungkinan perempuan untuk pulih dan menghindari dampak yang lebih serius. Dalam praktiknya, intervensi dini dilakukan melalui berbagai metode, seperti konseling suportif yang bersifat terapeutik, teknik relaksasi sederhana, pemberian edukasi tambahan tentang manajemen stres, hingga teknik-teknik kognitif perilaku yang efektif untuk membantu perempuan mengelola kecemasan atau depresi ringan hingga sedang. Intervensi dini yang dilakukan oleh bidan atau dokter umum ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kondisi mental perempuan, serta membantu mencegah berkembangnya gangguan mental menjadi kondisi yang lebih kompleks atau berat.

Namun, tenaga kesehatan juga perlu menyadari batas kemampuan mereka dalam memberikan intervensi psikologis. Ketika kondisi gangguan mental yang dialami perempuan teridentifikasi sebagai gangguan berat atau kompleks, tenaga kesehatan memiliki tanggung jawab penting dalam melakukan rujukan yang cepat dan tepat kepada tenaga profesional kesehatan mental seperti psikolog klinis atau psikiater. Rujukan ini harus dilakukan dengan tepat waktu agar perempuan segera mendapatkan penanganan yang lebih khusus, seperti psikoterapi mendalam atau bahkan terapi farmakologi jika dibutuhkan. Dalam hal ini, kolaborasi antar tenaga kesehatan sangat penting untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan penanganan kesehatan mental yang komprehensif dan optimal.

Selain itu, tenaga kesehatan memiliki peran tambahan dalam melakukan monitoring jangka panjang terhadap kondisi kesehatan mental perempuan yang telah mengalami gangguan mental sejak masa prakonsepsi maupun selama kehamilan. Monitoring jangka panjang ini melibatkan evaluasi rutin yang dilakukan secara berkala, guna memastikan bahwa perempuan tetap berada dalam kondisi mental yang stabil, terhindar dari kambuhnya gangguan mental, serta memiliki kemampuan coping yang baik dalam menghadapi tantangan emosional selama masa kehamilan dan setelahnya. Dengan melakukan monitoring secara berkelanjutan, tenaga kesehatan tidak hanya mampu memberikan intervensi lanjutan jika diperlukan, tetapi juga memberikan rasa aman kepada perempuan, karena mengetahui bahwa dirinya selalu didukung oleh tenaga kesehatan yang peduli dan kompeten dalam menjaga kesehatan mentalnya.

Dalam melaksanakan peran-peran tersebut, tenaga kesehatan, khususnya bidan, dokter, dan psikolog, membutuhkan keterampilan komunikasi terapeutik yang kuat dan efektif. Komunikasi terapeutik memungkinkan tenaga kesehatan untuk mendengarkan secara aktif, menunjukkan empati yang mendalam, serta memberikan respons yang mendukung tanpa ada unsur penilaian atau penghakiman. Dengan demikian, perempuan akan merasa dihargai, dimengerti, dan didukung secara emosional, sehingga intervensi kesehatan mental yang dilakukan akan menjadi lebih efektif dan memberikan hasil yang optimal.

I. Pendekatan Psikososial dalam Mendukung Kesehatan Mental Perempuan

Pendekatan psikososial merupakan salah satu metode penting dalam upaya meningkatkan dan menjaga kesehatan mental perempuan, khususnya pada masa prakonsepsi dan selama kehamilan. Pendekatan ini berfokus pada interaksi antara aspek psikologis dan sosial seseorang, di mana keduanya saling mempengaruhi dan membentuk kondisi kesehatan mental secara keseluruhan. Melalui pendekatan psikososial, tenaga kesehatan dapat memberikan dukungan emosional, membantu perempuan dalam memahami dan mengelola stres, serta mendorong terbentuknya lingkungan sosial yang positif dan mendukung, sehingga perempuan dapat menjalani masa prakonsepsi dan kehamilan dengan kondisi mental yang sehat dan stabil.

Salah satu komponen penting dalam pendekatan psikososial adalah pemberian konseling psikologis. Konseling ini bertujuan untuk membantu perempuan mengeksplorasi berbagai perasaan, pikiran, kekhawatiran, maupun tantangan yang dialaminya. Dalam proses konseling, tenaga kesehatan seperti bidan atau psikolog menggunakan teknik mendengarkan aktif, di mana mereka dengan sabar dan penuh empati mendengarkan keluhan perempuan tanpa melakukan

penilaian atau memberikan kritik. Mendengarkan aktif memungkinkan perempuan merasa diterima dan dihargai, sehingga ia lebih terbuka dalam mengungkapkan masalahnya. Selain itu, konseling juga melibatkan teknik empati reflektif, di mana tenaga kesehatan membantu perempuan mengenali emosi dan perasaannya, serta memberikan pemahaman bahwa emosi yang dirasakan adalah bagian alami dari proses persiapan menjadi ibu. Konseling psikososial juga bisa menggunakan pendekatan pemecahan masalah secara kolaboratif, di mana perempuan dibimbing untuk secara mandiri menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya, sehingga rasa percaya dirinya meningkat secara signifikan.

Selain konseling, pendekatan psikososial juga mengintegrasikan berbagai teknik relaksasi yang terbukti efektif dalam menurunkan tingkat stres dan kecemasan. Teknik relaksasi ini sangat berguna, baik pada masa prakonsepsi maupun selama kehamilan, ketika perempuan mengalami berbagai tekanan fisik maupun emosional yang mungkin muncul. Beberapa contoh teknik relaksasi yang bisa diterapkan adalah latihan pernapasan dalam (deep breathing exercise), relaksasi otot progresif, serta visualisasi positif. Latihan pernapasan dalam melibatkan pengaturan napas secara perlahan dan mendalam untuk menenangkan sistem saraf, sehingga membantu perempuan mengurangi rasa cemas yang muncul akibat tekanan emosional maupun pikiran negatif. Sementara itu, relaksasi otot progresif dilakukan dengan cara menegangkan dan merilekskan otot secara sistematis, mulai dari kaki hingga kepala, untuk membantu perempuan mengenali kondisi fisik saat mengalami stres, sekaligus meningkatkan kesadaran akan kondisi tubuhnya. Teknik visualisasi positif juga efektif untuk meredakan kecemasan, yaitu dengan membayangkan situasi atau tempat yang menyenangkan dan nyaman, sehingga pikiran perempuan menjadi lebih rileks dan tenang.

Pendekatan mindfulness merupakan elemen penting lainnya dalam pendekatan psikososial yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan penerimaan perempuan terhadap kondisi emosional dan mental yang dialami saat ini. Mindfulness melibatkan latihan yang mengajarkan perempuan untuk hadir sepenuhnya dalam momen saat ini tanpa terjebak pada pikiran masa lalu atau kekhawatiran akan masa depan. Latihan mindfulness seperti meditasi sederhana atau body scan dapat membantu perempuan mengenali emosi yang sedang dirasakan, serta belajar untuk menerima dan mengelola emosi tersebut dengan lebih baik tanpa berusaha menekan atau menghindarinya. Dengan penerapan mindfulness secara rutin, perempuan dapat memiliki kemampuan coping yang lebih baik dalam menghadapi stres, serta mampu menjalani masa prakonsepsi dan kehamilan dengan kondisi mental yang lebih stabil dan positif.

Selain berbagai teknik individual tersebut, dukungan sosial juga merupakan faktor yang sangat penting dalam pendekatan psikososial. Dukungan sosial mencakup interaksi positif dengan pasangan, keluarga, teman dekat, hingga komunitas sekitar yang dapat memberikan rasa aman, nyaman, serta kepercayaan diri kepada perempuan selama masa prakonsepsi dan kehamilan. Tenaga kesehatan perlu secara aktif melibatkan keluarga atau pasangan perempuan dalam edukasi dan pendampingan yang diberikan, sehingga mereka memahami pentingnya dukungan sosial dalam menjaga kesehatan mental perempuan. Dukungan sosial dapat berupa dukungan emosional, seperti memberikan perhatian, empati, dan dorongan positif kepada perempuan, maupun dukungan praktis seperti membantu dalam aktivitas sehari-hari, mendampingi selama kunjungan medis, atau sekadar menyediakan waktu untuk berbicara dan berbagi perasaan. Kehadiran dukungan sosial yang kuat terbukti secara signifikan membantu perempuan mengurangi perasaan terisolasi, stres, atau kecemasan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan mental secara keseluruhan.

Lebih lanjut, pendekatan psikososial juga sering melibatkan program atau aktivitas kelompok, seperti kelas prenatal atau kelompok pendukung ibu hamil dan calon ibu. Kegiatan kelompok ini menyediakan wadah bagi perempuan untuk bertemu dan berbagi pengalaman dengan perempuan lain yang memiliki kondisi atau tantangan serupa. Dalam kelompok ini, perempuan merasa lebih dimengerti dan tidak merasa sendirian dalam menghadapi tantangan emosional maupun psikologis yang dialami selama masa prakonsepsi dan kehamilan. Interaksi sosial dalam kelompok ini juga memberikan peluang bagi perempuan untuk saling memberikan motivasi, saran praktis, serta dukungan emosional yang berharga, sehingga secara keseluruhan membantu memperkuat resiliensi dan kesejahteraan mental perempuan.

Dalam implementasinya, pendekatan psikososial tidak berdiri sendiri, melainkan saling melengkapi dengan pendekatan medis atau klinis yang juga diperlukan selama masa prakonsepsi maupun kehamilan. Tenaga kesehatan perlu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang baik dalam menerapkan pendekatan psikososial, sehingga mampu memberikan dukungan mental yang tepat sesuai dengan kebutuhan masing-masing perempuan. Oleh karena itu, pelatihan rutin dan berkelanjutan dalam pendekatan psikososial bagi tenaga kesehatan menjadi sangat penting agar implementasi di lapangan benar-benar efektif dan berdampak positif bagi perempuan dan keluarganya.

J. Tantangan dan Solusi dalam Mengintegrasikan Layanan Kesehatan Mental dalam Pelayanan Prakonsepsi dan Antenatal

Integrasi layanan kesehatan mental dalam pelayanan kesehatan perempuan selama masa prakonsepsi dan kehamilan merupakan suatu kebutuhan yang semakin mendesak mengingat dampaknya yang sangat besar terhadap kesehatan ibu dan janin. Namun, implementasi layanan ini di lapangan masih menemui berbagai hambatan yang cukup kompleks, baik dari aspek internal tenaga kesehatan, aspek eksternal lingkungan masyarakat, hingga fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mendalam mengenai berbagai tantangan yang dihadapi serta solusi praktis yang bisa diimplementasikan secara efektif untuk mengatasinya.

Salah satu tantangan paling signifikan yang dihadapi adalah minimnya pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan terkait kesehatan mental maternal. Banyak tenaga kesehatan, khususnya bidan, perawat, atau dokter umum yang berada di garis depan pelayanan kesehatan, belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai pentingnya kesehatan mental dalam masa prakonsepsi dan kehamilan. Mereka sering kali lebih fokus pada aspek medis atau fisik seperti pemantauan pertumbuhan janin, pemeriksaan laboratorium, ataupun penanganan keluhan fisik ibu, sementara aspek emosional dan psikologis dianggap sebagai isu yang sekunder atau bahkan tidak relevan. Kondisi ini menyebabkan deteksi dini terhadap gangguan mental sering kali terlambat atau bahkan tidak dilakukan sama sekali, sehingga intervensi yang tepat waktu tidak bisa dilaksanakan.

Selain minimnya pengetahuan, tantangan lain yang juga kerap ditemukan adalah kurangnya keterampilan praktis dalam melakukan intervensi psikososial dasar. Banyak tenaga kesehatan merasa tidak percaya diri ketika dihadapkan dengan situasi di mana ibu menunjukkan tanda-tanda gangguan mental seperti kecemasan, depresi, atau stres berat. Mereka juga sering mengalami kesulitan dalam melakukan wawancara klinis yang efektif atau menggunakan instrumen skrining kesehatan mental seperti EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale) dan DASS-21 (Depression, Anxiety, and Stress Scale). Akibatnya, layanan kesehatan mental menjadi tidak optimal, bahkan cenderung terabaikan sama sekali dalam proses pelayanan kesehatan yang mereka berikan.

Selain faktor internal tenaga kesehatan, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah adanya stigma sosial yang masih kuat di masyarakat terhadap gangguan mental. Banyak perempuan yang enggan atau takut untuk mengungkapkan kondisi emosional atau gangguan mental yang mereka alami karena khawatir dianggap lemah atau mendapatkan label negatif dari keluarga maupun masyarakat sekitar. Stigma ini tidak hanya mempengaruhi sikap perempuan

dalam mencari bantuan, tetapi juga menciptakan hambatan bagi tenaga kesehatan dalam memberikan intervensi kesehatan mental secara terbuka. Akibatnya, banyak kasus gangguan mental yang seharusnya bisa ditangani secara dini justru tidak terdeteksi hingga akhirnya berkembang menjadi kondisi yang lebih serius dan kompleks.

Di sisi lain, keterbatasan fasilitas kesehatan juga menjadi tantangan nyata dalam implementasi layanan kesehatan mental pada masa prakonsepsi dan kehamilan. Fasilitas pelayanan kesehatan primer, seperti puskesmas atau klinik kebidanan, sering kali tidak dilengkapi dengan ruang khusus konseling atau bahkan tidak memiliki tenaga profesional kesehatan mental yang memadai seperti psikolog atau psikiater. Kondisi ini menyebabkan layanan kesehatan mental sering kali tidak tersedia di tingkat layanan primer, sehingga perempuan yang mengalami gangguan mental harus menunggu lama untuk mendapatkan rujukan ke layanan kesehatan tingkat lanjut. Selain itu, minimnya alat ukur atau instrumen deteksi gangguan mental yang tersedia di fasilitas kesehatan juga menjadi tantangan tersendiri, karena hal ini menyulitkan tenaga kesehatan dalam melakukan skrining dan deteksi dini secara sistematis.

Menyadari berbagai tantangan tersebut, dibutuhkan solusi yang komprehensif dan terintegrasi untuk memastikan bahwa layanan kesehatan mental dapat menjadi bagian integral dalam pelayanan kesehatan prakonsepsi dan antenatal. Solusi pertama yang harus dilakukan adalah peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui program pendidikan dan pelatihan yang rutin dan berkelanjutan. Pelatihan ini mencakup pemberian pemahaman dasar mengenai pentingnya kesehatan mental maternal, teknik wawancara klinis empati, penggunaan instrumen deteksi dini seperti EPDS dan DASS-21 secara efektif, serta pelatihan dalam berbagai teknik intervensi psikososial dasar seperti konseling suportif, teknik relaksasi, dan mindfulness. Dengan peningkatan kapasitas ini, tenaga kesehatan diharapkan lebih percaya diri dan kompeten dalam memberikan layanan kesehatan mental yang berkualitas.

Solusi kedua adalah mengurangi stigma sosial terhadap gangguan mental melalui edukasi masyarakat yang luas dan berkelanjutan. Kampanye kesehatan mental melalui media sosial, penyuluhan masyarakat, seminar, dan kegiatan komunitas perlu dilakukan secara intensif dan sistematis. Dalam proses ini, keluarga, tokoh masyarakat, serta pemuka agama juga perlu dilibatkan secara aktif agar mereka mampu memberikan pemahaman yang positif tentang pentingnya menjaga kesehatan mental, terutama pada perempuan yang sedang mempersiapkan kehamilan atau sedang hamil. Dengan mengurangi stigma sosial, perempuan akan

lebih nyaman dan terbuka dalam mengungkapkan kondisi mentalnya kepada tenaga kesehatan.

Solusi ketiga adalah advokasi kebijakan kepada pemerintah dan institusi terkait untuk menyediakan fasilitas yang lebih memadai dalam pelayanan kesehatan mental maternal. Hal ini meliputi pembangunan ruang khusus konseling yang nyaman di setiap fasilitas pelayanan primer, pengadaan alat ukur deteksi gangguan mental yang standar, serta penyediaan tenaga profesional kesehatan mental, seperti psikolog atau psikiater, yang dapat memberikan layanan lebih lanjut atau menerima rujukan secara cepat dan tepat. Dukungan kebijakan yang kuat dari pemerintah akan sangat membantu dalam mempercepat integrasi layanan kesehatan mental dalam praktik pelayanan kesehatan prakonsepsi dan antenatal.

Selain itu, solusi lainnya adalah memperkuat kolaborasi interprofesional antar tenaga kesehatan, seperti antara bidan, dokter umum, dokter spesialis kandungan, psikolog, hingga psikiater. Kolaborasi yang kuat ini akan memastikan bahwa tanggung jawab deteksi dini, intervensi awal, hingga penanganan lanjutan terhadap gangguan mental tidak hanya terbatas pada satu profesi saja, tetapi menjadi tanggung jawab bersama yang didukung oleh jaringan yang luas. Kolaborasi ini juga bisa diwujudkan dalam bentuk pembentukan tim kesehatan mental maternal yang terintegrasi, yang dapat bekerja secara efektif dalam memberikan layanan komprehensif kepada perempuan yang membutuhkan.

Terakhir, pendekatan berbasis komunitas juga menjadi solusi efektif dalam menghadapi keterbatasan sumber daya, terutama waktu dan tenaga kesehatan. Pendekatan ini melibatkan kelompok-kelompok dukungan ibu hamil atau calon ibu yang didampingi oleh tenaga kesehatan, di mana edukasi dan konseling bisa dilakukan secara kolektif dalam kelompok tersebut. Melalui pendekatan ini, perempuan mendapatkan manfaat berupa dukungan sosial yang kuat dari anggota kelompok lainnya, sekaligus edukasi dan intervensi kesehatan mental secara efektif dalam waktu yang lebih efisien.

K. Simpulan

Kesehatan mental perempuan selama masa prakonsepsi dan kehamilan merupakan aspek penting yang sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup perempuan, kesehatan ibu dan janin, serta kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Masa prakonsepsi merupakan periode kritis yang menuntut kesiapan mental, emosional, dan fisik perempuan sebelum memasuki kehamilan. Persiapan mental yang baik membantu perempuan menghadapi berbagai perubahan fisik maupun psikologis yang muncul selama kehamilan. Sebaliknya, gangguan mental yang terjadi sejak masa prakonsepsi seperti kecemasan terkait infertilitas, depresi

prakonsepsi, dan stres kronis dapat berdampak negatif terhadap fertilitas, kondisi fisik, kesiapan emosional, hingga risiko komplikasi selama kehamilan.

Selama masa kehamilan, perempuan menghadapi perubahan kompleks berupa tantangan fisik, emosional, dan sosial yang membutuhkan kestabilan mental yang tinggi. Gangguan kesehatan mental selama kehamilan seperti depresi prenatal, kecemasan berlebihan, dan stres kronis tidak hanya berdampak buruk terhadap kesehatan ibu, tetapi juga terhadap pertumbuhan janin. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan seperti preeklampsia, diabetes gestasional, kelahiran prematur, serta gangguan perkembangan saraf dan emosional pada anak di masa mendatang.

Oleh karena itu, deteksi dini dan intervensi kesehatan mental sejak masa prakonsepsi hingga selama kehamilan merupakan langkah penting yang harus diintegrasikan dalam pelayanan kesehatan maternal secara holistik. Tenaga kesehatan, khususnya bidan, dokter, dan psikolog, memegang peran strategis dalam memberikan edukasi, konseling psikososial, intervensi dini, serta melakukan rujukan tepat waktu kepada profesional kesehatan mental jika diperlukan. Berbagai pendekatan psikososial seperti konseling individual, teknik relaksasi, mindfulness, serta penguatan dukungan sosial menjadi solusi efektif dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan mental perempuan selama periode ini.

Namun demikian, integrasi layanan kesehatan mental dalam pelayanan kesehatan maternal masih menghadapi beberapa tantangan utama, antara lain minimnya pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan, stigma sosial di masyarakat, dan keterbatasan fasilitas layanan kesehatan. Solusi untuk mengatasi tantangan tersebut meliputi peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan rutin, edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma sosial, advokasi kebijakan yang mendukung, penguatan kolaborasi interprofesional, serta implementasi pendekatan berbasis komunitas.

L. Referensi

- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2018). Screening for perinatal depression (Committee Opinion No. 757). *Obstetrics & Gynecology*, 132(5), e208–e212. <https://doi.org/10.1097/aog.0000000000002927>
- Bayrampour, H., Hapsari, A. P., & Pavlovic, J. (2018). Barriers to addressing perinatal mental health issues in midwifery settings. *Midwifery*, 59, 47–58. <https://doi.org/10.1016/j.midw.2017.12.020>
- Dennis, C.-L., Falah-Hassani, K., & Shiri, R. (2017). Prevalence of antenatal and

postnatal anxiety: Systematic review and meta-analysis. *The British Journal of Psychiatry*, 210(5), 315–323. <https://doi.org/10.1192/bjp.bp.116.187179>

Kingston, D., Tough, S., & Whitfield, H. (2012). Prenatal and postpartum maternal psychological distress and infant development: A systematic review. *Child Psychiatry & Human Development*, 43(5), 683–714. <https://doi.org/10.1007/s10578-012-0291-4>

Lancaster, C. A., Gold, K. J., Flynn, H. A., Yoo, H., Marcus, S. M., & Davis, M. M. (2010). Risk factors for depressive symptoms during pregnancy: A systematic review. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 202(1), 5–14. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2009.09.007>

NICE. (2014). Antenatal and postnatal mental health: Clinical management and service guidance (CG192). National Institute for Health and Care Excellence. Retrieved from <https://www.nice.org.uk/guidance/cg192>

O'Hara, M. W., & Wisner, K. L. (2014). Perinatal mental illness: Definition, description and aetiology. *Best Practice & Research Clinical Obstetrics & Gynaecology*, 28(1), 3–12. <https://doi.org/10.1016/j.bpobgyn.2013.09.002>

Robertson, E., Grace, S., Wallington, T., & Stewart, D. E. (2004). Antenatal risk factors for postpartum depression: A synthesis of recent literature. *General Hospital Psychiatry*, 26(4), 289–295. <https://doi.org/10.1016/j.genhosppsych.2004.02.006>

Räisänen, S., Lehto, S. M., Nielsen, H. S., Gissler, M., Kramer, M. R., & Heinonen, S. (2014). Risk factors for and perinatal outcomes of major depression during pregnancy: A population-based analysis. *Journal of Affective Disorders*, 160, 135–140. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2014.02.005>

Van den Bergh, B. R. H., van den Heuvel, M. I., Lahti, M., Braeken, M., de Rooij, S. R., Entringer, S., ... Schwab, M. (2020). Prenatal developmental origins of behavior and mental health: The influence of maternal stress in pregnancy. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*, 117, 26–64. <https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2017.07.003>

World Health Organization. (2018). WHO recommendations on antenatal care for a positive pregnancy experience. World Health Organization. Retrieved from <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250796/9789241549912-eng.pdf>

M. Glosarium

- **Depresi prenatal**

Gangguan suasana hati yang ditandai oleh perasaan sedih mendalam, hilangnya minat, kelelahan, gangguan tidur, dan pola pikir negatif yang terjadi selama masa kehamilan.

- **Kecemasan prenatal**

Kondisi psikologis yang ditandai oleh rasa khawatir yang intens mengenai kesehatan janin, proses persalinan, atau peran baru sebagai ibu, disertai gejala fisik seperti gangguan tidur, jantung berdebar, hingga gangguan pencernaan.

- **Stres kronis**

Kondisi stres yang berlangsung dalam waktu lama, disebabkan oleh berbagai tekanan berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat mengganggu keseimbangan hormon dan fungsi fisiologis tubuh.

- **Masa prakonsepsi**

Periode sebelum seorang perempuan hamil, di mana perempuan melakukan persiapan fisik, mental, dan emosional untuk menghadapi kehamilan.

- **Pendekatan psikososial**

Metode intervensi yang melibatkan aspek psikologis dan sosial secara bersamaan, dengan tujuan mendukung kesehatan mental seseorang melalui konseling, relaksasi, mindfulness, dan dukungan sosial.

- **Mindfulness**

Latihan mental yang meningkatkan kesadaran seseorang untuk hadir sepenuhnya pada momen sekarang tanpa penilaian, dengan tujuan mengelola stres, kecemasan, atau emosi negatif lainnya.

- **Intervensi dini**

Upaya untuk mengidentifikasi dan menangani gangguan mental sesegera mungkin, sebelum berkembang menjadi kondisi yang lebih serius.

- **Kesehatan mental maternal**

Kondisi psikologis dan emosional perempuan yang terkait erat dengan kesejahteraan selama masa prakonsepsi, kehamilan, dan pascapersalinan.

- **Neuroendokrin**

Sistem komunikasi yang menghubungkan otak dengan kelenjar endokrin, berperan dalam pengaturan hormon tubuh, termasuk siklus menstruasi dan kesuburan, yang dipengaruhi oleh kondisi psikologis seseorang.

- **Deteksi dini kesehatan mental**

Proses pengenalan gejala awal gangguan mental dengan menggunakan instrumen standar (misalnya EPDS dan DASS-21), wawancara klinis, serta observasi perilaku untuk mencegah gangguan mental berkembang lebih lanjut.

CHAPTER 3

MANAJEMEN DEPRESI POSTPARTUM BERBASIS BUKTI

Fitria Jannatul Laili, S.Keb., Bd., M.M., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Depresi postpartum merupakan kondisi kesehatan mental yang dialami oleh perempuan setelah melahirkan, ditandai dengan perasaan sedih mendalam, kehilangan minat terhadap berbagai aktivitas yang sebelumnya dinikmati, munculnya rasa lelah berlebihan, gangguan tidur, perubahan pola makan, serta perasaan bersalah yang menetap. Gangguan ini umumnya mulai muncul dalam waktu beberapa minggu setelah persalinan dan dapat berlangsung hingga beberapa bulan, bahkan lebih lama lagi jika tidak segera mendapatkan penanganan yang tepat. Depresi postpartum perlu dibedakan dari kondisi yang lebih ringan dan sementara, seperti baby blues, yang biasanya hanya bertahan beberapa hari atau minggu dan tidak mengganggu fungsi sehari-hari secara signifikan.

Secara global, prevalensi depresi postpartum cukup tinggi. Berbagai studi melaporkan bahwa sekitar 10 hingga 20 persen perempuan mengalami kondisi ini setelah persalinan, meskipun angka tersebut dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya, serta metode penelitian yang digunakan. Di Indonesia sendiri, prevalensi depresi postpartum juga cukup signifikan, dengan angka yang diperkirakan mencapai sekitar 15 hingga 20 persen. Meskipun prevalensi cukup tinggi, sayangnya masih banyak kasus yang tidak terdeteksi secara dini akibat kurangnya kesadaran, minimnya skrining kesehatan mental postpartum, serta stigma sosial yang melekat pada gangguan kesehatan mental di masyarakat.

Karena prevalensinya yang tinggi serta dampak serius yang ditimbulkan terhadap kualitas hidup ibu maupun tumbuh kembang bayi, manajemen depresi postpartum perlu dilakukan dengan pendekatan yang berbasis bukti (evidence-based practice). Pendekatan berbasis bukti ini berarti bahwa setiap tindakan atau intervensi yang diberikan harus didasarkan pada hasil penelitian ilmiah terkini yang telah terbukti efektif melalui pengujian ketat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan yang mengalami depresi postpartum mendapatkan penanganan terbaik yang mampu memulihkan kondisi mentalnya secara optimal, sekaligus meminimalkan risiko komplikasi jangka panjang.

Penerapan manajemen berbasis bukti dalam menangani depresi postpartum sangat penting karena kondisi ini tidak hanya berpengaruh terhadap kesejahteraan

mental dan fisik ibu, tetapi juga berdampak luas pada perkembangan bayi dan dinamika keluarga secara keseluruhan. Ibu yang mengalami depresi postpartum seringkali menghadapi kesulitan dalam membangun ikatan emosional yang kuat dengan bayinya, sehingga bayi berisiko mengalami gangguan dalam perkembangan emosi dan kognitifnya di masa depan. Selain itu, depresi postpartum yang tidak ditangani dengan baik juga meningkatkan risiko gangguan hubungan dalam keluarga, termasuk meningkatnya konflik dengan pasangan, perasaan terisolasi, serta kesulitan dalam menjalankan peran sehari-hari sebagai ibu maupun anggota keluarga lainnya.

Pendekatan berbasis bukti juga memberikan manfaat besar bagi tenaga kesehatan. Dengan mengacu pada bukti ilmiah terkini, tenaga kesehatan seperti dokter, bidan, psikolog, maupun perawat akan mampu mengidentifikasi, mendiagnosis, dan memberikan intervensi yang lebih tepat sasaran. Pendekatan ini memastikan bahwa tindakan medis maupun psikologis yang diberikan adalah yang paling efektif, efisien, aman, dan didukung oleh data serta hasil penelitian yang kuat. Dengan demikian, hasil akhir yang diharapkan berupa pemulihan kesehatan mental ibu secara maksimal akan lebih mudah tercapai.

Lebih jauh lagi, penggunaan pendekatan berbasis bukti dalam manajemen depresi postpartum juga menjadi fondasi penting dalam pengambilan keputusan klinis. Dengan berpedoman pada data penelitian yang sudah teruji, tenaga kesehatan dapat menentukan bentuk intervensi apa yang paling sesuai untuk kondisi dan kebutuhan setiap individu. Misalnya, dalam beberapa kasus, terapi psikologis seperti Cognitive Behavioral Therapy (CBT) atau Interpersonal Psychotherapy (IPT) mungkin menjadi pilihan terbaik berdasarkan bukti klinis yang ada. Di sisi lain, pada kasus yang lebih berat atau yang tidak merespon terapi psikologis saja, penggunaan terapi farmakologis dengan antidepresan tertentu bisa menjadi opsi terbaik dengan pertimbangan keamanan bagi ibu dan bayi.

Selain itu, pendekatan berbasis bukti juga berfungsi sebagai landasan bagi kebijakan kesehatan mental maternal yang lebih luas. Dengan adanya bukti ilmiah yang kuat mengenai efektivitas skrining, intervensi psikologis, farmakologis, serta dukungan sosial yang efektif, pemerintah dan institusi kesehatan dapat mengembangkan kebijakan yang tepat sasaran dan berbasis data. Hal ini mencakup kebijakan mengenai integrasi layanan kesehatan mental ke dalam pelayanan kesehatan maternal secara rutin, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan, hingga pengadaan instrumen skrining yang valid dan terstandar secara nasional.

B. Etiologi dan Faktor Risiko Depresi Postpartum

Depresi postpartum adalah kondisi yang sangat kompleks, di mana penyebabnya tidak bisa dijelaskan secara tunggal. Kondisi ini muncul akibat kombinasi berbagai faktor yang saling terkait, baik dari aspek biologis, psikososial, riwayat kesehatan mental sebelumnya, maupun pengalaman perempuan selama masa kehamilan dan proses persalinan. Memahami berbagai faktor tersebut secara mendalam akan membantu dalam pengelolaan depresi postpartum secara lebih efektif.

Faktor pertama yang sangat berpengaruh dalam terjadinya depresi postpartum adalah faktor biologis dan hormonal. Setelah persalinan, perempuan mengalami perubahan hormon yang sangat drastis, terutama hormon estrogen dan progesteron. Selama masa kehamilan, kadar kedua hormon ini meningkat tajam untuk mendukung pertumbuhan janin. Namun, sesaat setelah melahirkan, kadar hormon estrogen dan progesteron tiba-tiba menurun drastis hingga kembali ke tingkat sebelum hamil. Perubahan mendadak ini diyakini dapat menyebabkan ketidakseimbangan kimiawi dalam otak, khususnya neurotransmiter seperti serotonin dan dopamin, yang berperan penting dalam mengatur suasana hati, emosi, serta kondisi mental secara keseluruhan. Kondisi ini menyebabkan perempuan menjadi lebih rentan terhadap munculnya gangguan suasana hati, termasuk depresi postpartum. Selain itu, perubahan hormonal tersebut juga dapat berpengaruh pada hormon stres seperti kortisol, yang dalam kadar tinggi akan memperparah gejala depresi.

Selain faktor biologis, faktor psikososial dan lingkungan juga memegang peran yang sangat penting dalam perkembangan depresi postpartum. Kondisi sosial dan lingkungan perempuan sangat menentukan bagaimana ia menghadapi berbagai tekanan selama masa transisi menjadi seorang ibu. Tekanan psikososial seperti hubungan interpersonal yang kurang harmonis dengan pasangan atau keluarga, isolasi sosial, rendahnya dukungan emosional, serta tuntutan peran sosial baru sebagai ibu, dapat menjadi pemicu kuat munculnya depresi postpartum. Lingkungan yang kurang mendukung, di mana perempuan merasa tidak mendapatkan perhatian atau pengertian dari pasangan, keluarga, maupun komunitas di sekitarnya, sering kali memperbesar rasa kesepian, kelelahan emosional, dan kecemasan. Kondisi psikologis seperti rasa bersalah karena merasa tidak mampu merawat bayi dengan optimal, rasa cemas terhadap kemampuan menjalankan peran baru, hingga kehilangan identitas diri sebelumnya juga menjadi aspek psikososial yang penting dalam menyebabkan depresi postpartum. Secara khusus, perempuan yang hidup dalam kondisi ekonomi kurang stabil juga

menghadapi tekanan psikologis lebih tinggi, sehingga lebih rentan mengalami depresi postpartum.

Selanjutnya, riwayat kesehatan mental sebelumnya merupakan salah satu faktor risiko terpenting dalam menentukan kemungkinan seorang perempuan mengalami depresi postpartum. Perempuan dengan riwayat gangguan kesehatan mental, seperti depresi sebelumnya, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, atau gangguan mood lainnya, memiliki risiko yang jauh lebih tinggi mengalami depresi postpartum dibandingkan dengan perempuan tanpa riwayat gangguan mental. Hal ini dikarenakan adanya kecenderungan biologis dan psikologis dalam tubuh mereka yang telah rentan terhadap perubahan kimiawi di otak maupun ketidakstabilan emosional. Terlebih lagi, perempuan yang pernah mengalami depresi postpartum pada kehamilan atau persalinan sebelumnya juga berisiko tinggi untuk kembali mengalami kondisi yang sama di kehamilan berikutnya. Oleh karena itu, deteksi dini dan pemantauan ketat terhadap perempuan dengan riwayat gangguan mental sebelumnya sangat penting untuk mencegah terjadinya depresi postpartum yang berat.

Di samping itu, pengalaman perempuan yang terkait dengan proses kehamilan dan persalinan juga memiliki hubungan erat dengan risiko terjadinya depresi postpartum. Kehamilan yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan sering kali menimbulkan tekanan emosional dan konflik batin yang cukup besar pada perempuan, sehingga meningkatkan risiko gangguan kesehatan mental setelah melahirkan. Selain itu, pengalaman negatif selama proses persalinan seperti komplikasi medis, persalinan yang sulit atau traumatis, atau bahkan persalinan caesar yang tidak diinginkan juga menjadi pemicu signifikan munculnya depresi postpartum. Trauma yang terjadi selama persalinan dapat menimbulkan perasaan takut, kehilangan kontrol, serta menurunkan rasa percaya diri perempuan dalam menjalani peran baru sebagai seorang ibu. Pengalaman-pengalaman negatif tersebut, jika tidak segera diatasi melalui konseling atau intervensi psikologis yang tepat, dapat berkembang menjadi depresi postpartum yang serius.

C. Identifikasi dan Skrining Depresi Postpartum Berbasis Bukti

Proses identifikasi dan skrining merupakan langkah awal yang sangat penting dalam manajemen depresi postpartum berbasis bukti. Tujuan utama dari tahap ini adalah untuk mendeteksi secara dini gejala depresi postpartum agar intervensi dapat segera diberikan sebelum kondisi mental ibu menjadi semakin berat dan sulit ditangani. Dalam praktik klinis, proses ini dilakukan secara sistematis dengan memanfaatkan berbagai metode dan instrumen yang terbukti valid dan reliabel secara klinis.

Salah satu pendekatan utama dalam identifikasi depresi postpartum adalah melalui penggunaan instrumen skrining terstandar. Instrumen-instrumen yang paling umum digunakan adalah Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS-21), dan Postpartum Depression Screening Scale (PDSS). Ketiga instrumen ini telah terbukti efektif dalam mendeteksi gejala depresi postpartum dan telah digunakan secara luas di berbagai negara dengan tingkat akurasi yang tinggi.

Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) merupakan instrumen yang paling sering digunakan dalam konteks kesehatan maternal dan kebidanan. EPDS terdiri dari 10 pertanyaan yang secara khusus dirancang untuk menilai berbagai gejala yang umum dialami perempuan pada periode postpartum, seperti perasaan sedih, cemas, kehilangan minat terhadap aktivitas yang sebelumnya dinikmati, rasa bersalah, perubahan pola tidur, hingga munculnya pikiran negatif atau berbahaya terhadap diri sendiri maupun bayinya. Setiap pertanyaan pada EPDS dinilai dengan skala angka, di mana total skor yang diperoleh menentukan apakah seorang ibu memiliki risiko tinggi mengalami depresi postpartum atau tidak. Instrumen ini populer karena penggunaannya yang sederhana, cepat, dan mudah dipahami oleh pasien, sehingga sangat efektif digunakan bahkan di fasilitas kesehatan primer seperti klinik kebidanan atau puskesmas.

Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS-21) juga merupakan instrumen skrining yang sangat bermanfaat karena mampu mengukur tiga dimensi penting sekaligus, yakni depresi, kecemasan, dan stres. DASS-21 terdiri dari 21 item pertanyaan yang menggali perasaan ibu selama satu minggu terakhir terkait aspek emosionalnya secara lebih komprehensif. Keunggulan instrumen ini adalah memberikan gambaran yang lebih luas tentang kondisi mental ibu postpartum, sehingga tenaga kesehatan dapat menentukan intervensi yang paling sesuai berdasarkan tingkat keparahan dan jenis gangguan yang dialami. Penggunaan DASS-21 sangat efektif ketika tenaga kesehatan ingin menilai tidak hanya gejala depresi, tetapi juga kondisi kecemasan atau stres yang sering menyertai depresi postpartum.

Sementara itu, Postpartum Depression Screening Scale (PDSS) merupakan instrumen yang secara khusus dirancang untuk menilai kondisi emosional ibu setelah melahirkan. PDSS terdiri dari 35 pertanyaan yang mencakup aspek kognitif, emosional, perilaku, hingga interaksi ibu-bayi. Instrumen ini memberikan informasi lebih rinci mengenai berbagai dimensi gejala depresi postpartum, seperti perubahan suasana hati, gangguan pola tidur, rasa cemas terhadap kesehatan bayi, perasaan tidak mampu menjadi ibu yang baik, hingga masalah dalam interaksi dengan bayi. PDSS sangat berguna dalam konteks klinis yang lebih mendalam atau ketika tenaga

kesehatan ingin mendapatkan informasi lebih komprehensif tentang gejala depresi postpartum yang dialami ibu.

Selain penggunaan instrumen standar, teknik wawancara klinis mendalam juga merupakan komponen penting dalam identifikasi depresi postpartum berbasis bukti. Wawancara ini dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih, seperti bidan, psikolog, atau psikiater, dengan tujuan untuk mengeksplorasi kondisi psikologis dan emosional ibu secara lebih detail. Dalam wawancara klinis mendalam, tenaga kesehatan akan mengajukan pertanyaan terbuka dan reflektif yang memungkinkan ibu untuk mengungkapkan secara jujur apa yang dirasakannya. Proses wawancara ini mencakup penggalan riwayat kesehatan mental sebelumnya, kondisi keluarga, kualitas hubungan interpersonal dengan pasangan dan lingkungan sosial, pengalaman selama kehamilan dan persalinan, serta berbagai perasaan negatif atau ketakutan yang dialami ibu saat ini. Keberhasilan wawancara klinis sangat bergantung pada kemampuan tenaga kesehatan dalam membangun hubungan terapeutik yang baik, yaitu menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan empatik, sehingga ibu merasa didengarkan, dipahami, dan tidak merasa dihakimi.

Observasi klinis juga merupakan pendekatan penting dalam identifikasi depresi postpartum. Observasi dilakukan untuk mengenali tanda-tanda nonverbal yang mungkin tidak terungkap melalui wawancara atau instrumen tertulis. Dalam observasi klinis, tenaga kesehatan memperhatikan ekspresi wajah, sikap tubuh, interaksi ibu dengan bayi maupun orang di sekitarnya, serta perubahan perilaku yang menunjukkan adanya gejala depresi, seperti ekspresi wajah yang datar, sedih, atau terlihat lelah secara terus-menerus, ibu yang sering menarik diri dari aktivitas atau kontak sosial, hingga kesulitan dalam merawat bayi. Observasi ini sangat membantu dalam mendeteksi gejala depresi postpartum secara dini, terutama jika ibu merasa malu atau enggan mengungkapkan perasaan negatifnya secara verbal.

Selain itu, mengenali tanda-tanda peringatan dini merupakan bagian penting dari observasi klinis yang tidak boleh diabaikan. Tanda-tanda peringatan dini depresi postpartum bisa berupa perubahan mendadak dalam pola tidur atau makan, ketidakmampuan ibu dalam menjalani aktivitas sehari-hari secara normal, kurangnya minat terhadap perawatan bayi, sering menangis tanpa alasan yang jelas, hingga munculnya perasaan tidak berharga atau pikiran negatif yang terus menerus tentang diri sendiri maupun bayinya. Jika tanda-tanda ini terdeteksi secara dini, maka intervensi bisa segera dilakukan untuk mencegah gejala depresi berkembang menjadi lebih serius atau bahkan membahayakan keselamatan ibu dan bayi.

D. Strategi Intervensi Psikologis Berbasis Bukti

Strategi intervensi psikologis berbasis bukti dalam manajemen depresi postpartum memainkan peran krusial untuk membantu ibu pulih dari gangguan emosional yang dialami setelah melahirkan. Intervensi psikologis merupakan pendekatan utama yang direkomendasikan karena terbukti efektif dalam mengatasi berbagai aspek psikologis yang menjadi sumber depresi postpartum, serta memberikan dampak positif jangka panjang bagi kesehatan mental ibu dan hubungan ibu-bayi.

Salah satu bentuk intervensi yang paling banyak digunakan dan direkomendasikan adalah Cognitive Behavioral Therapy (CBT). CBT merupakan terapi psikologis terstruktur yang secara spesifik menargetkan pikiran-pikiran negatif, distorsi kognitif, serta pola perilaku maladaptif yang mendasari depresi postpartum. Dalam praktiknya, CBT dilakukan melalui sesi individual maupun kelompok, di mana terapis membantu ibu mengidentifikasi pola pikir yang keliru atau negatif, seperti perasaan tidak mampu merawat bayi, pikiran bahwa dirinya bukan ibu yang baik, hingga rasa bersalah berlebihan. Setelah pola pikir tersebut teridentifikasi, ibu kemudian dibimbing untuk mengubah pola pikirnya menjadi lebih realistis, konstruktif, dan positif melalui berbagai teknik seperti restrukturisasi kognitif, aktivitas pemantauan pikiran otomatis (thought record), hingga latihan perilaku yang membantu meningkatkan aktivitas positif sehari-hari. Penelitian menunjukkan bahwa CBT mampu mengurangi gejala depresi postpartum secara signifikan, meningkatkan kepercayaan diri ibu dalam menjalani peran barunya, serta memperbaiki kualitas hubungan interpersonal, termasuk hubungan dengan bayinya.

Selain CBT, pendekatan yang juga banyak diterapkan dalam konteks depresi postpartum adalah Interpersonal Psychotherapy (IPT). IPT adalah terapi psikologis yang menekankan pada hubungan interpersonal dan dukungan sosial sebagai faktor utama dalam mengatasi depresi postpartum. Terapi ini didasarkan pada pemahaman bahwa gangguan depresi sering kali terkait erat dengan konflik interpersonal, kurangnya dukungan sosial, atau perubahan besar dalam peran kehidupan, seperti menjadi seorang ibu baru. IPT berfokus pada empat area utama, yakni transisi peran (role transition), konflik interpersonal, duka cita (grief), dan defisit interpersonal (social isolation). Terapis bekerja bersama ibu untuk mengeksplorasi masalah dalam hubungan interpersonalnya, seperti konflik dengan pasangan atau keluarga, isolasi sosial, atau kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan peran barunya sebagai seorang ibu. IPT membantu ibu membangun keterampilan komunikasi yang lebih baik, memperkuat dukungan sosial, serta mengembangkan strategi efektif dalam menghadapi perubahan peran yang dialami. Hasil berbagai penelitian menunjukkan bahwa IPT secara efektif mengurangi gejala

depresi postpartum, meningkatkan kualitas hubungan sosial ibu, serta membantu ibu menyesuaikan diri dengan lebih baik terhadap tantangan emosional dan sosial setelah melahirkan.

Intervensi psikologis lain yang juga sering diberikan dalam konteks depresi postpartum adalah konseling suportif, baik secara individual maupun kelompok. Konseling suportif bertujuan untuk memberikan dukungan emosional, mengurangi rasa isolasi yang sering dialami ibu postpartum, serta membantu ibu mengatasi berbagai tekanan psikologis yang muncul dalam masa transisi setelah melahirkan. Dalam konseling individual, ibu diberi kesempatan untuk berbicara secara bebas dan terbuka mengenai perasaannya, dengan terapis atau konselor memberikan respons yang empatik, non-judgmental, serta penuh perhatian. Konseling ini sangat membantu ibu merasa didengarkan, diterima, dan tidak sendiri dalam menghadapi kesulitannya. Di sisi lain, konseling suportif kelompok menawarkan kesempatan bagi ibu untuk bertemu dengan ibu-ibu lain yang mengalami kondisi serupa. Dalam kelompok ini, ibu dapat berbagi pengalaman, saling memberikan dukungan emosional, dan belajar dari strategi coping yang digunakan oleh anggota lain. Penelitian menunjukkan bahwa konseling suportif kelompok tidak hanya efektif dalam mengurangi gejala depresi postpartum tetapi juga mampu memperkuat jaringan sosial ibu serta menurunkan rasa kesepian dan isolasi sosial yang dialaminya.

Selain pendekatan yang berfokus pada kognitif atau interpersonal, mindfulness dan teknik relaksasi juga merupakan intervensi psikologis yang semakin banyak digunakan dan terbukti efektif dalam manajemen depresi postpartum. Mindfulness adalah latihan yang membantu ibu lebih sadar dan hadir sepenuhnya dalam momen saat ini tanpa tenggelam dalam penyesalan masa lalu atau kekhawatiran masa depan. Latihan mindfulness seperti meditasi singkat, body scan, atau mindful breathing dapat membantu ibu mengurangi tingkat stres, mengelola kecemasan, serta meningkatkan kesadaran terhadap emosi yang dirasakan. Teknik mindfulness membantu ibu mengembangkan sikap penerimaan terhadap kondisi emosionalnya, yang secara tidak langsung mampu menurunkan tekanan emosional yang dialaminya sehari-hari.

Teknik relaksasi seperti relaksasi otot progresif, latihan pernapasan dalam, serta visualisasi positif juga secara aktif digunakan dalam mendukung kesehatan mental ibu postpartum. Relaksasi otot progresif dilakukan dengan cara menegangkan dan kemudian merilekskan kelompok otot secara sistematis, mulai dari ujung kaki hingga kepala. Latihan ini membantu ibu mengenali ketegangan fisik yang muncul akibat stres, sekaligus mengurangi tingkat kecemasan. Latihan pernapasan dalam yang dilakukan secara teratur mampu menenangkan sistem saraf

ibu, sehingga membantu menurunkan gejala fisik dan emosional yang berkaitan dengan kecemasan maupun depresi. Teknik visualisasi positif mengajak ibu membayangkan situasi yang menyenangkan dan menenangkan, sehingga dapat membantu menurunkan tingkat kecemasan yang dialaminya dalam kehidupan sehari-hari.

Efektivitas dari intervensi psikologis dalam manajemen depresi postpartum telah didukung oleh banyak bukti penelitian ilmiah yang kuat. CBT dan IPT, khususnya, telah mendapatkan rekomendasi tinggi dari berbagai organisasi kesehatan internasional, seperti World Health Organization (WHO) dan National Institute for Health and Care Excellence (NICE), sebagai terapi lini pertama dalam manajemen depresi postpartum. Kedua terapi ini terbukti tidak hanya efektif dalam mengurangi gejala depresi tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang seperti peningkatan kualitas hidup ibu, hubungan ibu-anak yang lebih sehat, serta peningkatan kesejahteraan keluarga secara keseluruhan. Konseling suportif individual dan kelompok, serta pendekatan mindfulness dan teknik relaksasi, juga mendapatkan dukungan bukti ilmiah sebagai terapi pelengkap yang efektif untuk membantu ibu mengelola stres dan kecemasan secara lebih baik selama periode postpartum.

E. Terapi Farmakologis dalam Manajemen Depresi Postpartum

Terapi farmakologis merupakan salah satu pendekatan penting dalam manajemen depresi postpartum, terutama pada kasus-kasus di mana gejala depresi tergolong sedang hingga berat atau jika terapi psikologis tidak memberikan respons yang optimal. Pendekatan farmakologis ini bertujuan untuk menstabilkan kondisi psikologis ibu dengan mengoreksi ketidakseimbangan neurokimia di otak, terutama serotonin dan neurotransmitter lain yang berkaitan erat dengan gejala depresi. Pemilihan terapi farmakologis dalam manajemen depresi postpartum harus selalu didasarkan pada bukti ilmiah terkini, mempertimbangkan tingkat keparahan gejala, risiko manfaat terapi, serta kondisi khusus seperti menyusui atau adanya riwayat kesehatan tertentu pada ibu.

Indikasi penggunaan terapi farmakologis pada depresi postpartum berbasis bukti ilmiah terutama muncul ketika ibu menunjukkan gejala depresi yang cukup berat, termasuk adanya ideasi bunuh diri, perasaan putus asa yang intens, atau gangguan fungsi yang signifikan dalam menjalani kehidupan sehari-hari serta merawat bayi. Selain itu, terapi farmakologis juga menjadi pilihan yang tepat ketika ibu memiliki riwayat depresi mayor sebelumnya, terutama jika terdapat riwayat respons baik terhadap pengobatan antidepresan di masa lalu. Kondisi lain yang memperkuat indikasi terapi farmakologis adalah ketika ibu tidak menunjukkan

perbaikan berarti setelah menjalani intervensi psikologis selama periode yang cukup, biasanya 6-8 minggu, atau ketika ibu menunjukkan perburukan gejala selama proses terapi non-farmakologis berlangsung.

Dalam memilih obat antidepresan yang tepat, beberapa faktor penting perlu diperhatikan, terutama dalam konteks ibu menyusui. Berdasarkan bukti ilmiah yang ada, golongan obat antidepresan Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs) merupakan pilihan utama dalam terapi depresi postpartum karena profil keamanan dan efektivitasnya yang sudah terbukti secara klinis. SSRIs seperti sertralin, escitalopram, dan fluoxetine secara umum memiliki efektivitas yang tinggi dalam mengurangi gejala depresi, dengan efek samping yang relatif minimal dibandingkan golongan antidepresan lain seperti tricyclic antidepressants (TCAs) atau monoamine oxidase inhibitors (MAOIs).

Khusus dalam konteks ibu menyusui, sertralin merupakan obat yang paling direkomendasikan berdasarkan berbagai pedoman klinis internasional, seperti rekomendasi dari American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) dan World Health Organization (WHO). Hal ini dikarenakan sertralin memiliki tingkat paparan yang sangat rendah pada bayi melalui ASI, sehingga dianggap sebagai obat yang paling aman untuk ibu menyusui. Escitalopram juga dapat menjadi pilihan berikutnya, walaupun kadar paparan pada bayi sedikit lebih tinggi dibanding sertralin. Sebaliknya, obat seperti fluoxetine perlu digunakan dengan hati-hati atau bahkan dihindari pada ibu menyusui karena kadar transfer yang lebih tinggi ke dalam ASI dan risiko efek samping pada bayi, seperti gangguan tidur atau agitasi.

Pertimbangan keamanan tidak hanya mencakup risiko paparan obat terhadap bayi melalui ASI, tetapi juga efek samping yang mungkin dialami ibu sendiri. Efek samping SSRIs yang perlu diperhatikan meliputi gangguan gastrointestinal ringan seperti mual, diare, perubahan nafsu makan, gangguan tidur, hingga risiko efek samping seksual seperti penurunan libido atau disfungsi seksual. Meskipun demikian, efek samping ini biasanya bersifat ringan hingga sedang, serta cenderung menurun seiring berjalannya waktu terapi. Oleh karena itu, komunikasi yang jelas dan terbuka antara tenaga kesehatan dan ibu sangat penting agar ibu memahami manfaat terapi dibandingkan risiko yang mungkin muncul, serta agar ibu tidak menghentikan pengobatan secara tiba-tiba karena efek samping yang dapat diminimalisir.

Durasi pengobatan farmakologis dalam manajemen depresi postpartum juga menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan. Berdasarkan bukti ilmiah terkini, durasi minimal pemberian terapi antidepresan adalah sekitar 6 hingga 12 bulan setelah gejala depresi menunjukkan perbaikan atau mencapai remisi klinis. Pengobatan jangka pendek, kurang dari 6 bulan, sering dikaitkan dengan risiko

tinggi kekambuhan depresi, yang dapat memperburuk kondisi emosional ibu maupun hubungan ibu-anak. Namun, durasi terapi juga dapat lebih lama, hingga 1-2 tahun, terutama bagi ibu yang memiliki riwayat depresi mayor berulang atau yang mengalami gejala depresi postpartum yang sangat berat.

Selama periode pengobatan, evaluasi respons terapi perlu dilakukan secara rutin dan sistematis. Evaluasi ini mencakup pemantauan klinis mengenai perbaikan gejala depresi, peningkatan fungsi sosial dan keluarga ibu, serta dampak terapi terhadap hubungan ibu dengan bayi dan keluarga secara keseluruhan. Evaluasi biasanya dilakukan setiap 4-6 minggu pada awal pengobatan, kemudian dilanjutkan setiap 2-3 bulan setelah kondisi stabil. Dalam evaluasi ini, instrumen klinis seperti Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) atau Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS-21) dapat digunakan untuk mengukur perubahan objektif dalam gejala depresi yang dialami ibu. Apabila respons terapi kurang optimal atau efek samping yang signifikan muncul, maka penyesuaian dosis, perubahan obat antidepresan, atau penambahan intervensi psikologis lain mungkin diperlukan.

terapi farmakologis merupakan komponen penting dalam manajemen depresi postpartum berbasis bukti, terutama untuk kasus yang memerlukan intervensi yang lebih intensif. Dengan indikasi yang jelas, pemilihan obat yang tepat berdasarkan bukti keamanan dan efektivitas, serta durasi pengobatan yang memadai dengan evaluasi respons terapi secara rutin, ibu dengan depresi postpartum dapat memperoleh pemulihan optimal dan mampu menjalani peran barunya dengan lebih baik dan sehat secara mental maupun emosional.

F. Pendekatan Non-Farmakologis Tambahan dalam Manajemen Depresi Postpartum

Pendekatan non-farmakologis tambahan merupakan salah satu aspek penting yang melengkapi strategi utama dalam penanganan depresi postpartum. Pendekatan ini bertujuan untuk mendukung proses pemulihan ibu dengan cara-cara yang aman, nyaman, dan bebas dari efek samping obat, sekaligus memperkuat efektivitas intervensi psikologis maupun farmakologis yang sedang dijalani. Beberapa pendekatan non-farmakologis tambahan yang berbasis bukti ilmiah meliputi intervensi berbasis aktivitas fisik dan olahraga ringan, terapi komplementer dan alternatif seperti aromaterapi, pijat, dan akupunktur, serta edukasi keluarga dan peningkatan dukungan sosial yang intensif.

Salah satu pendekatan non-farmakologis yang terbukti efektif secara ilmiah dalam mengurangi gejala depresi postpartum adalah intervensi berbasis aktivitas fisik dan olahraga ringan. Aktivitas fisik secara teratur telah diketahui dapat meningkatkan produksi hormon endorfin, yang merupakan neurotransmitter alami

tubuh yang berperan dalam meningkatkan suasana hati dan mengurangi perasaan cemas maupun depresi. Jenis aktivitas fisik yang direkomendasikan untuk ibu postpartum adalah olahraga ringan hingga sedang, seperti berjalan kaki santai, yoga postpartum, stretching, atau latihan aerobik ringan yang dilakukan secara rutin minimal 20-30 menit per hari, tiga sampai lima kali dalam seminggu. Penelitian menunjukkan bahwa ibu yang rutin berolahraga ringan setelah melahirkan tidak hanya mengalami penurunan gejala depresi secara signifikan, tetapi juga mengalami peningkatan energi, kualitas tidur yang lebih baik, serta rasa percaya diri yang lebih tinggi dalam menjalani peran sebagai ibu baru. Selain itu, olahraga juga membantu mempercepat proses pemulihan fisik pasca melahirkan serta mengurangi rasa lelah kronis yang kerap dialami oleh ibu postpartum.

Selain intervensi berbasis aktivitas fisik, terapi komplementer dan alternatif juga semakin mendapatkan perhatian dalam manajemen depresi postpartum, karena pendekatan ini dianggap aman, minim risiko efek samping, dan secara psikologis dapat memberikan rasa nyaman dan relaksasi kepada ibu. Aromaterapi merupakan salah satu bentuk terapi komplementer yang menggunakan minyak esensial dari tumbuhan untuk membantu meredakan gejala depresi dan kecemasan postpartum. Minyak esensial seperti lavender, chamomile, dan bergamot diketahui memiliki efek menenangkan sistem saraf, meningkatkan relaksasi, serta membantu menurunkan stres dan meningkatkan kualitas tidur. Aromaterapi biasanya diaplikasikan melalui metode inhalasi atau pijat ringan menggunakan minyak aromaterapi yang diencerkan. Studi ilmiah telah menunjukkan bahwa ibu yang menerima aromaterapi secara rutin mengalami penurunan gejala depresi dan kecemasan yang signifikan dibandingkan dengan ibu yang tidak menerima terapi tersebut.

Terapi pijat postpartum juga merupakan salah satu intervensi non-farmakologis yang terbukti bermanfaat bagi ibu yang mengalami depresi postpartum. Terapi pijat dapat membantu mengurangi ketegangan fisik maupun emosional, meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi nyeri otot, serta memberikan perasaan relaksasi yang mendalam. Selain efek fisik, terapi pijat juga memiliki manfaat psikologis yang kuat, di mana ibu merasa lebih dihargai, diperhatikan, serta memiliki waktu untuk memanjakan diri sendiri, yang secara signifikan dapat meningkatkan suasana hati dan rasa percaya dirinya. Terapi pijat biasanya dilakukan secara rutin, minimal sekali dalam seminggu, dan terbukti efektif dalam menurunkan tingkat keparahan depresi serta mempercepat pemulihan emosional ibu postpartum.

Akupunktur adalah metode lain dalam kategori terapi alternatif yang juga semakin banyak diterapkan sebagai intervensi tambahan dalam manajemen depresi

postpartum. Teknik ini dilakukan dengan memasukkan jarum steril tipis ke dalam titik-titik spesifik di tubuh untuk merangsang sistem saraf dan endokrin. Efektivitas akupunktur dalam mengurangi gejala depresi postpartum didukung oleh berbagai penelitian ilmiah, yang menunjukkan bahwa akupunktur mampu meningkatkan pelepasan neurotransmitter seperti serotonin dan endorfin dalam otak, sehingga menghasilkan efek antidepresan yang alami. Selain itu, akupunktur juga dapat memperbaiki kualitas tidur, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan energi serta vitalitas tubuh ibu postpartum. Pendekatan ini menjadi pilihan alternatif yang baik bagi ibu yang ingin menghindari atau membatasi penggunaan obat-obatan antidepresan.

Aspek lain yang tak kalah penting dari pendekatan non-farmakologis adalah edukasi keluarga dan penguatan dukungan sosial di lingkungan sekitar ibu postpartum. Depresi postpartum tidak hanya berdampak pada ibu sendiri, tetapi juga memengaruhi interaksi ibu dengan keluarga, pasangan, dan bayi. Oleh karena itu, edukasi keluarga menjadi salah satu komponen penting dalam manajemen depresi postpartum. Edukasi ini mencakup pemberian pemahaman yang jelas mengenai tanda dan gejala depresi postpartum, pentingnya dukungan emosional dan praktis, serta bagaimana cara terbaik keluarga memberikan dukungan yang diperlukan oleh ibu. Ketika keluarga memahami kondisi ibu dengan baik, mereka cenderung lebih sabar, empatik, dan terlibat secara aktif dalam proses pemulihan emosional ibu. Edukasi ini biasanya dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti bidan, psikolog, atau konselor secara teratur, baik melalui konseling keluarga, kelas postpartum, maupun melalui sesi edukasi individual.

Dukungan sosial yang kuat juga merupakan faktor protektif yang sangat penting dalam membantu ibu mengatasi depresi postpartum. Dukungan sosial dapat berupa dukungan emosional seperti mendengarkan keluhan, memberikan motivasi, dan empati, maupun dukungan praktis seperti membantu ibu dalam merawat bayi, mengurus rumah tangga, atau menyediakan waktu istirahat yang cukup. Penelitian menunjukkan bahwa ibu postpartum yang mendapatkan dukungan sosial yang kuat memiliki risiko lebih rendah untuk mengalami depresi berkepanjangan, serta memiliki tingkat pemulihan yang lebih cepat dibandingkan dengan ibu yang tidak mendapatkan dukungan sosial yang memadai.

pendekatan non-farmakologis tambahan yang mencakup aktivitas fisik teratur, terapi komplementer seperti aromaterapi, pijat, akupunktur, serta edukasi keluarga dan peningkatan dukungan sosial merupakan bagian integral dalam manajemen depresi postpartum berbasis bukti. Dengan pendekatan ini, diharapkan ibu dapat mencapai pemulihan emosional secara menyeluruh, lebih nyaman menjalani proses pemulihan, serta mampu merawat bayi dengan penuh kasih sayang dan percaya diri.

G. Peran Keluarga dan Dukungan Sosial Berbasis Bukti dalam Manajemen Depresi Postpartum

Keluarga memiliki peran sentral dalam mendukung pemulihan ibu yang mengalami depresi postpartum. Peran ini tidak terbatas hanya pada aspek praktis dalam merawat bayi dan mengelola rumah tangga, tetapi juga mencakup aspek emosional yang secara langsung mempengaruhi kondisi psikologis ibu. Secara khusus, pasangan memiliki peran yang sangat krusial karena ia menjadi sosok terdekat dan pertama yang dapat mendeteksi tanda-tanda awal depresi postpartum serta memberikan dukungan yang diperlukan. Pasangan yang responsif dan empatik terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat stres, kecemasan, maupun perasaan sedih pada ibu yang mengalami depresi postpartum, sehingga mempercepat proses pemulihan.

Penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang memiliki pemahaman yang baik tentang depresi postpartum cenderung mampu memberikan dukungan yang lebih tepat dan efektif. Dukungan pasangan tersebut bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari mendengarkan keluhan dan curahan hati ibu dengan penuh perhatian, memberi kesempatan kepada ibu untuk beristirahat lebih banyak, hingga terlibat secara langsung dalam perawatan bayi. Dengan demikian, ibu tidak merasa sendirian dalam menjalani tantangan emosional selama masa postpartum. Keterlibatan pasangan secara aktif juga meningkatkan rasa percaya diri ibu dalam menjalani perannya sebagai orang tua baru, sehingga mengurangi perasaan bersalah, ketidakmampuan, atau kecemasan berlebihan yang sering muncul dalam kondisi depresi postpartum.

Agar dukungan dari pasangan menjadi efektif, dibutuhkan strategi khusus untuk meningkatkan keterampilan pasangan dalam memberikan dukungan yang optimal. Salah satu strategi yang terbukti efektif secara ilmiah adalah pelaksanaan edukasi atau pelatihan singkat bagi pasangan mengenai depresi postpartum. Edukasi ini mencakup informasi dasar mengenai tanda-tanda depresi postpartum, cara merespons secara positif ketika ibu mengalami gejala depresi, serta pentingnya peran pasangan dalam menjaga keseimbangan emosional ibu. Pelatihan ini biasanya disampaikan oleh tenaga kesehatan seperti bidan, psikolog, atau konselor yang secara khusus dilatih dalam manajemen depresi postpartum. Dengan pemahaman yang baik, pasangan menjadi lebih peka terhadap perubahan emosional ibu serta mampu memberikan respons dukungan yang sesuai dan tepat waktu.

Selain peran pasangan, keluarga yang lebih luas seperti orang tua, saudara, atau kerabat juga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan emosional

dan praktis kepada ibu postpartum. Dukungan keluarga yang kuat terbukti secara ilmiah mampu meningkatkan rasa aman, mengurangi rasa isolasi, dan mempercepat pemulihan ibu dari depresi postpartum. Dukungan ini bisa berupa bantuan praktis dalam merawat bayi, melakukan tugas rumah tangga sehari-hari, hingga memberikan kesempatan bagi ibu untuk memiliki waktu istirahat yang cukup dan berkualitas. Dukungan emosional keluarga yang berupa perhatian, empati, dan dorongan positif juga penting karena ibu merasa dihargai, dicintai, dan didukung sepenuhnya oleh lingkungan terdekatnya.

Namun demikian, tidak semua keluarga secara otomatis mengetahui bagaimana cara terbaik memberikan dukungan kepada ibu yang mengalami depresi postpartum. Oleh karena itu, strategi edukasi keluarga menjadi sangat penting untuk diterapkan secara sistematis. Edukasi keluarga dilakukan melalui konseling keluarga atau sesi edukasi khusus yang bertujuan meningkatkan kesadaran keluarga tentang dampak depresi postpartum serta cara-cara spesifik untuk memberikan dukungan yang efektif. Melalui edukasi ini, keluarga dapat memahami bahwa depresi postpartum bukan merupakan kelemahan pribadi ibu, melainkan kondisi medis yang membutuhkan dukungan, empati, dan intervensi yang tepat. Penelitian menunjukkan bahwa keluarga yang mendapatkan edukasi ini cenderung lebih efektif dalam memberikan dukungan, sehingga proses pemulihan ibu menjadi lebih cepat dan optimal.

Di samping dukungan dari keluarga terdekat, intervensi berbasis komunitas dan kelompok dukungan juga memiliki peran signifikan dalam mendukung pemulihan ibu yang mengalami depresi postpartum. Intervensi ini berbentuk kelompok pendukung yang diisi oleh para ibu yang memiliki pengalaman serupa atau kelompok pendukung berbasis komunitas yang difasilitasi oleh tenaga kesehatan. Kelompok-kelompok ini menyediakan lingkungan sosial yang positif, aman, serta mendukung, di mana ibu merasa tidak sendirian dalam menghadapi tantangan emosional yang dialaminya. Interaksi dengan sesama ibu yang mengalami situasi serupa memberikan rasa empati yang tinggi, serta kesempatan untuk saling berbagi pengalaman, solusi praktis, maupun motivasi.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ibu yang rutin menghadiri kelompok dukungan postpartum cenderung mengalami perbaikan yang signifikan dalam kondisi psikologis mereka dibandingkan dengan ibu yang tidak memiliki akses terhadap kelompok tersebut. Dalam kelompok ini, ibu mendapatkan manfaat tambahan berupa informasi praktis mengenai perawatan bayi, manajemen stres sehari-hari, hingga teknik relaksasi yang membantu mengurangi gejala depresi postpartum. Selain itu, kelompok dukungan juga sering melibatkan aktivitas sosial

seperti kegiatan rekreasi atau olahraga ringan bersama, yang secara langsung berdampak positif terhadap kesejahteraan mental dan emosional ibu.

Implementasi intervensi berbasis komunitas juga memiliki dampak yang luas, terutama dalam mengurangi stigma sosial terhadap depresi postpartum. Melalui edukasi komunitas yang terintegrasi dengan kegiatan kelompok, kesadaran masyarakat meningkat mengenai pentingnya mendukung ibu yang mengalami depresi postpartum secara positif dan empatik. Hal ini membantu ibu merasa lebih nyaman dalam mencari bantuan, baik secara informal dari komunitas maupun secara formal dari tenaga kesehatan. Komunitas yang mendukung menciptakan lingkungan sosial yang lebih kondusif bagi ibu, sehingga risiko isolasi sosial yang sering dialami ibu postpartum dapat dikurangi secara signifikan.

peran keluarga dan dukungan sosial berbasis bukti dalam manajemen depresi postpartum sangat penting untuk memastikan ibu mendapatkan dukungan yang holistik. Keterlibatan aktif pasangan, edukasi keluarga yang tepat, serta intervensi berbasis komunitas yang efektif secara bersama-sama menciptakan lingkungan sosial yang positif dan mendukung pemulihan ibu secara optimal. Dengan dukungan yang tepat dari lingkungan terdekat dan komunitas yang luas, ibu yang mengalami depresi postpartum dapat pulih lebih cepat, merasa lebih percaya diri, dan mampu menjalani peran barunya sebagai ibu dengan lebih nyaman dan bahagia.

H. Tantangan dalam Implementasi Manajemen Depresi Postpartum Berbasis Bukti

Implementasi manajemen depresi postpartum yang berbasis bukti di berbagai tingkat pelayanan kesehatan sering kali menghadapi berbagai tantangan kompleks yang berasal dari aspek internal sistem pelayanan kesehatan hingga faktor eksternal berupa lingkungan sosial dan budaya masyarakat. Salah satu tantangan utama yang muncul adalah hambatan dalam pelaksanaan skrining dan deteksi dini terhadap depresi postpartum. Meskipun berbagai instrumen skrining terstandar seperti Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS-21), maupun Postpartum Depression Screening Scale (PDSS) telah terbukti efektif secara ilmiah, penggunaannya di lapangan masih mengalami kendala besar. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan di fasilitas primer, baik bidan maupun perawat, yang belum sepenuhnya memahami pentingnya skrining rutin, cara menggunakan instrumen dengan benar, serta interpretasi hasil skrining secara tepat. Akibatnya, banyak kasus depresi postpartum yang luput dari deteksi dini dan tidak mendapatkan intervensi yang seharusnya segera diberikan.

Selain keterbatasan pengetahuan tenaga kesehatan, hambatan skrining juga muncul karena keterbatasan waktu dan beban kerja yang tinggi pada tenaga kesehatan, terutama di fasilitas pelayanan primer. Bidan dan perawat di tingkat puskesmas atau klinik kebidanan sering kali harus menghadapi pasien dalam jumlah besar setiap harinya, sehingga mereka merasa tidak memiliki waktu yang cukup untuk melakukan skrining kesehatan mental secara sistematis. Situasi ini menyebabkan skrining depresi postpartum sering diabaikan, bahkan hanya dilakukan secara singkat atau sporadis tanpa menggunakan alat ukur yang tepat. Dalam jangka panjang, hal ini menyebabkan intervensi yang seharusnya dapat dilakukan secara dini menjadi terlambat, yang pada akhirnya memperburuk kondisi kesehatan mental ibu dan meningkatkan risiko komplikasi yang lebih berat.

Selain hambatan dalam skrining, tantangan berikutnya yang tidak kalah penting adalah keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan mental khusus bagi ibu postpartum yang mengalami depresi. Di banyak daerah, terutama di wilayah pedesaan atau terpencil, akses terhadap layanan kesehatan mental yang komprehensif seperti layanan psikolog atau psikiater sangat terbatas atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Kondisi ini mengharuskan ibu dengan depresi postpartum melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan penanganan profesional yang dibutuhkan, yang sering kali tidak praktis atau bahkan tidak memungkinkan karena keterbatasan ekonomi, transportasi, atau situasi keluarga. Kurangnya ketersediaan layanan kesehatan mental yang mudah dijangkau juga membuat banyak ibu akhirnya tidak mendapatkan bantuan sama sekali, sehingga kondisi depresi mereka semakin memburuk dan berisiko berdampak pada kualitas hubungan ibu-bayi maupun dinamika keluarga secara keseluruhan.

Lebih jauh, di daerah perkotaan sekalipun, akses layanan kesehatan mental postpartum yang berkualitas masih menjadi tantangan nyata karena berbagai kendala struktural. Layanan psikologis atau psikiatri sering kali hanya tersedia di rumah sakit besar atau fasilitas kesehatan khusus, yang membutuhkan proses rujukan panjang. Hal ini membuat ibu yang sudah dideteksi mengalami depresi postpartum tetap menghadapi kesulitan dalam mendapatkan penanganan yang tepat waktu. Selain itu, biaya layanan kesehatan mental yang relatif tinggi dan tidak selalu tercakup oleh jaminan kesehatan, menjadi kendala tambahan bagi ibu yang membutuhkan bantuan, khususnya bagi mereka yang berasal dari keluarga dengan tingkat ekonomi rendah atau menengah. Semua faktor ini memperburuk kondisi mental ibu, karena ibu merasa tidak memiliki alternatif yang jelas untuk mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.

Selain faktor-faktor yang bersifat internal sistem kesehatan, tantangan yang signifikan lainnya berasal dari faktor eksternal berupa stigma sosial yang masih

melekat kuat di berbagai lapisan masyarakat terhadap ibu yang mengalami depresi postpartum. Di banyak budaya, termasuk di Indonesia, depresi postpartum sering kali masih dianggap sebagai kelemahan karakter, kegagalan pribadi ibu, atau bahkan dianggap sebagai kondisi yang tabu untuk dibahas secara terbuka. Akibatnya, ibu yang mengalami gejala depresi postpartum merasa enggan atau takut untuk mencari bantuan profesional, karena khawatir mendapatkan pandangan negatif, label sosial, atau penilaian buruk dari keluarga dan masyarakat sekitar. Dalam kondisi seperti ini, ibu cenderung menyembunyikan gejala yang dialaminya, mencoba mengatasi sendiri dalam diam, yang pada akhirnya memperburuk kondisi depresi serta meningkatkan risiko munculnya komplikasi psikologis yang lebih serius.

Dampak stigma sosial ini sangat nyata dalam berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami depresi postpartum sering kali lebih memilih untuk diam atau mencari pengobatan alternatif tanpa pengawasan profesional. Mereka cenderung baru mencari bantuan setelah kondisi depresi menjadi berat, sehingga proses pemulihan menjadi jauh lebih sulit dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Stigma sosial juga secara tidak langsung berdampak pada keluarga, khususnya pasangan, yang mungkin juga merasa malu atau kesulitan menerima kondisi yang dialami oleh ibu, sehingga kurang memberikan dukungan yang dibutuhkan. Dengan demikian, stigma sosial tidak hanya memperparah kondisi mental ibu, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang kurang mendukung pemulihan dan kesejahteraan emosional ibu postpartum secara keseluruhan.

Mengatasi berbagai tantangan tersebut memerlukan pendekatan komprehensif dan terintegrasi. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan rutin tentang penggunaan instrumen skrining, wawancara klinis yang efektif, serta pemahaman dasar mengenai depresi postpartum, menjadi solusi utama dalam mengatasi hambatan skrining dan deteksi dini. Di sisi lain, pemerintah dan institusi terkait juga perlu secara aktif meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan mental melalui kebijakan yang mendukung perluasan layanan psikologis atau psikiatri hingga ke tingkat puskesmas, memfasilitasi kemudahan rujukan, serta memastikan bahwa biaya layanan kesehatan mental postpartum dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, edukasi masyarakat secara luas dan berkelanjutan mengenai depresi postpartum harus dilakukan secara sistematis untuk mengurangi stigma sosial. Kampanye edukasi publik melalui media sosial, komunitas lokal, dan fasilitas kesehatan primer dapat membantu masyarakat memahami bahwa depresi postpartum merupakan kondisi medis yang membutuhkan perhatian khusus, bukan

sebuah kelemahan atau kesalahan pribadi ibu. Dengan demikian, ibu merasa lebih nyaman dan aman untuk mencari bantuan profesional tanpa khawatir mendapatkan pandangan negatif dari lingkungan sekitar.

tantangan dalam implementasi manajemen depresi postpartum berbasis bukti memang kompleks dan multifaktorial. Namun, dengan upaya bersama dari berbagai pihak—tenaga kesehatan, pemerintah, komunitas, serta masyarakat luas—tantangan ini dapat diatasi secara bertahap dan sistematis. Hasilnya, ibu postpartum yang mengalami depresi dapat lebih cepat dideteksi, mendapatkan intervensi yang tepat waktu, serta menjalani proses pemulihan yang lebih efektif, sehingga kualitas hidup ibu, bayi, dan keluarganya secara keseluruhan dapat meningkat secara signifikan.

I. Solusi dan Rekomendasi Implementasi Manajemen Berbasis Bukti

Manajemen depresi postpartum yang efektif memerlukan pendekatan sistematis dan menyeluruh berdasarkan bukti ilmiah yang terpercaya. Berbagai tantangan dalam implementasi praktik berbasis bukti di lapangan menuntut berbagai solusi konkret yang dapat diimplementasikan secara nyata. Dalam konteks ini, terdapat beberapa solusi strategis yang direkomendasikan untuk memastikan bahwa manajemen depresi postpartum dapat berjalan secara efektif di berbagai level pelayanan kesehatan, baik primer maupun sekunder.

Salah satu solusi penting yang harus mendapat perhatian utama adalah penguatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan yang terstruktur, rutin, dan berkelanjutan. Tenaga kesehatan, khususnya bidan, perawat, dokter umum, maupun spesialis kebidanan, harus diberikan pelatihan komprehensif mengenai deteksi dini depresi postpartum, penggunaan instrumen skrining yang tepat seperti Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS-21), hingga Postpartum Depression Screening Scale (PDSS). Pelatihan ini tidak hanya sebatas pada aspek teknis skrining, tetapi juga mencakup keterampilan wawancara klinis, teknik komunikasi terapeutik yang empatik, serta pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip intervensi psikologis dasar, seperti konseling suportif, cognitive behavioral therapy (CBT), maupun teknik relaksasi dan mindfulness. Dengan pelatihan ini, tenaga kesehatan akan memiliki pengetahuan yang memadai, rasa percaya diri, serta kompetensi yang dibutuhkan untuk secara aktif mendeteksi, mengidentifikasi, serta memberikan intervensi awal yang efektif terhadap ibu yang mengalami depresi postpartum.

Selain pelatihan tenaga kesehatan, solusi berikutnya yang perlu ditekankan adalah integrasi layanan kesehatan mental ke dalam pelayanan postpartum rutin. Pendekatan ini berarti bahwa skrining kesehatan mental harus menjadi bagian

integral yang tidak terpisahkan dari kunjungan postpartum yang sudah ada, sebagaimana pemeriksaan fisik dan pemantauan kondisi kesehatan ibu lainnya. Integrasi layanan ini menjamin bahwa setiap ibu postpartum yang datang ke fasilitas kesehatan primer seperti puskesmas atau klinik bidan secara otomatis mendapatkan evaluasi kesehatan mental yang komprehensif. Dengan demikian, ibu yang mengalami tanda-tanda awal depresi postpartum dapat segera dikenali dan mendapatkan intervensi yang cepat dan tepat waktu. Strategi integrasi ini memerlukan adanya sistem pencatatan yang jelas, penyediaan instrumen skrining yang tersedia di setiap layanan postpartum, serta kebijakan internal yang memastikan bahwa skrining kesehatan mental menjadi rutinitas standar dan bukan tindakan yang bersifat opsional atau tambahan.

Advokasi kebijakan yang proaktif juga menjadi solusi yang sangat penting untuk memperkuat dukungan fasilitas kesehatan mental bagi ibu postpartum. Pemerintah, pembuat kebijakan kesehatan, serta institusi terkait harus didorong untuk mengeluarkan kebijakan yang spesifik terkait penyediaan layanan kesehatan mental maternal di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan. Advokasi ini meliputi pengadaan ruang khusus untuk layanan konseling kesehatan mental, penyediaan tenaga profesional kesehatan mental seperti psikolog klinis atau psikiater, serta alokasi dana khusus yang memastikan layanan kesehatan mental postpartum dapat diberikan secara efektif, mudah diakses, dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, peran organisasi profesi kesehatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta komunitas-komunitas yang peduli terhadap isu kesehatan perempuan juga sangat penting dalam mendukung advokasi kebijakan yang efektif. Dengan adanya dukungan kebijakan yang kuat, layanan kesehatan mental maternal akan mendapatkan prioritas yang tinggi, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kualitas hidup ibu dan bayi secara menyeluruh.

Solusi lain yang tak kalah penting adalah pendekatan kolaboratif antarprofesi kesehatan. Pendekatan ini menekankan pentingnya kerja sama yang erat dan koordinasi yang jelas antara berbagai tenaga kesehatan yang terlibat dalam manajemen depresi postpartum, seperti bidan, dokter umum, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, psikolog klinis, psikiater, serta pekerja sosial. Kolaborasi antarprofesi ini dapat diwujudkan melalui pembentukan tim kesehatan mental maternal multidisiplin yang bertugas melakukan deteksi dini, memberikan intervensi awal, serta melakukan rujukan lanjutan secara efektif dan efisien. Dengan adanya kolaborasi antarprofesi, tanggung jawab manajemen depresi postpartum tidak hanya terbebani pada satu profesi saja, tetapi menjadi tanggung jawab bersama yang didukung oleh jaringan pelayanan kesehatan yang kuat. Model kolaborasi ini juga memungkinkan dilakukannya pertukaran informasi klinis secara cepat,

konsultasi antart tenaga kesehatan dalam menentukan strategi intervensi yang tepat, serta pengambilan keputusan klinis yang komprehensif berdasarkan perspektif berbagai disiplin ilmu.

implementasi solusi-solusi tersebut akan menciptakan lingkungan pelayanan kesehatan yang lebih kondusif untuk manajemen depresi postpartum berbasis bukti. Dengan kapasitas tenaga kesehatan yang meningkat, integrasi skrining kesehatan mental dalam pelayanan postpartum rutin, dukungan kebijakan yang kuat, serta kolaborasi antarprofesi kesehatan yang solid, maka ibu postpartum yang mengalami depresi akan mendapatkan bantuan yang dibutuhkan secara tepat waktu, efektif, serta berbasis bukti ilmiah. Hasilnya, kesehatan mental ibu postpartum dapat terjaga secara optimal, kualitas hidup ibu dan keluarga meningkat, dan risiko komplikasi jangka panjang dari depresi postpartum bisa diminimalkan secara signifikan.

J. Simpulan

Depresi postpartum merupakan kondisi kesehatan mental yang sering dialami perempuan setelah melahirkan, ditandai dengan gejala seperti kesedihan mendalam, gangguan tidur, kecemasan, hingga gangguan fungsi sehari-hari. Kondisi ini memiliki prevalensi yang cukup tinggi secara global maupun di Indonesia, sehingga menjadi perhatian serius dalam pelayanan kesehatan maternal. Pendekatan berbasis bukti menjadi sangat penting karena menjamin bahwa setiap tindakan dalam manajemen depresi postpartum didasarkan pada hasil penelitian ilmiah yang teruji, efektif, dan aman.

Etiologi depresi postpartum bersifat multifaktorial, melibatkan aspek biologis seperti perubahan hormonal yang drastis, aspek psikososial seperti tekanan lingkungan dan kurangnya dukungan sosial, riwayat kesehatan mental sebelumnya, serta pengalaman negatif selama kehamilan dan persalinan. Pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor ini sangat membantu dalam proses identifikasi dini serta intervensi yang tepat sasaran.

Proses identifikasi dan skrining depresi postpartum dilakukan melalui instrumen terstandar seperti EPDS, DASS-21, dan PDSS, wawancara klinis mendalam, serta observasi klinis terhadap tanda peringatan dini. Intervensi psikologis berbasis bukti seperti Cognitive Behavioral Therapy (CBT), Interpersonal Psychotherapy (IPT), konseling suportif, mindfulness, dan teknik relaksasi telah terbukti efektif dalam mengatasi gejala depresi postpartum. Selain intervensi psikologis, terapi farmakologis dengan antidepresan tertentu juga berperan penting, terutama pada kasus depresi berat atau kasus yang tidak merespons terapi non-farmakologis, dengan perhatian khusus terhadap keamanan bagi ibu menyusui.

Pendekatan non-farmakologis tambahan seperti aktivitas fisik teratur, terapi komplementer (aromaterapi, pijat, akupunktur), serta edukasi keluarga dan peningkatan dukungan sosial juga secara signifikan mendukung proses pemulihan ibu postpartum. Peran keluarga, terutama pasangan, serta dukungan sosial berbasis komunitas sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemulihan mental ibu, menurunkan risiko isolasi sosial, serta mengurangi dampak stigma yang masih melekat pada kondisi ini.

Namun, implementasi manajemen depresi postpartum berbasis bukti menghadapi berbagai tantangan kompleks, antara lain keterbatasan pengetahuan tenaga kesehatan, keterbatasan akses layanan kesehatan mental, serta stigma sosial yang masih kuat di masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan solusi strategis yang mencakup penguatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan rutin, integrasi layanan kesehatan mental dalam layanan postpartum rutin, advokasi kebijakan kesehatan yang mendukung, serta pendekatan kolaboratif antarprofesi kesehatan.

Dengan menerapkan solusi-solusi tersebut secara sistematis dan terintegrasi, diharapkan ibu postpartum yang mengalami depresi dapat dideteksi sejak dini, menerima intervensi berbasis bukti secara optimal, serta mengalami pemulihan yang efektif. Pada akhirnya, pendekatan ini akan berdampak positif terhadap kualitas hidup ibu, perkembangan bayi, serta kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

K. Referensi

- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2018). Screening for Perinatal Depression. ACOG Committee Opinion No. 757. *Obstetrics & Gynecology*, 132(5), e208-e212. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000002927>
- Beck, C. T., & Gable, R. K. (2000). Postpartum Depression Screening Scale (PDSS): Development and Psychometric Testing. *Nursing Research*, 49(5), 272-282. <https://doi.org/10.1097/00006199-200009000-00006>
- Cox, J. L., Holden, J. M., & Sagovsky, R. (1987). Detection of Postnatal Depression: Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. *The British Journal of Psychiatry*, 150(6), 782-786. <https://doi.org/10.1192/bjp.150.6.782>
- Dennis, C. L., & Hodnett, E. (2007). Psychosocial and Psychological Interventions for Treating Postpartum Depression. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2007(4). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD006116.pub2>
- Goodman, J. H., & Santangelo, G. (2011). Group Treatment for Postpartum

Depression: A Systematic Review. *Archives of Women's Mental Health*, 14(4), 277-293. <https://doi.org/10.1007/s00737-011-0216-7>

Milgrom, J., Gemmill, A. W., Ericksen, J., Burrows, G., & Buist, A. (2015). Treatment of Postnatal Depression with Cognitive Behavioural Therapy, Sertraline, and Combination Therapy: A Randomised Controlled Trial. *Australian & New Zealand Journal of Psychiatry*, 49(3), 236-245. <https://doi.org/10.1177/0004867414565474>

National Institute for Health and Care Excellence. (2014). Antenatal and Postnatal Mental Health: Clinical Management and Service Guidance (CG192). NICE. Retrieved from <https://www.nice.org.uk/guidance/cg192>

O'Hara, M. W., & Swain, A. M. (1996). Rates and Risk of Postpartum Depression—A Meta-analysis. *International Review of Psychiatry*, 8(1), 37-54. <https://doi.org/10.3109/09540269609037816>

Wisner, K. L., Parry, B. L., & Piontek, C. M. (2002). Clinical Practice. Postpartum Depression. *New England Journal of Medicine*, 347(3), 194-199. <https://doi.org/10.1056/NEJMcp011542>

World Health Organization. (2008). Maternal Mental Health and Child Health and Development in Low and Middle-Income Countries: Report of the Meeting Held in Geneva, Switzerland, 30 January-1 February, 2008. WHO Press.

L. Glosarium

- **Depresi Postpartum:** Gangguan kesehatan mental yang dialami perempuan setelah melahirkan, ditandai oleh kesedihan mendalam, kelelahan berlebihan, perubahan pola tidur dan makan, serta hilangnya minat pada aktivitas sehari-hari.
- **Baby Blues:** Kondisi ringan berupa perasaan sedih, kecemasan, atau perubahan suasana hati yang sering dialami perempuan beberapa hari setelah melahirkan, namun tidak berlangsung lama dan tidak mengganggu aktivitas sehari-hari secara signifikan.
- **Evidence-Based Practice (EBP):** Praktik pelayanan kesehatan yang didasarkan pada bukti ilmiah terkini dan telah terbukti efektif melalui penelitian klinis yang ketat.
- **Etiologi:** Kajian atau ilmu tentang sebab atau asal-usul terjadinya suatu penyakit atau gangguan kesehatan.

- **Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS):** Alat skrining standar yang terdiri dari 10 pertanyaan, digunakan untuk mendeteksi gejala depresi postpartum pada ibu setelah melahirkan.
- **Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS-21):** Instrumen yang digunakan untuk mengukur tiga dimensi penting kesehatan mental sekaligus, yaitu depresi, kecemasan, dan stres.
- **Postpartum Depression Screening Scale (PDSS):** Instrumen penilaian yang lebih rinci untuk mendeteksi berbagai dimensi gejala depresi postpartum, termasuk aspek emosional, kognitif, perilaku, dan interaksi ibu-bayi.
- **Cognitive Behavioral Therapy (CBT):** Terapi psikologis yang menargetkan perubahan pola pikir negatif serta perilaku maladaptif menjadi lebih positif dan konstruktif.
- **Interpersonal Psychotherapy (IPT):** Terapi psikologis yang menitikberatkan hubungan interpersonal, peran sosial, dan dukungan sosial dalam mengatasi gejala depresi postpartum.
- **Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs):** Kelompok obat antidepresan yang bekerja dengan meningkatkan kadar serotonin di otak, digunakan secara luas untuk terapi depresi postpartum karena efektivitas dan profil keamanannya.

CHAPTER 4

PERAN BIDAN DALAM MENDUKUNG KESEHATAN MENTAL KELUARGA

Aminah, S.S.T., M.Kes.

A. Pendahuluan/Prolog

Kesehatan mental merupakan salah satu komponen penting dari kesehatan holistik manusia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kesehatan mental sebagai kondisi kesejahteraan yang memungkinkan individu menyadari potensi dirinya, mampu menghadapi tekanan kehidupan sehari-hari, bekerja secara produktif, serta berkontribusi terhadap komunitasnya (WHO, 2022). Dalam lingkup keluarga, kesehatan mental berperan penting dalam menjaga keharmonisan hubungan antaranggota, membentuk pola asuh yang sehat, serta mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Sayangnya, isu kesehatan mental masih sering terpinggirkan dibandingkan kesehatan fisik. Data menunjukkan bahwa satu dari delapan orang di dunia hidup dengan gangguan kesehatan mental, dan sebagian besar tidak mendapatkan layanan yang memadai (WHO, 2022). Di Indonesia, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 mencatat prevalensi depresi sebesar 6,1% pada penduduk usia 15 tahun ke atas, dengan faktor risiko yang banyak terkait dengan tekanan keluarga, status ekonomi, serta kurangnya dukungan sosial (Kemenkes RI, 2019). Hal ini menegaskan bahwa keluarga merupakan unit penting dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah kesehatan mental.

Bidan, sebagai tenaga kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, memiliki posisi strategis dalam mendukung kesehatan mental keluarga. Bidan tidak hanya memberikan pelayanan klinis terkait kehamilan, persalinan, nifas, bayi, anak, dan keluarga berencana, tetapi juga melakukan pendekatan psikososial melalui edukasi, konseling, dan pemberdayaan keluarga (Ibrahim et al., 2020). Interaksi berkesinambungan antara bidan dan keluarga menjadikan bidan berperan sebagai detektor dini masalah kesehatan mental, penyedia dukungan emosional, sekaligus fasilitator rujukan ke layanan profesional bila diperlukan.

Masa kehamilan, persalinan, dan nifas adalah periode kritis yang rentan menimbulkan gangguan kesehatan mental, khususnya depresi pascapersalinan. Sekitar 10–20% ibu mengalami depresi postpartum di seluruh dunia, dan angka ini cenderung lebih tinggi di negara berkembang (Shorey et al., 2018). Kondisi ini tidak

hanya berdampak pada ibu, tetapi juga pada bayi (misalnya keterlambatan perkembangan emosi dan kognitif) serta keharmonisan keluarga. Dengan demikian, peran bidan dalam mendampingi keluarga pada masa transisi kehidupan menjadi sangat krusial.

Selain itu, keluarga dengan stres sosial-ekonomi, permasalahan rumah tangga, hingga kekerasan domestik juga berisiko mengalami masalah kesehatan mental. Bidan yang berperan sebagai penggerak kesehatan masyarakat dapat membantu meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya kesehatan mental, memperkuat jejaring sosial, serta mengadvokasi kebijakan yang mendukung kesejahteraan psikososial keluarga (Stuart, 2021).

Kesehatan mental merupakan aspek integral dari kesehatan secara menyeluruh. Masa kehamilan, persalinan, dan nifas adalah periode transisi yang menuntut adaptasi biologis, psikologis, dan sosial yang signifikan bagi seorang perempuan dan keluarganya. Salah satu masalah kesehatan mental yang paling banyak diteliti pada periode ini adalah depresi pascapersalin (postpartum depression/PPD), yang berdampak tidak hanya pada ibu, tetapi juga perkembangan anak, kualitas hubungan keluarga, serta stabilitas rumah tangga.

Penelitian terbaru tahun 2024 menegaskan bahwa prevalensi PPD masih cukup tinggi di berbagai belahan dunia. Studi multinasional yang melibatkan ibu di Mesir, Yaman, Irak, India, Ghana, dan Suriah melaporkan prevalensi PPD berkisar 20–30%, dengan variasi faktor risiko seperti kurangnya dukungan sosial, komplikasi obstetri, dan kondisi bayi (BMC Public Health, 2024). Temuan ini konsisten dengan penelitian di Palestina yang melaporkan angka PPD sekitar 30% pada ibu 2–4 minggu pascapersalin, terutama pada mereka yang mengalami pengalaman persalinan negatif (BMC Public Health, 2024).

Selain itu, meta-analisis di Arab Saudi tahun 2024 menunjukkan prevalensi PPD bervariasi antara 18–45%, tergantung cut-off skor Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) yang digunakan. Faktor risiko yang dominan antara lain kehamilan tidak direncanakan, minimnya dukungan pasangan, dan rendahnya status ekonomi (MDPI, 2024).

Di Indonesia, penelitian terbaru juga menunjukkan variasi angka PPD. Studi di Banda Aceh dengan 359 responden menemukan prevalensi depresi pascapersalin 34,2% kategori ringan, 19,8% sedang, dan 5,6% berat (Amna & Khairani, 2024). Penelitian deskriptif di Malang pada ibu nifas hari ke-7 menemukan hasil skrining PPD sebesar 50–70%, meskipun angka ini perlu ditafsirkan hati-hati karena metode skrining dapat memengaruhi hasil (Poltekkes Malang, 2024). Sementara itu, penelitian lapangan di Kabupaten Tangerang juga menyoroti adanya kasus PPD pada rentang 2 minggu hingga 9 bulan postpartum, dengan faktor risiko utama

berupa stres pengasuhan, rendahnya dukungan keluarga, dan pengalaman kehamilan yang tidak direncanakan (UPNVJ, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, pembahasan mengenai peran bidan dalam mendukung kesehatan mental keluarga menjadi sangat relevan. Dengan penguatan peran ini, bidan tidak hanya dipandang sebagai penyedia layanan kebidanan, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam membangun keluarga sehat, tangguh, dan sejahtera secara fisik maupun mental.

B. Peran Bidan Dalam Mendukung Kesehatan Mental Keluarga

1. Deteksi Dini Masalah Kesehatan Mental

Bidan memiliki kesempatan luas untuk bertemu dengan keluarga melalui pelayanan antenatal care, postnatal care, KB, imunisasi, hingga kunjungan rumah. Interaksi ini memungkinkan bidan untuk melakukan skrining awal terhadap tanda-tanda stres, kecemasan, depresi postpartum, maupun masalah komunikasi dalam keluarga. Misalnya, penggunaan alat ukur sederhana seperti Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) dapat membantu bidan mengenali gejala depresi pada ibu nifas.

2. Memberikan Edukasi dan Konseling

Bidan berperan dalam memberikan edukasi mengenai pentingnya kesehatan mental, cara mengelola stres, dan strategi menjaga komunikasi yang sehat dalam keluarga. Konseling yang dilakukan bidan, misalnya saat konseling pranikah atau KB, tidak hanya menekankan aspek medis tetapi juga menyentuh aspek psikososial dan kesiapan mental pasangan.

3. Memberikan Dukungan Emosional

Kehamilan, persalinan, dan masa nifas adalah periode yang penuh perubahan fisik maupun emosional. Bidan dapat memberikan dukungan emosional kepada ibu dan keluarga melalui pendekatan empati, mendengarkan aktif, serta memvalidasi perasaan pasien. Dukungan ini terbukti dapat menurunkan kecemasan dan meningkatkan rasa percaya diri ibu dalam menjalani perannya (Shorey et al., 2018).

4. Fasilitator Dukungan Sosial

Bidan dapat menghubungkan keluarga dengan sumber dukungan lain seperti kelompok ibu hamil, posyandu, kader kesehatan, maupun layanan konseling profesional. Dengan demikian, bidan berfungsi sebagai fasilitator jejaring sosial yang memperkuat daya lenting keluarga terhadap tekanan hidup.

5. Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Masalah kesehatan mental keluarga sering kali berhubungan dengan kekerasan berbasis gender atau konflik rumah tangga. Bidan yang peka dapat

mengenali tanda-tanda kekerasan dan memberikan rujukan yang tepat. Intervensi dini ini sangat penting untuk melindungi korban serta memutus siklus kekerasan yang berisiko memperburuk kondisi psikologis anggota keluarga.

6. Advokasi dan Promosi Kesehatan Mental

Bidan juga berperan sebagai advokat kesehatan mental di masyarakat. Melalui penyuluhan, kampanye kesehatan, dan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya, bidan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan mental dalam keluarga.

C. Tantangan dalam Pelaksanaan

Meskipun peran bidan sangat penting, terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi, antara lain:

1. Stigma terhadap masalah kesehatan mental di masyarakat yang menyebabkan keluarga enggan terbuka.
2. Keterbatasan kompetensi bidan dalam konseling psikologis karena belum semua memiliki pelatihan khusus.
3. Keterbatasan sistem rujukan ke layanan kesehatan jiwa, terutama di daerah rural.

D. Strategi Penguatan Peran Bidan

Untuk memperkuat peran bidan dalam mendukung kesehatan mental keluarga, diperlukan strategi berikut:

1. **Pelatihan berkelanjutan** bagi bidan terkait konseling psikososial, manajemen stres, dan deteksi dini masalah mental.
2. **Integrasi skrining kesehatan mental** ke dalam pelayanan kebidanan rutin.
3. **Kolaborasi lintas sektor**, misalnya dengan psikolog, psikiater, dan lembaga sosial.
4. **Peningkatan kesadaran masyarakat** tentang pentingnya mendiskusikan kesehatan mental tanpa stigma.

E. Simpulan

Bidan memiliki peran krusial dalam mendukung kesehatan mental keluarga melalui deteksi dini, edukasi, konseling, dukungan emosional, fasilitasi jejaring sosial, hingga advokasi. Tantangan yang ada perlu diatasi melalui penguatan kapasitas bidan, integrasi pelayanan kesehatan mental, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, bidan bukan hanya penolong persalinan, tetapi juga agen perubahan dalam membangun keluarga yang sehat secara fisik maupun mental.

F. Referensi

- Amna, Z., & Khairani, M. (2024). *Faktor-faktor Risiko Depresi pada Ibu Pascabersalin*. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, IPB.
- BMC Public Health. (2024). *Exploring predictors and prevalence of postpartum depression among mothers: Multinational study*.
- BMC Public Health. (2024). *Postpartum depression symptoms: prevalence, risk factors, and childbirth experiences in Palestine*.
- Ibrahim, H., Soltani, H., & Gamble, J. (2020). Health professionals' perspectives of barriers, facilitators and strategies to improve maternal mental healthcare in low- and middle-income countries: A systematic review. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 20(1), 1–14. <https://doi.org/10.1186/s12884-020-02944-7>
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). *Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018*. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Jakarta: Kemenkes RI.
- MDPI. (2024). *The Prevalence and Risk Factors of Postpartum Depression Among Saudi Arabian Women — Systematic Review and Meta-Analysis*.
- Poltekkes Kemenkes Malang. (2024). *Descriptive Study the Characteristics Of Mothers With Postpartum Depression Screening Results On The Seventh Day Puerperium*. IJAHST.
- Shorey, S., Chan, S. W., Chong, Y. S., & He, H. G. (2018). A randomized controlled trial of a postnatal psychoeducation programme: Effects on parental outcomes. *Journal of Advanced Nursing*, 74(7), 1619–1631. <https://doi.org/10.1111/jan.13555>
- Stuart, G. W. (2021). *Principles and Practice of Psychiatric Nursing* (11th ed.). Elsevier Health Sciences.
- World Health Organization (WHO). (2022). *World Mental Health Report: Transforming Mental Health for All*. Geneva: WHO.
- Zulfa Zuhriyyah Aydiputri. (2024). *Deteksi Dini dan Analisis Kejadian Postpartum Depression pada Ibu di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang*. Skripsi, UPN Veteran Jakarta

G. Glosarium

WUS

Wanita Usia Subur

Kesehatan Mental

Kondisi kesejahteraan yang memungkinkan individu menyadari potensinya, mampu menghadapi tekanan hidup, bekerja secara produktif, dan berkontribusi pada komunitas.

WHO (World Health Organization)

Organisasi Kesehatan Dunia yang menjadi rujukan global dalam standar, pedoman, dan kebijakan kesehatan, termasuk definisi kesehatan mental.

Kesehatan Holistik

Pendekatan kesehatan yang memandang manusia sebagai kesatuan fisik, mental, emosional, sosial, dan spiritual yang saling berkaitan.

Riskesmas (Riset Kesehatan Dasar)

Survei nasional oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menyediakan data prevalensi berbagai masalah kesehatan, termasuk kesehatan jiwa.

Depresi

Gangguan suasana hati yang ditandai dengan perasaan sedih mendalam, kehilangan minat, kelelahan, dan gangguan fungsi sehari-hari.

Depresi Pascapersalinan (Postpartum Depression/PPD)

Gangguan kesehatan mental yang dialami ibu setelah melahirkan, ditandai dengan kesedihan mendalam, rasa tidak berdaya, dan penurunan kemampuan merawat diri maupun bayi.

Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS)

Alat ukur skrining sederhana untuk mendeteksi gejala depresi pada ibu setelah melahirkan.

Bidan

Tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan memberikan asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, nifas, bayi, anak, keluarga berencana, serta mendukung kesehatan mental keluarga melalui edukasi dan konseling.

Konseling Psikososial

Bentuk pendampingan yang membantu individu atau keluarga dalam menghadapi masalah emosional, sosial, dan psikologis.

Dukungan Emosional

Tindakan memberikan empati, mendengarkan aktif, dan validasi perasaan untuk menurunkan kecemasan dan meningkatkan rasa percaya diri.

Dukungan Sosial

Bantuan dari lingkungan sosial seperti keluarga, kelompok masyarakat, atau layanan profesional yang memperkuat ketahanan individu menghadapi tekanan.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Tindakan kekerasan fisik, emosional, seksual, atau ekonomi yang terjadi di dalam keluarga dan berhubungan dengan masalah kesehatan mental.

Advokasi Kesehatan Mental

Upaya memengaruhi kebijakan, meningkatkan kesadaran, serta memperjuangkan hak individu dan keluarga agar mendapatkan layanan kesehatan mental yang layak.

Stigma Kesehatan Mental

Label negatif atau diskriminasi sosial terhadap individu dengan masalah kesehatan jiwa yang menghambat keterbukaan dan akses layanan.

Kolaborasi Lintas Sektor

Kerja sama antara tenaga kesehatan, psikolog, psikiater, lembaga sosial, dan masyarakat dalam mendukung pencegahan dan penanganan masalah kesehatan mental.

CHAPTER 5

STRATEGI KEBIJAKAN KESEHATAN MENTAL PEREMPUAN DI INDONESIA

Karolin Adhisty, S.Kep., Ns., M.Kep.

A. Pendahuluan/Prolog

1. Urgensi Kesehatan Mental Perempuan di Indonesia

Kesehatan mental perempuan semakin dipahami sebagai isu strategis dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Gambaran beban masalah pada tingkat populasi menunjukkan sinyal yang jelas: Riset Kesehatan Dasar 2018 mencatat prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk usia ≥ 15 tahun sekitar 9,8 persen, dan angkanya lebih tinggi pada perempuan (sekitar 12,1 persen) dibanding laki-laki (sekitar 7,6 persen). Survei Kesehatan Indonesia 2023 mengestimasi prevalensi depresi nasional sekitar 1,4 persen dengan puncak pada kelompok usia 15 sampai 24 tahun sekitar 2 persen. Di kelompok usia muda ini tampak ketimpangan gender yang tegas, perempuan sekitar 2,8 persen dan laki-laki sekitar 1,1 persen. Pola tersebut sejalan dengan temuan global bahwa perempuan lebih sering terdampak depresi dibanding laki-laki, serta bahwa masa kehamilan dan pascapersalinan merupakan periode rentan dengan sekitar satu dari sepuluh ibu hamil dan lebih dari satu dari sepuluh ibu pascapersalinan mengalami masalah kesehatan mental, terutama depresi. Secara substantif, data ini menegaskan kebutuhan akan pendekatan kebijakan yang sensitif gender dan berjangka panjang.

Kerentanan perempuan terhadap masalah kesehatan mental terbentuk dari jalinan faktor biologis, sosial, dan budaya yang saling memperkuat sepanjang daur kehidupan. Dari sisi biologis, perubahan dan fluktuasi hormon reproduktif pada masa pubertas, kehamilan, nifas, dan perimenopause memengaruhi regulasi emosi serta kerentanan terhadap gangguan mood. Hal ini menjelaskan mengapa periode perinatal dan transisi menopause sering disebut sebagai "jendela risiko". Namun determinan sosial dan budaya kerap menjadi pengganda masalah, antara lain beban kerja perawatan domestik yang tidak dibayar, ketidaksetaraan kesempatan ekonomi, tekanan norma peran gender, diskriminasi di tempat kerja, serta paparan kekerasan berbasis gender. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 2021 menunjukkan sekitar satu dari empat perempuan usia 15 sampai 64 tahun pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya, dan hampir satu dari

sebelas mengalaminya dalam dua belas bulan terakhir. Stresor kronis seperti ini berkaitan erat dengan peningkatan risiko depresi, kecemasan, dan trauma psikologis. Pada saat yang sama, kesenjangan akses memperparah beban. Pada kelompok anak muda dengan depresi, hanya sekitar satu dari sepuluh yang mencari pengobatan, sementara proporsi penderita depresi yang mendapatkan terapi medis di populasi umum juga masih rendah. Kondisi ini menunjukkan adanya hambatan struktural seperti stigma, literasi kesehatan mental yang terbatas, biaya tidak langsung seperti transportasi dan kehilangan pendapatan, ketersediaan tenaga profesional yang tidak merata, serta minimnya layanan ramah perempuan di tingkat primer.

Urgensi kebijakan semakin nyata apabila dampak mikro pada keluarga dan dampak makro pada pembangunan manusia diperhitungkan secara bersamaan. Kesehatan mental ibu berhubungan dengan kualitas pengasuhan, keberhasilan menyusui, sensitivitas terhadap kebutuhan bayi, dan stimulasi dini. Melalui mekanisme-mekanisme tersebut, kesehatan mental ibu berpotensi memengaruhi perkembangan kognitif, bahasa, dan sosial emosional anak. Sejumlah penelitian di Indonesia menunjukkan keterkaitan antara kesehatan mental ibu dan risiko gangguan tumbuh kembang termasuk stunting, walaupun sebagian temuan lain menekankan bahwa hubungan tersebut dapat mengecil setelah faktor perancu dikendalikan. Meskipun bukti kausal masih memerlukan penguatan, implikasinya tetap konsisten. Dukungan terhadap kesehatan mental perempuan, khususnya pada fase kehamilan dan pascapersalinan, dapat memberikan dampak lintas generasi yang signifikan sehingga investasi pada layanan ini tidak dapat ditunda.

Dari perspektif ekonomi dan tata kelola, alasan untuk bertindak juga kuat. Secara global, gangguan depresi dan kecemasan dikaitkan dengan hilangnya miliaran hari kerja setiap tahun yang menimbulkan beban biaya tidak langsung besar bagi rumah tangga dan perekonomian. Analisis pengembalian investasi menunjukkan bahwa setiap satu satuan biaya yang ditanamkan untuk tata laksana depresi dan kecemasan menghasilkan pengembalian sekitar empat kali lipat dalam bentuk peningkatan kesehatan dan produktivitas. Temuan ini relevan bagi Indonesia yang tengah mengejar bonus demografi dan meningkatkan daya saing. Kesehatan mental perempuan yang memainkan peran sentral di keluarga, komunitas, dan pasar kerja merupakan prasyarat produktivitas dan ketahanan sosial.

Arah kebijakan nasional juga memberikan landasan yang kuat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 sampai 2024 menempatkan kesehatan jiwa sebagai bagian dari prioritas pengendalian penyakit di layanan primer, yang kemudian dijabarkan dalam rencana strategis sektor kesehatan

melalui target deteksi dini serta penguatan pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa di seluruh kabupaten dan kota. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengonsolidasikan pengaturan kesehatan, termasuk kesehatan jiwa, dalam satu payung hukum dan mencabut undang-undang sebelumnya. Langkah ini membuka peluang harmonisasi lintas program, penguatan layanan berbasis hak, serta pendanaan yang lebih berkelanjutan. Pada tingkat global, komitmen Indonesia terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya target untuk menurunkan kematian dini akibat penyakit tidak menular sekaligus mempromosikan kesehatan mental dan kesejahteraan, menegaskan bahwa isu ini tidak hanya berada pada ranah klinis, tetapi juga agenda pembangunan lintas sektor yang memerlukan sinergi dengan pendidikan, ketenagakerjaan, perlindungan sosial, dan penegakan hukum.

B. Kerangka Hukum dan Kebijakan Nasional

Kerangka hukum dan kebijakan kesehatan di Indonesia kini memberikan landasan yang lebih kokoh bagi penguatan kesehatan mental perempuan. Payung utamanya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengonsolidasikan berbagai rezim pengaturan kesehatan dalam satu undang-undang komprehensif. Undang-undang ini menegaskan prinsip kesetaraan antara kesehatan fisik dan kesehatan jiwa, menempatkan kesehatan jiwa sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat, serta mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk merencanakan, membiayai, dan menyelenggarakan layanan yang bermutu sesuai standar. Undang-undang tersebut juga menggantikan pengaturan terdahulu tentang kesehatan jiwa, sehingga arah kebijakan menjadi lebih terpadu antara norma, standar, prosedur, dan kriteria, pembiayaan publik, serta tata kelola layanan di semua jenjang.

Di bawah payung undang-undang, peraturan pelaksana memperjelas mandat layanan kesehatan jiwa sebagai layanan dasar yang harus tersedia di seluruh daerah. Standar pelayanan minimal bidang kesehatan mewajibkan pemerintah daerah menjamin layanan prioritas termasuk identifikasi, rujukan, dan penanganan masalah kesehatan jiwa. Ketentuan ini memperjelas bahwa pemenuhan hak atas layanan kesehatan jiwa bukan pilihan kebijakan, melainkan kewajiban layanan dasar yang kemajuannya harus dipantau melalui indikator kinerja daerah. Pada tataran operasional, pedoman penyelenggaraan kesehatan jiwa di fasilitas kesehatan tingkat pertama memberikan alur teknis promotif dan preventif, skrining dan deteksi dini, tatalaksana awal, manajemen rujukan, dan kesinambungan perawatan berbasis komunitas. Puskesmas ditempatkan sebagai ujung tombak integrasi layanan,

dengan penguatan jejaring bidan, perawat, psikolog, psikiater, kader, serta kemitraan dengan pemerintah desa dan organisasi masyarakat.

Integrasi kesehatan mental perempuan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional memperkuat keberlanjutan program. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional periode dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh empat menempatkan kesehatan jiwa dalam fokus penguatan layanan primer, pencegahan dan pengendalian penyakit, serta peningkatan derajat kesehatan keluarga. Arah ini diterjemahkan dalam rencana strategis sektor kesehatan melalui target deteksi dini, perluasan cakupan intervensi berbasis masyarakat, serta peningkatan kompetensi tenaga kesehatan di lini pertama. Pos kesehatan terpadu, posyandu keluarga, program sekolah sehat, dan kunjungan rumah berbasis keluarga menjadi wahana untuk mengarusutamakan kesehatan mental pada fase kehidupan yang rentan bagi perempuan, seperti remaja, calon pengantin, kehamilan, masa nifas, dan perimenopause.

Peta jalan ini selaras dengan komitmen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Target tiga titik empat menuntut negara mengurangi kematian dini akibat penyakit tidak menular sekaligus mempromosikan kesehatan mental dan kesejahteraan. Selain itu, Tujuan lima tentang kesetaraan gender memperkuat kewajiban negara untuk mencegah dan merespons kekerasan berbasis gender yang terbukti berkaitan erat dengan beban gangguan mental pada perempuan. Penyelarasan ini diadopsi ke dalam rencana aksi nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi acuan lintas kementerian, sehingga indikator dan kegiatan yang relevan dengan kesehatan mental perempuan dapat dianggarkan dan dimonitor secara rutin.

Keterkaitan dengan program nasional berbasis keluarga memperluas jangkauan intervensi. Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga memasukkan komponen kesehatan jiwa dalam penilaian keluarga sehat, sehingga skrining risiko dan konseling dasar dapat dilakukan dalam kunjungan rumah dan didukung peta sasaran keluarga berisiko. Agenda percepatan penurunan stunting, yang menempatkan remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai sasaran, membuka ruang integrasi konseling kesehatan mental ibu dan remaja sebagai bagian dari paket layanan esensial, mengingat dampak kesehatan mental ibu terhadap pengasuhan, menyusui, dan stimulasi tumbuh kembang anak. Seluruh paket intervensi ini dapat dibiayai melalui kombinasi anggaran pusat, daerah, bantuan operasional kesehatan untuk puskesmas, dan mekanisme pembiayaan jaminan kesehatan nasional.

Pembiayaan publik melalui jaminan kesehatan nasional merupakan simpul penting yang menjembatani regulasi dan layanan nyata. Skema ini menjamin pelayanan promotif dan preventif yang diamanatkan regulasi, layanan kuratif dan

rehabilitatif termasuk konsultasi dengan dokter spesialis kedokteran jiwa, psikoterapi sesuai indikasi, peresepan obat yang tercantum dalam formularium nasional, serta layanan rujukan berjenjang yang terstandar. Pembayaran kapitasi di layanan primer dan klaim di rumah sakit memberi insentif agar deteksi dini, rujukan tepat waktu, dan tatalaksana berkelanjutan dapat berjalan. Agar responsif terhadap kebutuhan perempuan, paket manfaat perlu dioperasionalkan melalui protokol skrining yang peka gender, misalnya deteksi depresi dan kecemasan pada masa antenatal dan nifas, serta rambu rujukan cepat untuk penyintas kekerasan.

Peran kelembagaan lintas sektor menentukan efektivitas implementasi. Kementerian Kesehatan memegang fungsi perumusan norma, standar, dan pedoman teknis; memimpin transformasi layanan primer; menguatkan kompetensi tenaga kesehatan; menata jejaring rujukan; serta mengembangkan sistem informasi kesehatan terintegrasi untuk pencatatan, pelaporan, dan pemantauan indikator yang terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memimpin intervensi berbasis keluarga, termasuk edukasi kesehatan reproduksi remaja, konseling pranikah, pendampingan ibu hamil dan menyusui, serta koordinasi percepatan penurunan stunting, sehingga isu kesehatan mental ibu dan remaja putri dapat ditangani secara lebih sistematis. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memastikan pengarusutamaan gender dalam perencanaan, penganggaran, dan pemantauan, sekaligus menyediakan layanan terpadu bagi penyintas kekerasan melalui unit pelaksana teknis daerah yang memberikan pendampingan psikologis, rujukan medis, dan bantuan hukum. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendorong lingkungan belajar yang aman dan sehat mental melalui program sekolah sehat, bimbingan konseling, dan edukasi literasi kesehatan mental. Kementerian Ketenagakerjaan memperkuat aspek keselamatan dan kesehatan kerja dengan memasukkan pencegahan kelelahan psikis, penanganan pelecehan dan perundungan di tempat kerja, serta kebijakan kerja yang ramah keluarga. Kementerian Sosial memberikan rehabilitasi sosial dan bantuan sosial bagi orang dengan gangguan jiwa berat dan keluarga rentan. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan orkestrasi perencanaan lintas sektor dan memastikan indikator masuk ke dokumen perencanaan, sementara BPJS Kesehatan mengelola pembiayaan dan memastikan kepatuhan fasilitas kesehatan terhadap standar pelayanan dan rujukan.

Kerangka hukum juga memperkuat perlindungan bagi perempuan yang mengalami kekerasan. Peraturan tentang tindak pidana kekerasan seksual menegaskan hak korban atas pemulihan yang meliputi layanan kesehatan fisik dan mental, pendampingan psikologis, dan dukungan sosial. Instrumen

pengarusutamaan gender pada tingkat nasional dan daerah mewajibkan setiap sektor untuk menilai dampak kebijakan terhadap perempuan dan laki-laki, memastikan anggaran responsif gender, dan memasukkan indikator terpilah dalam pemantauan. Dengan demikian, pencegahan kekerasan, penanganan korban, serta pemulihan psikologis menjadi bagian dari paket kebijakan yang berdampak langsung pada kesehatan mental perempuan.

C. Strategi Promotif dan Preventif

Strategi promotif dan preventif kesehatan mental perempuan perlu dibangun di atas pemahaman bahwa kebutuhan, hambatan, dan sumber daya perempuan berbeda menurut tahapan kehidupan serta konteks sosial budaya. Pendekatan yang digunakan sebaiknya berbasis daur hidup dan peka gender, memadukan peningkatan literasi kesehatan mental, penguatan kapasitas individu dan komunitas, serta integrasi yang rapi di layanan primer agar deteksi dini, rujukan, dan dukungan berkelanjutan berlangsung tanpa putus. Ketiga komponen ini saling menguatkan. Edukasi membentuk pengetahuan dan sikap, pemberdayaan memperluas pilihan dan daya kendali, sedangkan integrasi layanan memastikan ada pintu masuk yang jelas, jalur rujukan yang aman, serta pembiayaan dan data yang dapat dipantau.

Edukasi kesehatan mental berbasis gender menempatkan pengalaman perempuan sebagai titik berangkat. Materi edukasi tidak cukup berhenti pada definisi depresi, kecemasan, atau stres, tetapi perlu menyentuh keterkaitan antara peran gender, beban kerja domestik yang tidak dibayar, kekerasan dalam rumah tangga, tekanan ekonomi, dan tuntutan reproduktif. Pesan kunci disusun berbeda untuk remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu pada masa nifas, pekerja perempuan, dan perempuan pada masa perimenopause. Pada remaja putri, fokus yang relevan adalah keterampilan mengelola emosi, literasi kesehatan reproduksi, penanganan perundungan, dan pencarian bantuan yang aman. Pada calon pengantin, edukasi menekankan kesiapan mental, komunikasi pasangan, pembagian peran, serta rencana keuangan dasar. Pada ibu hamil dan ibu pada masa nifas, materi utamanya meliputi perubahan emosi normal, tanda bahaya yang perlu diwaspadai, strategi dukungan keluarga, dan jalur layanan yang tersedia. Pada pekerja perempuan, edukasi perlu memasukkan hak dan perlindungan di tempat kerja, pencegahan kelelahan psikis, serta mekanisme pengaduan pelecehan. Pada perimenopause, materi mengaitkan perubahan hormon dengan mood, tidur, dan relasi, disertai strategi gaya hidup dan rujukan bila diperlukan. Cara penyampaian mengikuti preferensi audiens. Kelas tatap muka yang dipandu tenaga kesehatan, modul singkat pada Posyandu dan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular, siaran radio komunitas, pesan singkat dan infografik digital, serta kelompok

dukungan sebaya dapat dipadukan. Bahasa yang digunakan harus sederhana, tidak menyalahkan, menghormati keragaman budaya dan agama, serta menghindari istilah yang menstigma. Di setiap sesi, fasilitator mempraktikkan teknik dasar seperti pernapasan diafragma, restrukturisasi pikiran sederhana, dan perencanaan aktivitas menyenangkan yang realistis, sehingga peserta pulang tidak hanya dengan pengetahuan tetapi juga keterampilan yang bisa langsung dilakukan.

Program pemberdayaan perempuan dan komunitas memperluas ruang aman agar edukasi berubah menjadi aksi yang bertahan. Pemberdayaan berarti memperbesar kapasitas perempuan mengambil keputusan atas tubuh, waktu, dan sumber dayanya sendiri, serta memperkuat dukungan sosial di sekitar mereka. Bentuk kegiatannya bisa berupa kelompok sebaya yang bertemu berkala dengan kurikulum terstruktur, misalnya siklus delapan hingga dua belas pertemuan yang membahas pengenalan emosi, pengasuhan responsif, komunikasi asertif, pengelolaan keuangan rumah tangga, hingga perencanaan keselamatan bagi penyintas kekerasan. Kader Posyandu, tokoh PKK, guru bimbingan konseling, tokoh agama, dan pekerja sosial lokal dilatih sebagai fasilitator agar keberlanjutan terjaga. Prinsip partisipatif dijalankan, sehingga anggota kelompok ikut menentukan topik prioritas, jam pertemuan, dan mekanisme dukungan, misalnya arisan penitipan anak saat pertemuan. Keterlibatan laki-laki yang signifikan bagi kehidupan peserta, seperti pasangan, ayah, atau mertua, diundang dalam sesi tertentu untuk membahas pembagian peran, teknik komunikasi tanpa kekerasan, dan dukungan emosional. Penguatan ekonomi mikro seperti pelatihan keterampilan dan literasi keuangan dapat disisipkan agar daya kendali atas pendapatan meningkat, sebab keamanan finansial berhubungan erat dengan kesehatan mental. Di desa dan kelurahan, program ini berjejaring dengan layanan perlindungan perempuan dan anak sehingga bila ada indikasi kekerasan, fasilitator dapat melakukan rujukan yang cepat, aman, dan menghormati kerahasiaan. Monitoring dilakukan sederhana tetapi konsisten, misalnya mencatat kehadiran, tema yang dibahas, dan umpan balik peserta, serta melakukan pengukuran singkat kondisi emosi pada awal dan akhir siklus pertemuan untuk memantau perubahan.

Integrasi layanan promotif dan preventif di fasilitas primer, terutama Puskesmas, Posyandu, dan jejaringnya, menjadi kunci agar upaya tidak terfragmentasi. Puskesmas berfungsi sebagai simpul koordinasi yang menghubungkan layanan klinis, kegiatan berbasis masyarakat, dan sistem rujukan. Unit Kesehatan Ibu dan Anak menjadi pintu utama untuk skrining gejala depresi dan kecemasan menggunakan alat baku yang ringkas. Pengisian alat skrining dilakukan pada kunjungan antenatal di trimester kedua dan ketiga, saat kunjungan nifas, serta ketika ibu datang untuk imunisasi anak. Pada layanan kesehatan remaja, skrining

singkat dilakukan pada kegiatan sekolah sehat, posyandu remaja, atau klinik ramah remaja. Petugas dilatih untuk melakukan wawancara dengan empati, menjamin kerahasiaan, dan memetakan faktor risiko, misalnya riwayat kekerasan, dukungan keluarga yang minim, atau masalah ekonomi berat. Hasil skrining dipakai untuk menentukan tindak lanjut. Bila gejala ringan, peserta menerima konseling singkat terstruktur dan dihubungkan dengan kelompok dukungan di komunitas. Bila gejala sedang atau berat, petugas melakukan rujukan terencana ke psikolog klinis atau dokter spesialis kedokteran jiwa dengan pendampingan aktif. Puskesmas menyusun peta jejaring rujukan, termasuk rumah sakit, layanan perlindungan perempuan dan anak, pekerja sosial, serta layanan hukum, sehingga penanganan berjalan komprehensif. Posyandu berperan sebagai wahana promosi dan penjangkaran. Kader melakukan edukasi singkat saat kegiatan timbang dan imunisasi, membagikan lembar informasi, serta membantu skrining sederhana. Kader juga memantau tindak lanjut, misalnya memastikan ibu yang dirujuk benar datang ke Puskesmas atau layanan rujukan. Agar alur berjalan mulus, Puskesmas menyelenggarakan lokakarya mini setiap satu atau dua bulan untuk meninjau data, memecahkan masalah operasional, dan memperbarui peta kasus. Pencatatan dipadukan dengan sistem informasi kesehatan yang sudah ada, indikator dipilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur, dan hasilnya dipakai untuk perbaikan mutu menggunakan siklus rencana, jalankan, pelajari, dan tindak lanjuti.

Ketiga pilar tersebut perlu ditopang oleh penguatan tenaga dan pembiayaan. Puskesmas menugaskan penanggung jawab program kesehatan jiwa yang bekerja erat dengan program kesehatan ibu dan anak, kesehatan remaja, serta penyakit tidak menular. Pelatihan berjenjang dirancang agar dokter, bidan, perawat, dan psikolog menguasai konseling singkat, pertolongan pertama psikologis, dan manajemen kasus sederhana, sementara kader menguasai keterampilan dasar deteksi dini dan rujukan. Skema pembiayaan memanfaatkan anggaran operasional Puskesmas, dukungan pemerintah daerah, serta manfaat jaminan kesehatan nasional untuk konsultasi dan tata laksana yang sesuai indikasi. Keberlanjutan juga memerlukan komunikasi publik yang konsisten. Pesan anti stigma, kisah pemulihan, dan informasi jalur layanan disiarkan secara berkala melalui media lokal dan kanal digital. Pelibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemimpin perempuan setempat meningkatkan penerimaan komunitas dan mempercepat perubahan norma.

Dengan desain seperti ini, strategi promotif dan preventif tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga mengubah perilaku, memperkuat dukungan sosial, serta memperpendek jarak antara keluarga dan layanan. Perempuan di berbagai tahapan kehidupan memperoleh ruang aman untuk belajar, bertukar

pengalaman, dan mencari bantuan, sementara Puskesmas dan Posyandu menyediakan alur yang jelas dari edukasi, skrining, konseling, hingga rujukan. Hasil akhirnya adalah penurunan beban gangguan mental, peningkatan kualitas hidup, dan keluarga yang lebih tangguh, yang pada gilirannya memperkuat pembangunan manusia di tingkat desa, kota, dan nasional.

D. Strategi Kuratif dan Rehabilitatif

Strategi kuratif dan rehabilitatif kesehatan mental perempuan perlu dirancang sebagai sebuah kesinambungan layanan yang dimulai sejak pintu masuk di tingkat primer, terhubung rapi dengan tingkat rujukan, dan berlanjut ke pemulihan berbasis komunitas. Orientasinya bukan hanya meredakan gejala, tetapi memulihkan peran sosial, produktivitas, dan kualitas hidup. Dengan kerangka ini, seorang perempuan yang datang dengan keluhan emosional di Puskesmas tidak berhenti pada diagnosis semata, melainkan mendapat paket tatalaksana yang jelas, aman, dan berlanjut hingga ia benar-benar pulih dan kembali berdaya.

Akses layanan di tingkat primer menjadi penentu pertama keberhasilan. Puskesmas beserta jejaringnya harus siap menjadi tempat konsultasi awal yang ramah perempuan, menjaga kerahasiaan, dan peka terhadap kekerasan berbasis gender. Di sini, tenaga kesehatan melakukan asesmen klinis dan sosial secara menyeluruh, termasuk penilaian keparahan gejala, risiko bunuh diri, kondisi kehamilan atau menyusui, penyakit penyerta, dukungan keluarga, serta faktor pemicu di rumah dan pekerjaan. Untuk kasus ringan sampai sedang, layanan primer menyediakan konseling singkat terstruktur, misalnya terapi berbasis pemecahan masalah atau pendekatan kognitif-perilaku sederhana dalam beberapa sesi yang terjadwal. Konselor, perawat, atau bidan yang telah dilatih menjalankan intervensi ini dengan supervisi berkala dari psikolog atau psikiater. Pendekatan berbasis pengukuran diterapkan agar keputusan klinis tidak bergantung pada kesan semata, melainkan pada perubahan skor gejala yang dipantau dari waktu ke waktu. Bila ditemukan risiko tinggi seperti ide bunuh diri aktif, gejala psikotik, mania, atau depresi perinatal berat, tenaga kesehatan primer menyiapkan rujukan segera dan aman ke fasilitas rujukan, dengan pendampingan serta informasi tertulis mengenai temuan klinis.

Ketersediaan psikolog, psikiater, dan konselor harus diatur melalui model kolaboratif. Wilayah dengan keterbatasan tenaga spesialis memanfaatkan konsultasi jarak jauh, klinik satelit berkala, serta konferensi kasus multidisiplin yang menghubungkan dokter layanan primer dengan psikolog klinis dan psikiater di rumah sakit. Pada jam-jam tertentu, tenaga spesialis membuka jendela konsultasi terjadwal untuk menelaah kasus yang dirujuk balik, memberi umpan balik rencana

terapi, dan menegaskan kriteria rujuk ulang bila terjadi perburukan. Pembiayaan dari jaminan kesehatan digunakan untuk memastikan konsultasi, psikoterapi yang diindikasikan, dan farmakoterapi yang sesuai formularium dapat diakses tanpa beban biaya yang menghalangi. Keputusan penggunaan obat mempertimbangkan fase kehidupan perempuan, khususnya kehamilan dan menyusui. Pada kondisi ini, prinsip kehati-hatian, penilaian manfaat dan risiko, serta pilihan terapi nonfarmakologis yang diperkuat dukungan keluarga menjadi bagian dari diskusi klinis yang transparan.

Layanan berbasis rumah sakit melengkapi kebutuhan yang tidak dapat ditangani di tingkat primer. Instalasi gawat darurat menyiapkan tata laksana krisis psikologis dan psikiatris, termasuk manajemen agitasi, percobaan bunuh diri, atau kondisi psikotik akut. Ruang rawat inap menyediakan stabilisasi, penyesuaian terapi, dan perencanaan pulang yang matang. Unit konsultasi-liaison bekerja lintas bagian untuk menangani komorbid seperti penyakit jantung, endokrin, atau obstetri yang sering hadir bersamaan dengan gangguan mental pada perempuan. Layanan khusus keibuan seperti klinik kejiwaan perinatal sangat penting untuk menilai dan menangani depresi kehamilan, depresi pascapersalinan, kecemasan, gangguan obsesif kompulsif, hingga psikosis pascapersalinan, sembari melindungi ikatan ibu dan bayi serta keberlanjutan menyusui. Di rumah sakit juga tersedia intervensi yang membutuhkan sarana dan pengawasan ketat, termasuk terapi fisik tertentu, penyesuaian obat yang kompleks, dan program rawat siang yang menyediakan psikoterapi intensif tanpa perlu rawat inap penuh.

Meski rumah sakit memegang peran penting, pemulihan terbaik sering terjadi di komunitas. Tim kesehatan jiwa berbasis masyarakat menjadi jembatan antara perawatan klinis dan kehidupan sehari-hari. Mereka melakukan kunjungan rumah terencana, memantau kepatuhan terapi, menilai kembali faktor stres di lingkungan, dan mengaktifkan dukungan keluarga serta tetangga. Kelompok dukungan sebaya bagi ibu pascapersalinan, remaja putri, perempuan pekerja, atau perempuan pada masa perimenopause menyediakan ruang aman untuk berbagi strategi menghadapi gejala, mengatasi stigma, dan membangun rutinitas sehat. Kader di Posyandu dan organisasi perempuan lokal dilatih untuk mengenali tanda kekambuhan dini, memahami cara merespons krisis emosional, dan menghubungkan warga dengan Puskesmas atau layanan rujukan ketika diperlukan. Pada wilayah dengan tantangan geografis, telekonseling dan temu tatap muka hibrida memastikan kontinuitas, sementara pengingat digital membantu keteraturan kunjungan dan minum obat.

Rehabilitasi berorientasi pemulihan adalah fase yang menyatukan aspek klinis dengan tujuan hidup yang bermakna. Setiap pasien menyusun rencana pemulihan pribadi bersama tim layanan, menetapkan sasaran yang realistis seperti kembali

bekerja, melanjutkan pendidikan, memperbaiki relasi dengan pasangan, atau memperkuat peran sebagai orang tua. Modul psikoedukasi keluarga menjelaskan hakikat gangguan, cara mendukung tanpa mengontrol, teknik komunikasi yang mengurangi konflik, dan rencana menghadapi situasi krisis. Pendekatan pencegahan kekambuhan dibuat konkrit melalui daftar tanda peringatan dini, strategi mengatasi pemicu, dan kartu rencana keselamatan yang berisi kontak darurat serta langkah yang perlu dilakukan oleh anggota keluarga ketika gejala muncul kembali.

Dukungan sosial ekonomi adalah bagian integral dari rehabilitasi. Banyak perempuan terhambat pemulihannya karena hambatan finansial, kekerasan dalam rumah tangga, atau ketergantungan ekonomi. Oleh sebab itu, layanan kesehatan berjejaring dengan layanan perlindungan perempuan dan anak, bantuan hukum, dan program perlindungan sosial agar penyintas mendapatkan tempat aman, pendampingan hukum, serta bantuan sementara. Program pelatihan keterampilan, penempatan kerja yang didukung, dan kewirausahaan mikro memberi jalan kembali pada kemandirian. Bagi perempuan muda, dukungan untuk kembali bersekolah atau mengikuti pelatihan vokasi menjadi prioritas. Semua intervensi ini menghormati pilihan pasien, memperhatikan pengasuhan anak, dan fleksibel terhadap jadwal serta peran domestik.

Keberhasilan kuratif dan rehabilitatif bertumpu pada perencanaan pulang yang tidak tergesa-gesa. Setiap pasien yang keluar dari rumah sakit atau menyelesaikan fase intensif terapi menerima jadwal kunjungan tindak lanjut yang jelas, kontak yang dapat dihubungi ketika terjadi krisis, serta rujukan balik yang aktif ke Puskesmas atau psikolog setempat. Masa kritis beberapa minggu setelah pulang dipantau ketat melalui panggilan telepon, pesan singkat, atau kunjungan rumah. Pengelolaan obat dijelaskan rinci, mencakup manfaat, efek samping, interaksi, dan kapan harus segera kembali bila muncul keluhan. Untuk ibu pascapersalinan, jadwal kontrol diselaraskan dengan jadwal imunisasi bayi agar akses lebih mudah dan dukungan keluarga dapat dimobilisasi.

Penguatan mutu layanan dilakukan secara sistematis. Fasilitas menetapkan indikator sederhana namun bermakna, seperti proporsi pasien yang mendapat rencana pemulihan tertulis, tindak lanjut tujuh hari pascadischarge, penurunan skor gejala pada kunjungan kontrol, dan angka kunjungan ulang ke instalasi gawat darurat. Data dipilah menurut kelompok umur dan jenis kelamin agar kesenjangan pada perempuan mudah dikenali. Siklus perbaikan mutu dijalankan berkala melalui pertemuan tim, telaah kasus, dan pembaruan alur rujukan bila ditemukan hambatan. Suara pasien dan keluarga dihimpun melalui umpan balik singkat tentang pengalaman layanan, rasa aman, dan dukungan yang dirasakan.

Keseluruhan strategi ini bekerja ketika setiap komponen saling terhubung. Puskesmas memastikan penilaian awal yang komprehensif dan intervensi berbasis bukti untuk kasus ringan sampai sedang. Rumah sakit menangani kondisi berat, krisis, dan kebutuhan terapi khusus, sekaligus menyiapkan rencana pulang yang matang. Tim komunitas menjaga kontinuitas, menghubungkan pasien dengan sumber daya sosial, dan memfasilitasi kembalinya peran sosial yang bermakna. Di atas semuanya, pendekatan yang berpusat pada perempuan, peka terhadap fase kehidupan dan pengalaman kekerasan, serta menghormati pilihan individu menjadi kunci. Dengan rancangan yang demikian, strategi kuratif dan rehabilitatif tidak hanya menurunkan gejala, tetapi benar-benar memulihkan kehidupan.

E. Peran Lintas Sektor dan Kolaborasi

Penguatan kesehatan mental perempuan tidak dapat ditangani oleh sektor kesehatan saja. Kebutuhan perempuan terbentang dari ruang domestik, sekolah, tempat kerja, hingga ranah hukum, sehingga strategi yang efektif harus mengorkestrasi upaya berbagai sektor dengan arah yang sama dan indikator yang disepakati. Sinergi dimulai dari penetapan sasaran bersama yang terukur, misalnya penurunan gejala depresi pada ibu hamil dan pascapersalinan di wilayah puskesmas tertentu, peningkatan skor kesejahteraan psikologis remaja putri di sekolah yang menjadi binaan, serta berkurangnya kasus kekerasan yang berulang pada perempuan yang telah menerima layanan. Sasaran ini diterjemahkan ke dalam rencana aksi lintas dinas di tingkat kabupaten atau kota, lengkap dengan peran, jalur rujukan, standar waktu respons, dan pembiayaan. Dinas kesehatan memimpin penegakan standar klinis, pelatihan tenaga puskesmas, pencatatan indikator yang terpilah menurut jenis kelamin dan usia, serta penguatan layanan ramah perempuan. Dinas pendidikan memastikan ekosistem belajar yang aman melalui kebijakan anti perundungan, penguatan bimbingan konseling, dan penyisipan literasi kesehatan mental dalam kurikulum serta kegiatan sekolah sehat. Dinas ketenagakerjaan mengarusutamakan pencegahan kelelahan psikis, kebijakan kerja yang ramah keluarga, mekanisme pengaduan pelecehan di tempat kerja, serta program kembali bekerja yang memadai setelah krisis kesehatan mental. Aparat penegak hukum bersama layanan perlindungan perempuan dan anak menegakkan perlindungan, menyediakan pendampingan psikologis dan hukum, serta menjamin kerahasiaan dan keselamatan korban. Sinergi ini berjalan efektif ketika ada sekretariat bersama lintas sektor yang bertemu secara berkala, memeriksa kendala operasional, meninjau data terbaru, dan memperbarui peta rujukan agar tidak ada perempuan yang terhenti di tengah layanan.

Di tingkat layanan, sinergi antarsektor terwujud dalam skema rujukan yang konkret. Seorang ibu yang teridentifikasi mengalami depresi perinatal di puskesmas segera mendapatkan konseling singkat terstruktur, dukungan keluarga, serta rujukan terencana ke psikolog klinis atau psikiater apabila diperlukan, dengan jadwal yang telah ditentukan dan pendampingan yang jelas. Bila terdeteksi ada relasi yang penuh kekerasan, petugas menghubungkan pasien dengan unit layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak, memastikan akses tempat aman, bantuan hukum, serta dukungan sosial. Bagi remaja putri, jalur rujukan menghubungkan sekolah, puskesmas, dan layanan konseling ramah remaja. Bagi pekerja perempuan, jalur rujukan melibatkan klinik perusahaan atau fasilitas kesehatan kerja, serikat pekerja, dan dinas ketenagakerjaan untuk mengatur penyesuaian beban kerja dan perlindungan dari perundungan. Setiap jalur rujukan memiliki batas waktu respons, formulir ringkas yang melindungi privasi, serta kontak penanggung jawab yang mudah dihubungi. Kejelasan ini mencegah perempuan harus menceritakan ulang pengalaman traumatis berkali kali dan meminimalkan risiko putus layanan.

Kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga internasional memperkaya kualitas desain, mempercepat inovasi, dan memperluas jangkauan. Organisasi masyarakat sipil menjadi jembatan ke komunitas dengan kepercayaan tinggi, terutama di wilayah yang stigma terhadap kesehatan mental masih kuat. Mereka menjalankan kelompok dukungan sebaya untuk ibu pascapersalinan, komunitas remaja putri, atau pekerja perempuan, menyediakan konseling dasar, serta memfasilitasi rencana keselamatan bagi penyintas kekerasan. Mereka juga mengembangkan materi komunikasi yang peka budaya, merekrut dan melatih kader lokal, serta melakukan penjangkauan ke kelompok yang sulit dijangkau seperti pekerja migran atau perempuan yang tinggal di daerah terpencil. Lembaga internasional menyediakan dukungan teknis, paket pelatihan, dan pembelajaran lintas negara. Adaptasi dilakukan dengan hati-hati agar pendekatan yang digunakan sesuai dengan konteks lokal, bahasa, norma, dan sistem layanan yang ada. Setiap dukungan eksternal sebaiknya memuat strategi keluar yang jelas agar kapasitas lokal tetap bertahan setelah proyek selesai, termasuk menyerahkan materi pelatihan, sistem pemantauan, dan mekanisme pendanaan mikro agar kelompok dukungan tetap berjalan.

Kunci kolaborasi yang sehat adalah tata kelola yang transparan. Nota kesepahaman mencantumkan tujuan, indikator, pembagian tugas, standar layanan yang dirujuk bersama, mekanisme pengaduan, dan pengaturan data. Pengelolaan data mengikuti prinsip minimalisasi, persetujuan yang diinformasikan, dan perlindungan kerahasiaan. Data yang dipertukarkan cukup untuk kesinambungan layanan, misalnya nama inisial, usia, hasil skrining ringkas, dan rencana tindak lanjut.

Data untuk keperluan evaluasi diolah dalam bentuk agregat yang tidak mengungkap identitas. Forum koordinasi menyertakan perwakilan perempuan yang menjadi penerima manfaat agar suara pengguna layanan ikut membentuk perbaikan desain. Pendanaan disusun dari berbagai sumber, termasuk anggaran daerah, dukungan pusat, hibah filantropi, dan dana perusahaan melalui tanggung jawab sosial, dengan laporan penggunaan yang sederhana tetapi akuntabel.

Media memegang peran strategis dalam membentuk persepsi publik. Pemberitaan yang sensasional dan penggunaan istilah yang merendahkan memperkuat stigma dan membuat perempuan enggan mencari bantuan. Sebaliknya, pelatihan bagi jurnalis dan editor tentang peliputan isu kesehatan mental yang etis akan menghasilkan narasi yang empatik, akurat, dan aman. Redaksi menyusun pedoman gaya yang menghindari label yang menstigma, menggunakan bahasa yang menempatkan manusia lebih dahulu, dan menautkan informasi tentang jalur bantuan serta layanan yang tersedia. Konten yang mengangkat kisah pemulihan, strategi menghadapi gejala, dan dukungan keluarga membantu masyarakat melihat bahwa gangguan mental dapat ditangani dan pemulihan itu mungkin. Kampanye publik menggabungkan media arus utama, radio komunitas, dan platform digital. Komunikasi melibatkan tokoh agama, pemimpin perempuan setempat, dan figur panutan yang dipercaya. Media sosial dimanfaatkan untuk edukasi yang singkat dan interaktif, misalnya kuis gejala ringan, tips mengelola stres, dan panduan mencari bantuan. Pemantauan percakapan daring membantu pemerintah daerah dan mitra memahami isu yang sedang ramai, misalnya kekhawatiran terhadap efek samping obat atau kebingungan mengenai jalur rujukan, sehingga pesan perbaikan dapat disiapkan segera.

Efektivitas peran media akan meningkat jika diikat dengan praktik layanan. Setiap kampanye publik diselaraskan dengan kesiapan fasilitas terdekat agar lonjakan pencari layanan dapat ditangani. Nomor kontak puskesmas, jam layanan konseling, serta prosedur pendaftaran daring disampaikan dengan jelas. Untuk wilayah yang sumber dayanya terbatas, kampanye dibuat bertahap agar tidak menimbulkan antrean panjang yang melelahkan dan mematahkan semangat pencari bantuan. Media juga dapat menjadi mitra akuntabilitas dengan menyoroti data kemajuan program, kisah praktik baik, dan tantangan yang perlu dukungan publik. Ketika media menjalankan fungsi kontrol sosial yang konstruktif, pemerintah daerah dan dinas terkait terdorong untuk memperbaiki celah layanan tanpa merasa diserang.

F. Pendekatan Berbasis Gender dan Budaya

Pendekatan berbasis gender dan budaya dalam kesehatan mental perempuan bermula dari pengakuan bahwa pengalaman, risiko, dan hambatan perempuan berbeda menurut peran sosial, usia, status ekonomi, bahasa, dan kepercayaan. Karena itu kebijakan dan layanan tidak cukup netral, melainkan harus secara sengaja mengarusutamakan gender sejak tahap perencanaan hingga evaluasi, sekaligus peka terhadap keragaman budaya dan agama yang membentuk cara perempuan memberi makna terhadap emosi, gejala, dan pencarian bantuan. Tujuannya sederhana tetapi menuntut disiplin kelembagaan, yaitu agar setiap perempuan dapat mengakses dukungan yang aman, bermutu, dan relevan dengan kehidupannya, serta pulih sampai kembali berdaya di keluarga, sekolah, tempat kerja, dan komunitas.

Pengarusutamaan gender dalam kebijakan kesehatan mental berarti integrasi perspektif gender pada seluruh siklus kebijakan. Analisis gender dilakukan terlebih dahulu untuk memetakan siapa yang tertinggal, bagian alur layanan mana yang berisiko meminggirkan perempuan, serta sumber daya apa yang perlu dialihkan. Hasil analisis dituangkan dalam tujuan dan indikator yang terpilah menurut jenis kelamin, usia, lokasi, disabilitas, serta status sosial ekonomi. Perencanaan dan penganggaran responsif gender memastikan ada sumber daya bagi layanan yang benar benar dibutuhkan perempuan, misalnya jam layanan yang fleksibel bagi ibu bekerja, ruang konseling yang menjamin privasi, pelibatan tenaga kesehatan perempuan di titik layanan tertentu, serta dukungan transportasi atau penitipan anak ketika perempuan harus menjalani sesi konseling. Standar operasional di puskesmas, pos layanan terpadu, dan rumah sakit menyisipkan protokol skrining yang peka gender pada kunjungan antenatal, kunjungan masa nifas, pelayanan keluarga berencana, klinik remaja, dan klinik penyakit tidak menular. Di setiap titik kontak digunakan alat skrining yang tervalidasi untuk depresi dan kecemasan, termasuk alat khusus untuk periode kehamilan dan pascapersalinan. Proses rujukan dirancang agar perempuan tidak perlu menceritakan ulang pengalaman traumatis berkali kali, dengan formulir ringkas, batas waktu respons yang jelas, dan pendampingan yang menghormati kerahasiaan. Pemantauan kinerja mengukur bukan hanya jumlah yang disaring dan dirujuk, tetapi juga waktu tunggu, ketercapaian kunjungan ulang, dan kepuasan pasien, semuanya dipilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur sehingga ketimpangan mudah terlihat dan dapat diperbaiki.

Sensitivitas budaya dan agama dalam intervensi kesehatan mental menuntut kemampuan klinis sekaligus kepekaan antropologis. Layanan dimulai dengan memahami bahasa dan konsep lokal tentang rasa sedih, cemas, atau malu, karena

tidak semua perempuan mengekspresikan distress dengan istilah medis. Tenaga kesehatan menggunakan bahasa yang tidak menghakimi, menghindari label yang menstigma, dan memvalidasi pengalaman pasien sebelum menawarkan penjelasan klinis. Materi edukasi disesuaikan dengan konteks setempat, misalnya menggunakan peribahasa atau kisah pendek yang akrab di telinga warga, serta contoh kegiatan koping yang sejalan dengan norma komunitas. Dalam konteks keagamaan, banyak perempuan memaknai doa, ibadah, dan dukungan tokoh agama sebagai sumber kekuatan. Layanan memfasilitasi hal tersebut tanpa mengaburkan batas profesional, yaitu dengan membuka ruang bagi strategi spiritual yang dipilih pasien sepanjang tidak menggantikan terapi yang diperlukan. Jadwal sesi konseling memperhatikan waktu ibadah, kegiatan adat, dan peran domestik pasien. Di wilayah yang multibahasa, tersedia penerjemah terlatih atau pekerja sosial lokal yang memahami etika kerahasiaan. Staf mendapatkan pelatihan kompetensi budaya dan agama, termasuk cara merespons keyakinan yang keliru tentang kesehatan mental dengan cara yang sopan dan efektif. Prinsip *do no harm* menjadi pagar bersama, sehingga intervensi tidak menegasikan nilai lokal tetapi juga tidak memperkuat praktik yang merugikan kesehatan perempuan, seperti pembatasan akses layanan atau normalisasi kekerasan dengan dalih tradisi.

Kebijakan afirmatif untuk kelompok perempuan rentan menempatkan dukungan yang lebih intensif di tempat yang risikonya lebih tinggi. Pada ibu hamil dan ibu masa nifas, dilakukan skrining universal untuk depresi dan kecemasan pada beberapa titik kunjungan, konseling singkat terstruktur di lini pertama, serta rujukan cepat bila ditemukan gejala sedang hingga berat atau risiko keselamatan. Klinik kejiwaan perinatal dan tim laktasi terintegrasi membantu penatalaksanaan yang aman selama kehamilan dan menyusui, termasuk edukasi mengenai obat, dukungan menyusui, serta penguatan ikatan ibu dan bayi. Jadwal kontrol diselaraskan dengan jadwal imunisasi anak agar akses lebih mudah. Kunjungan rumah oleh tim kesehatan jiwa berbasis komunitas menjadi jembatan antara perawatan klinis dan rutinitas pengasuhan, terutama bagi ibu yang kesulitan mobilitas atau tinggal jauh dari fasilitas.

Bagi pekerja migran perempuan, kebijakan afirmatif hadir sebelum keberangkatan, selama bekerja, dan saat kembali. Sebelum berangkat, calon pekerja menerima pendidikan singkat mengenai stres adaptasi, hak atas kesehatan, jalur bantuan ketika mengalami pelecehan, serta latihan keterampilan mengatasi tekanan. Selama bekerja, disediakan saluran konseling jarak jauh yang aman dan rahasia, serta kemitraan dengan organisasi diaspora atau serikat pekerja untuk dukungan sebaya. Ketika kembali ke tanah air, puskesmas melakukan skrining ulang, menilai kebutuhan psikologis dan sosial ekonomi, serta menghubungkan dengan

program reintegrasi seperti pelatihan kerja, kewirausahaan mikro, atau bantuan sosial sementara bila diperlukan. Seluruh jalur ini dilengkapi mekanisme rujukan ke layanan perlindungan perempuan dan anak ketika terdapat indikasi kekerasan atau eksploitasi.

Untuk penyintas kekerasan, kerangka kerja trauma informed care menjadi prinsip utama. Kontak awal dilakukan dengan memastikan keselamatan fisik dan emosional, menjamin kerahasiaan, serta memberi pilihan nyata bagi pasien agar ia memegang kendali atas keputusan perawatan. Layanan satu atap memudahkan akses pendampingan psikologis, dukungan medis, bantuan hukum, dan tempat aman sementara. Rencana keselamatan disusun bersama pasien, mencakup tanda bahaya, orang kepercayaan yang dapat dihubungi, dan langkah yang harus dilakukan ketika terjadi krisis. Intervensi klinis dikombinasikan dengan dukungan sosial ekonomi karena banyak penyintas terikat secara finansial pada pelaku. Program pelatihan keterampilan, penempatan kerja yang didukung, dan dukungan pengasuhan anak membantu pemulihan yang berkelanjutan. Setiap kontak layanan menghindari pertanyaan yang menyalahkan, serta meminimalkan kebutuhan pasien untuk mengulang cerita yang menyakitkan.

Semua kebijakan afirmatif membutuhkan tata kelola yang konsisten. Pemerintah daerah menetapkan koordinator lintas sektor yang memimpin peta rujukan, lokakarya mini berkala, dan telaah kasus. Tenaga kesehatan, pekerja sosial, polisi, tokoh agama, dan organisasi masyarakat sipil duduk bersama untuk menyepakati standar waktu respons, format komunikasi yang aman, serta pembagian peran. Data dipilah menurut jenis kelamin, kelompok umur, lokasi, dan disabilitas, lalu dianalisis untuk melihat apakah perempuan dari kelompok tertentu masih tertinggal. Hasil analisis dikembalikan kepada pelaksana lapangan dalam bentuk umpan balik yang jelas agar perbaikan dapat segera dilakukan. Perencanaan dan penganggaran responsif gender memastikan komponen pelatihan, penyediaan ruang aman, penerjemah, transportasi, dan penitipan anak benar benar mendapatkan dukungan dana, bukan sekadar tertulis di dokumen.

G. Tantangan Implementasi Kebijakan

Upaya memperkuat kesehatan mental perempuan sering kali tersendat bukan pada ketiadaan kebijakan, melainkan pada hambatan yang muncul saat kebijakan diterjemahkan menjadi layanan nyata. Tiga penghalang utama yang saling berkaitan adalah stigma sosial yang melekat pada isu kesehatan mental perempuan, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dan terdistribusi merata, serta kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Ketiganya bekerja

sebagai mata rantai yang jika tidak ditangani bersama akan membuat cakupan dan mutu layanan sulit meningkat secara berkelanjutan.

Stigma sosial terhadap kesehatan mental perempuan hadir dalam banyak bentuk, mulai dari stereotip bahwa perempuan yang mengungkapkan rasa sedih dianggap lemah, hingga keyakinan bahwa gejala depresi pascapersalinan adalah bagian normal dari menjadi ibu dan karenanya harus ditanggung sendiri. Stigma ini beroperasi di tiga tingkat. Pada tingkat individu, banyak perempuan menginternalisasi rasa malu sehingga menunda mencari pertolongan, menyembunyikan gejala dari pasangan dan keluarga, atau berhenti berobat ketika mulai merasa lebih baik karena takut dilabeli. Pada tingkat keluarga dan komunitas, komentar yang meremehkan, gosip, atau saran yang menyalahkan korban membuat perempuan semakin enggan mengakses layanan. Pada tingkat kelembagaan, stigma dapat muncul dalam bentuk layanan yang tidak ramah, ruang konsultasi yang tidak menjaga kerahasiaan, atau prosedur rujukan yang berbelit yang secara tidak langsung mengomunikasikan bahwa masalah mereka tidak dianggap penting. Dalam konteks ini, penyintas kekerasan menghadapi lapisan rintangan tambahan karena takut pada pembalasan, ketergantungan ekonomi, dan norma yang menormalisasi kekerasan domestik. Selama stigma tidak ditangani secara sistemik, intervensi teknis seperti skrining dan konseling akan kehilangan daya karena pintu masuknya tidak benar-benar digunakan.

Keterbatasan sumber daya manusia adalah tantangan struktural yang menghambat kualitas dan kontinuitas layanan dari hulu ke hilir. Ketersediaan psikiater, psikolog klinis, dan konselor terlatih masih jauh dari kebutuhan, dengan konsentrasi yang berat di kota-kota besar dan rumah sakit rujukan. Puskesmas di banyak daerah kesulitan mendapatkan tenaga dengan kompetensi psikoterapi dasar, sementara bidan dan perawat yang menjadi garda depan dalam layanan ibu dan anak jarang menerima pelatihan berjenjang mengenai kesehatan mental perinatal dan penanganan awal krisis. Di sisi lain, beban kerja tinggi dan minimnya supervisi klinis berisiko memicu kelelahan emosional pada tenaga kesehatan, menurunkan empati, dan memperlemah kualitas hubungan terapeutik. Jalur karier bagi tenaga kesehatan jiwa di level primer belum selalu jelas, sehingga retensi menjadi masalah, terutama di daerah yang jauh dari pusat. Keterbatasan ini juga terlihat pada kurangnya tenaga pendukung seperti pekerja sosial dan pendamping sebaya yang berperan penting pada fase rehabilitasi dan reintegrasi. Tanpa strategi pengembangan tenaga yang terencana, pelatihan yang berulang, dan supervisi yang rutin, implementasi kebijakan akan bergantung pada individu yang kebetulan antusias, bukan pada sistem yang kuat.

Kesenjangan akses layanan antara wilayah perkotaan dan pedesaan menambah ketidakadilan yang dialami perempuan. Di kota besar, layanan lebih beragam dan dekat, namun antrean panjang dan biaya tidak langsung tetap menjadi penghalang. Di pedesaan dan wilayah kepulauan, persoalannya berlapis. Jarak ke fasilitas rujukan memakan waktu dan biaya, transportasi umum terbatas, dan jaringan komunikasi digital tidak selalu dapat diandalkan. Ketika telekonseling atau telepsikiatri ditawarkan sebagai solusi, literasi digital, ketersediaan perangkat, dan kekhawatiran tentang kerahasiaan sering menjadi hambatan. Bahasa lokal dan perbedaan budaya memperumit komunikasi, sedangkan di komunitas kecil kerahasiaan sulit dijaga karena semua orang saling mengenal. Kondisi ini diperberat oleh ketersediaan obat yang tidak selalu konsisten dan terbatasnya ruang aman untuk konseling, sehingga tenaga kesehatan kesulitan menegakkan standar privasi yang diperlukan dalam layanan kesehatan mental. Ketimpangan ini membuat indikator capaian terlihat baik di rata rata, tetapi menutupi kantong kantong wilayah yang tertinggal dan kelompok perempuan yang paling membutuhkan.

Ketiga tantangan tersebut juga memiliki dimensi tata kelola yang kerap luput dari perhatian. Sistem pencatatan dan pelaporan belum selalu memisahkan data menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi, sehingga sulit mendeteksi apakah perempuan di pedesaan benar benar terlayani atau apakah penyintas kekerasan memperoleh rujukan komprehensif. Mekanisme pendanaan terkadang tidak fleksibel, membuat puskesmas sulit membiayai kebutuhan yang sangat praktis seperti transportasi pasien, penitipan anak selama sesi konseling, atau penerjemah lokal. Di banyak tempat, jejaring rujukan antara puskesmas, rumah sakit, layanan perlindungan perempuan dan anak, dan aparat penegak hukum belum memiliki standar waktu respons dan format komunikasi yang disepakati, sehingga perempuan harus mengulang cerita traumatis kepada banyak petugas, dengan risiko putus di tengah jalan.

Dampak kumulatif dari stigma, kekurangan tenaga, dan kesenjangan akses adalah rendahnya pemanfaatan layanan oleh mereka yang paling membutuhkan, keterlambatan penanganan hingga masalah memburuk, serta angka putus berobat yang tinggi. Akibatnya, beban sosial dan ekonomi meningkat, bukan hanya bagi perempuan itu sendiri tetapi juga bagi keluarga dan komunitas. Anak anak berisiko kehilangan pengasuhan yang peka, pasangan menghadapi ketegangan yang berlarut, dan produktivitas rumah tangga menurun. Di tingkat kebijakan, hal ini tercermin sebagai jurang antara target yang tercantum dalam rencana strategis dan kemajuan yang benar benar terjadi di lapangan.

Mengurai tantangan implementasi kebijakan berarti menempatkan perempuan sebagai pusat perancangan layanan dan memandang masalah melalui

lensa sistem. Stigma sosial harus dihadapi dengan strategi komunikasi publik yang konsisten yang diikat pada kesiapan layanan agar permintaan yang meningkat dapat dilayani dengan bermartabat. Keterbatasan sumber daya manusia perlu dijawab dengan peta kebutuhan tenaga yang jelas, kurikulum pelatihan berjenjang, supervisi klinis yang rutin, dan jalur karier yang membuat tenaga bertahan di layanan primer. Kesenjangan kota desa menuntut kombinasi intervensi daring dan luring, penguatan logistik obat, dan investasi pada ruang aman serta kader lokal yang dipercaya. Tanpa itu semua, kebijakan akan tetap kuat di atas kertas, tetapi rapuh saat bersentuhan dengan realitas hidup perempuan di berbagai penjuru Indonesia.

H. Inovasi dan Teknologi dalam Kebijakan Kesehatan Mental

Pemanfaatan inovasi dan teknologi dalam kebijakan kesehatan mental membuka peluang untuk memperluas jangkauan layanan, mempercepat waktu respons, dan menyesuaikan intervensi dengan kebutuhan nyata perempuan di berbagai tahap kehidupan. Teknologi yang dirancang dengan perspektif gender dan kepekaan budaya dapat menjadi pengungkit untuk mengatasi hambatan klasik seperti stigma, jarak geografis, dan kelangkaan tenaga ahli. Namun teknologi hanya efektif bila dipasang di atas fondasi tata kelola yang kuat, standar mutu klinis yang jelas, serta perlindungan data dan etika yang ketat. Dengan kerangka ini, telemedicine, aplikasi digital, dan analitik data skala besar dapat bekerja serempak mendukung layanan kuratif, promotif, preventif, hingga rehabilitatif.

Telemedicine menjadi pintu masuk utama yang mengurangi sekat ruang dan waktu antara penyedia layanan dan perempuan yang membutuhkan bantuan. Layanan sinkron melalui video, telepon, atau chat real time memudahkan konsultasi awal, penilaian risiko, penentuan rencana tatalaksana, dan tindak lanjut tanpa memaksa pasien meninggalkan pekerjaan atau pengasuhan anak. Layanan asinkron seperti pesan aman dan monitoring gejala berjadwal memungkinkan tenaga kesehatan menilai tren perbaikan dari waktu ke waktu, misalnya perubahan tidur, nafsu makan, atau intensitas pikiran cemas. Model layanan yang bertingkat memungkinkan kasus ringan ditangani di lini pertama dengan konseling singkat terstruktur, sedangkan kasus sedang hingga berat ditingkatkan ke psikolog atau psikiater. Untuk konteks perinatal, telemedicine mempermudah skrining depresi dan kecemasan pada kunjungan antenatal dan nifas, menyelaraskan jadwal konseling ibu dengan jadwal imunisasi bayi, serta menyediakan ruang tatap muka privat yang aman bagi ibu yang mobilitasnya terbatas. Keamanan dan etika menjadi syarat mutlak, sehingga klinik telemedicine harus menggunakan enkripsi ujung ke ujung, persetujuan tindakan yang jelas, verifikasi identitas yang layak, serta protokol kedaruratan apabila terdeteksi risiko menyakiti diri atau orang lain. Aspek

kesetaraan turut diupayakan melalui opsi koneksi berbandwidth rendah, jam layanan yang fleksibel, dan integrasi dengan rujukan luring ketika diperlukan pemeriksaan fisik, penyesuaian obat, atau penilaian komorbid medis.

Aplikasi digital kesehatan mental melengkapi layanan jarak jauh dengan program swabantu yang terstruktur. Modul berbasis kognitif perilaku, latihan pemecahan masalah, mindfulness, atau manajemen stres dapat dipaketkan menjadi perjalanan belajar singkat yang praktis, dilengkapi pengingat berkala dan pencatatan gejala harian. Pengalaman pengguna yang sensitif gender menjadi kunci agar perempuan merasa aman dan dihargai. Antarmuka yang sederhana, bahasa yang tidak menghakimi, pilihan anonimitas pada tahap awal, serta konten yang mengakui realitas beban ganda pekerjaan dan rumah tangga akan meningkatkan keterlibatan. Fitur adaptasi budaya seperti contoh kasus yang relevan, idiom lokal tentang rasa sedih atau cemas, dan opsi materi berbasis audio penting bagi pengguna dengan literasi baca tulis yang beragam. Untuk penyintas kekerasan, aplikasi harus menyertakan tombol keluar cepat, ikon yang tidak mencolok, panduan keselamatan, serta rute aman menuju layanan perlindungan tanpa meninggalkan jejak yang mudah ditemukan pelaku. Aplikasi yang dipakai dalam sistem kesehatan perlu melewati proses penilaian keamanan, privasi, dan efektivitas, memiliki daftar manfaat yang transparan, serta terhubung dengan fasilitas terdekat agar pengguna dapat beralih dari swabantu ke konsultasi profesional dengan mulus ketika gejala memburuk.

Layanan konseling daring yang ramah perempuan menuntut desain operasional yang menempatkan keselamatan, kerahasiaan, dan kemudahan akses sebagai prioritas. Platform pemesanan yang memungkinkan memilih konselor perempuan, mengatur jadwal di luar jam kerja reguler, dan menyediakan sesi singkat berkualitas tinggi akan menghapus banyak hambatan praktis. Kebijakan biaya yang transparan dan opsi pembiayaan melalui skema jaminan kesehatan atau subsidi daerah mengurangi beban finansial yang sering menjadi alasan utama putus terapi. Setiap sesi dimulai dengan penegasan batas kerahasiaan, penilaian singkat faktor risiko domestik, dan kesepakatan rencana keamanan bila topik kekerasan muncul. Untuk pekerja migran, ruang konseling lintas zona waktu dengan akses melalui ponsel dan dukungan bahasa menjadi syarat agar layanan benar benar hadir di saat diperlukan. Konseling kelompok daring berbasis sebaya untuk ibu pascapersalinan, remaja putri, atau perempuan pada masa perimenopause dapat memperkuat rasa terhubung, menurunkan rasa sendiri, dan menularkan strategi koping yang realistis. Kualitas dijaga melalui supervisi klinis berkala, audit rekam sesi yang dianonimkan, serta pelatihan rutin tentang kompetensi budaya, agama, dan respons terhadap trauma.

Integrasi teknologi dengan layanan luring mencegah fragmentasi. Semua kanal digital harus terhubung dengan puskesmas, rumah sakit, dan layanan perlindungan perempuan dan anak melalui jalur rujukan yang jelas dan standar waktu respons yang disepakati. Hasil skrining di aplikasi masuk ke catatan kesehatan yang dikelola fasilitas, sehingga tenaga kesehatan dapat melihat riwayat gejala, intervensi yang telah dicoba, dan preferensi pasien tanpa memaksa pasien mengulang cerita yang menyakitkan. Notifikasi tindak lanjut terjadwal membantu ketepatan kunjungan kontrol. Bagi wilayah dengan sinyal lemah, materi edukasi dan modul latihan dapat diunduh untuk akses luring, kemudian disinkronkan kembali ketika koneksi tersedia. Untuk menjaga keberlanjutan, kontrak kerja sama dengan penyedia teknologi menyertakan klausul portabilitas data, standar interoperabilitas, dan komitmen dukungan teknis minimum, sehingga layanan tidak berhenti ketika proyek berakhir.

Analitik data skala besar atau big data menjadi mesin pengambilan keputusan berbasis bukti. Data berasal dari berbagai sumber yang sah dan relevan seperti catatan layanan primer dan rujukan, hasil skrining digital, panggilan darurat, dan survei cepat di komunitas. Setelah dianonimkan dan diproteksi, data dipadukan untuk memetakan pola kebutuhan, kesenjangan akses, dan titik kemacetan dalam alur layanan. Peta panas dapat menunjukkan kecamatan dengan angka depresi perinatal yang tinggi, waktu tunggu panjang ke psikolog, atau tingginya angka putus terapi pada minggu kedua, sehingga intervensi dapat difokuskan di lokasi prioritas. Analisis tren membantu menilai dampak kampanye anti stigma atau penambahan sesi konseling malam hari terhadap angka pemanfaatan layanan. Teknik evaluasi yang lincah seperti uji coba bertahap, perbandingan sebelum dan sesudah, atau pendekatan penilaian realistis memberi jawaban cepat tentang apa yang bekerja, untuk siapa, dan dalam kondisi apa. Di saat yang sama, etika data dijaga melalui prinsip minimalisasi, persetujuan yang diinformasikan ketika identitas terlibat, serta pelarangan penggunaan data untuk tujuan yang merugikan kelompok rentan. Algoritme prediktif yang dipakai untuk memperkirakan risiko kekambuhan atau ketidakhadiran kontrol harus diuji biasanya, diawasi oleh tim multidisiplin, dan selalu menempatkan klinisi sebagai pengambil keputusan akhir.

Riset kebijakan berbasis bukti memerlukan jembatan yang kuat antara peneliti, pelaksana layanan, dan pembuat kebijakan. Agenda penelitian disusun bersama agar pertanyaan yang diuji benar benar menjawab persoalan lapangan, misalnya efektivitas konseling singkat tiga sesi dibanding enam sesi pada ibu nifas dengan gejala ringan, atau apakah penambahan jam konsultasi setelah pukul delapan malam meningkatkan kepatuhan kontrol pekerja perempuan. Hasil penelitian diringkas menjadi rekomendasi yang operasional, dilengkapi estimasi biaya, sumber

daya yang dibutuhkan, dan risiko yang perlu dimitigasi. Mekanisme diseminasi yang cepat seperti ringkasan kebijakan dua halaman, dashboard indikator yang mudah dipahami, dan lokakarya perbaikan mutu di puskesmas mempercepat adopsi. Ketika rekomendasi diujicobakan, data pemantauan dikembalikan ke tim kebijakan secara berkala untuk penyesuaian cepat tanpa menunggu siklus perencanaan tahunan.

Seluruh ekosistem inovasi berdiri di atas kepercayaan publik. Karena itu, perlindungan data pribadi, standar klinis, dan akuntabilitas finansial tidak bisa dinegosiasikan. Platform digital wajib memenuhi standar keamanan, mempekerjakan petugas perlindungan data, dan membuka kanal pengaduan yang responsif. Kontrak kerja sama menyebutkan secara jelas kepemilikan data, masa simpan, tempat penyimpanan, dan prosedur penghapusan. Di sisi klinis, setiap intervensi digital dirangkai dengan pedoman tatalaksana nasional sehingga tidak lahir standar ganda. Dari aspek pembiayaan, mekanisme klaim dan paket manfaat harus jelas untuk konsultasi daring, psikoterapi jarak jauh, serta pendampingan komunitas, agar tenaga profesional termotivasi menyediakan layanan dengan mutu yang konsisten.

Dengan rancangan yang matang, inovasi dan teknologi tidak menggantikan peran manusia, melainkan memperkuatnya. Telemedicine memperpendek jarak menuju pertolongan, aplikasi digital memberi alat untuk merawat diri di antara sesi terapi, dan big data menajamkan kebijakan sehingga sumber daya yang terbatas digunakan tepat sasaran. Bagi perempuan yang selama ini tertahan oleh stigma, beban pengasuhan, atau jarak geografis, teknologi menghadirkan jalur akses yang lebih aman, cepat, dan sesuai kebutuhan. Ketika inovasi dikawinkan dengan tata kelola yang etis dan sensitif gender, hasilnya adalah layanan kesehatan mental yang lebih adil, lebih efektif, dan lebih berkelanjutan.

I. Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan Masa Depan

Evaluasi kebijakan kesehatan mental perempuan perlu diletakkan pada kerangka yang menyeluruh, terukur, dan berulang, sehingga setiap intervensi dapat dibuktikan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Langkah pertama adalah menyepakati indikator yang tidak hanya menghitung jumlah kegiatan, tetapi juga menunjukkan mutu klinis, pemerataan, dan hasil pada perempuan di berbagai tahap kehidupan. Indikator input dan kesiapan fasilitas mencakup ketersediaan ruangan yang menjamin kerahasiaan, ketersediaan psikolog, dokter spesialis kedokteran jiwa, konselor terlatih, pekerja sosial, serta kesinambungan obat esensial. Indikator proses menilai apakah skrining dilakukan pada titik kontak strategis seperti kunjungan kehamilan, masa nifas, layanan remaja, dan layanan penyakit tidak menular, apakah rujukan dibuat dalam batas waktu yang disepakati, dan apakah konseling singkat

terstruktur diberikan sesuai protokol. Indikator keluaran menilai keterjangkauan berbagai kanal layanan oleh perempuan, termasuk konsultasi tatap muka, telemedicine, dan aplikasi swabantu, beserta angka partisipasi dan penyelesaian siklus konseling. Indikator hasil klinis menggunakan pengukuran berbasis instrumen yang tervalidasi, misalnya penurunan skor gejala depresi atau kecemasan setelah rangkaian sesi, angka kunjungan ulang dalam tujuh hari setelah pulang dari perawatan, serta angka putus terapi pada minggu kedua hingga keempat. Indikator pemerataan menghitung selisih capaian antara wilayah perkotaan dan pedesaan, antara perempuan berpenghasilan rendah dan menengah, serta antara penerima manfaat program perlindungan sosial dan non penerima. Indikator pengalaman pasien dan keluarga dikumpulkan melalui ukuran pengalaman pengguna layanan yang menilai rasa aman, martabat, kemudahan akses, serta dukungan bagi pengasuhan anak. Di hilir, indikator dampak memantau perbaikan kualitas hidup, keterlibatan kembali di sekolah atau kerja, penurunan kunjungan gawat darurat untuk krisis psikologis yang berulang, serta berkurangnya kasus kekerasan yang berulang setelah perempuan masuk ke jejaring perlindungan.

Agar evaluasi tidak berhenti pada angka, dibutuhkan tata cara penilaian yang kuat. Setiap puskesmas dan rumah sakit menyajikan panel indikator bulanan yang dipilah menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan lokasi, lalu dibandingkan dengan target wilayah. Perubahan dinilai tidak hanya secara rata-rata, tetapi juga dengan memetakan kantong kantong yang tertinggal agar dukungan dapat difokuskan. Analisis tren digunakan untuk membaca efek kampanye anti stigma, penambahan jam layanan malam, atau pembukaan klinik kejiwaan perinatal. Untuk intervensi baru, digunakan uji coba bertahap dan pendekatan realistis yang menjawab pertanyaan apa yang bekerja, untuk siapa, dan dalam kondisi apa. Praktik telaah kasus dan pertemuan mutu lintas profesi memastikan bahwa temuan angka dihubungkan kembali dengan cerita nyata pasien, sehingga koreksi alur rujukan, pelatihan, atau logistik dapat segera dilakukan.

Rekomendasi kebijakan berbasis bukti bergerak dari hal yang paling dekat dengan kebutuhan perempuan. Pertama, integrasikan skrining dan konseling singkat ke dalam layanan primer yang sudah sering diakses perempuan. Kunjungan kehamilan dan masa nifas, layanan keluarga berencana, layanan remaja, dan layanan penyakit tidak menular menjadi pintu masuk yang konsisten. Instrumen skrining yang ringkas digunakan pada beberapa titik waktu, dan hasilnya langsung ditautkan dengan pilihan tindak lanjut, mulai dari konseling singkat terstruktur di lini pertama hingga rujukan ke psikolog atau psikiater untuk kasus sedang dan berat. Kedua, jalankan model perawatan bertingkat yang jelas, sehingga kasus ringan ditangani di puskesmas dengan supervisi berkala, sedangkan kasus kompleks ditangani di rumah

sakit dan dikembalikan lagi ke komunitas dengan rencana pemulihan pribadi. Ketiga, bangun layanan yang peka terhadap pengalaman kekerasan. Setiap titik layanan memiliki protokol yang aman untuk menanyakan dan menindaklanjuti kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual, dilengkapi jalur rujukan ke unit layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak, bantuan hukum, serta tempat aman sementara. Keempat, perkuat tenaga melalui pembagian tugas yang cermat. Dokter, bidan, perawat, dan konselor di lini pertama dilatih konseling berbasis bukti dan pertolongan pertama psikologis, sementara psikolog dan psikiater menyediakan supervisi terjadwal dan konsultasi kasus. Kelima, pastikan pembiayaan yang adil. Terapkan paket manfaat yang mencakup psikoterapi tatap muka dan jarak jauh, berikan tarif yang realistis untuk konseling, akui layanan kelompok sebaya yang terstruktur, dan sediakan anggaran kecil yang fleksibel untuk kebutuhan praktis seperti transportasi dan penitipan anak selama sesi. Keenam, jalankan komunikasi publik yang konsisten dan aman. Kampanye anti stigma diatur berkelanjutan, dikaitkan dengan kesiapan layanan, dan menonjolkan kisah pemulihan agar perilaku mencari bantuan menjadi wajar.

Teknologi menjadi pengungkit kebijakan, tetapi harus diselaraskan dengan tata kelola yang kokoh. Telemedicine diperluas dengan memperhatikan keamanan data, verifikasi identitas, dan protokol krisis. Aplikasi swabantu diseleksi melalui kurasi nasional yang menilai keamanan, privasi, dan bukti efektivitas, lalu dihubungkan dengan fasilitas terdekat agar pengguna dapat beralih ke konsultasi profesional ketika gejala memburuk. Seluruh kanal digital diintegrasikan dengan sistem informasi kesehatan yang sudah ada, sehingga catatan skrining dan konseling tidak tercecer. Data disajikan di dasbor yang mudah dipahami, dan dikembalikan kepada pelaksana lapangan dalam bentuk umpan balik rutin. Algoritme prediktif digunakan secara hati hati, diuji biasanya, dan selalu ditempatkan sebagai alat bantu, bukan pengganti keputusan klinis.

Arah pengembangan kebijakan ke depan menuntut kepekaan terhadap arus globalisasi dan percepatan era digital. Mobilitas manusia meningkat, sehingga dukungan bagi pekerja migran perempuan harus melintasi batas negara. Layanan konseling lintas zona waktu, portabilitas hak atas manfaat kesehatan, dan kemitraan dengan organisasi diaspora perlu menjadi bagian dari perencanaan. Perubahan iklim, bencana, dan guncangan ekonomi menghadirkan gelombang stres baru, sehingga rencana kesiapsiagaan harus memasukkan dukungan psikososial yang ramah perempuan sejak tahap perencanaan darurat hingga pemulihan. Ekosistem digital yang kian dominan menuntut kebijakan yang melindungi dari kekerasan berbasis siber, perundungan, dan penyebaran informasi yang menyesatkan tentang kesehatan mental. Literasi digital bagi remaja putri, ibu muda, dan pekerja

perempuan menjadi bagian kurikulum layanan, sementara platform digital didorong untuk menjalankan kebijakan moderasi yang lebih bertanggung jawab, bekerja sama dengan otoritas kesehatan dan organisasi masyarakat sipil.

Kemajuan kecerdasan artifisial membuka peluang sekaligus risiko. Alat berbasis kecerdasan artifisial dapat membantu triase awal, menandai tanda bahaya, dan mempersonalisasi pengingat perawatan, tetapi penggunaannya harus transparan, dapat diaudit, dan diawasi oleh tenaga profesional. Kebijakan perlu menetapkan standar etik, jejak audit, dan mekanisme akuntabilitas ketika terjadi kesalahan. Di sisi data, kedaulatan dan keamanan menjadi perhatian utama. Data pribadi perempuan harus diproteksi dengan enkripsi yang kuat, batas akses yang ketat, dan prinsip minimalisasi. Perjanjian kerja sama dengan penyedia teknologi menyebutkan kepemilikan data, masa simpan, tempat penyimpanan, dan prosedur penghapusan yang dapat diverifikasi. Standar interoperabilitas diterapkan agar data dapat berpindah ketika program berganti, tanpa mengunci layanan pada satu vendor.

Kebijakan masa depan juga perlu memperkuat suara pengguna. Perempuan yang pernah menggunakan layanan dilibatkan sebagai penasihat. Forum umpan balik yang aman dan tidak menghakimi disediakan di puskesmas dan platform digital. Rekomendasi perbaikan yang lahir dari pengalaman pengguna mendapatkan jalur cepat ke pengambil keputusan. Mekanisme insentif diarahkan pada hasil yang penting bagi pasien, misalnya pemulihan peran sosial, kepuasan layanan, dan penurunan waktu tunggu, bukan hanya pada banyaknya kegiatan yang dilakukan. Kerja sama lintas sektor diperdalam melalui target bersama yang nyata, seperti menurunkan depresi perinatal di satu kabupaten tertentu, atau mengurangi putus sekolah pada remaja putri yang mengalami gangguan kecemasan. Semua target tersebut disertai peta rujukan, jadwal pertemuan rutin, dan sumber pendanaan yang jelas.

J. Simpulan

Kesehatan mental perempuan adalah fondasi pembangunan manusia yang menentukan kualitas keluarga, komunitas, dan daya saing bangsa. Data nasional dan mandat global sama-sama menunjukkan bahwa beban gangguan mental pada perempuan lebih tinggi, dengan jendela kerentanan yang khas sepanjang daur kehidupan, terutama pada masa remaja, kehamilan, pascapersalinan, dan perimenopause. Kerentanan ini dibentuk oleh pertemuan faktor biologis dengan faktor sosial budaya seperti beban kerja domestik yang tidak dibayar, ketidaksetaraan ekonomi, dan paparan kekerasan berbasis gender. Karena itu,

kebijakan yang efektif tidak cukup klinis semata, melainkan harus berwatak lintas sektor, adil gender, dan berjangka panjang.

Arsitektur kebijakan nasional sudah menyiapkan landasan yang kuat melalui payung hukum kesehatan, standar pelayanan minimal, rencana pembangunan menengah, dan skema pembiayaan jaminan kesehatan. Di atas landasan tersebut, layanan primer menjadi simpul integrasi yang menghubungkan promosi, pencegahan, skrining, tatalaksana awal, dan rujukan, sementara rumah sakit menyediakan layanan intensif dan perencanaan pulang yang matang. Program berbasis keluarga, sekolah, dan tempat kerja memperluas jangkauan, sedangkan perlindungan bagi penyintas kekerasan memastikan pemulihan psikologis berjalan bersama dukungan hukum dan sosial. Ketika rantai layanan ini disatukan dengan tata kelola data yang baik dan pembiayaan yang berkelanjutan, akses yang setara bagi perempuan menjadi tujuan yang realistis, bukan sekadar aspirasi.

Strategi yang menonjol dari keseluruhan pembahasan adalah pentingnya pendekatan berbasis daur hidup yang peka gender dan budaya. Edukasi yang relevan dengan realitas peran perempuan, kelompok dukungan sebaya yang aman, serta konseling singkat terstruktur di lini pertama terbukti mengurangi hambatan awal pencarian bantuan. Pada saat yang sama, layanan kuratif dan rehabilitatif harus berorientasi pemulihan, memadukan intervensi klinis dengan dukungan sosial ekonomi, penguatan peran keluarga, dan rencana pencegahan kekambuhan yang jelas. Inovasi digital seperti telemedicine, aplikasi swabantu, dan analitik data memberi daya ungkit untuk memperpendek jarak, mempercepat respons, dan menajamkan sasaran, asalkan dijalankan dengan standar mutu klinis, etika, dan perlindungan data yang ketat.

Tantangan implementasi tetap nyata. Stigma sosial menutup pintu masuk layanan, kelangkaan dan ketimpangan distribusi tenaga menggerus mutu, sedangkan kesenjangan kota dan desa membuat kelompok paling membutuhkan sering tertinggal. Kelemahan tata kelola data dan rujukan juga berkontribusi terhadap putusnya layanan. Menjawab tantangan ini menuntut kombinasi strategi: komunikasi publik anti stigma yang terhubung dengan kesiapan layanan, perencanaan kebutuhan tenaga dan supervisi klinis berjenjang, penguatan ruang aman dan logistik obat di daerah terpencil, serta pendanaan yang cukup fleksibel untuk kebutuhan praktis seperti transportasi dan penitipan anak selama sesi konseling. Di ranah koordinasi, sekretariat lintas sektor di tingkat daerah perlu memastikan standar waktu respons, formulir komunikasi yang melindungi privasi, dan peta rujukan yang diperbarui berkala.

Keberhasilan kebijakan pada akhirnya diukur dari perubahan yang dirasakan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Indikator yang terpilah menurut jenis

kelamin, usia, lokasi, dan kondisi sosial perlu dipakai untuk menilai peningkatan deteksi dini, kecepatan rujukan, penyelesaian siklus konseling, penurunan gejala, pemulihan peran sosial, serta berkurangnya kekerasan yang berulang. Suara pengguna layanan harus menjadi kompas perbaikan, dan teknologi dimanfaatkan secara etis untuk mempercepat pembelajaran kebijakan. Dengan disiplin evaluasi, pembiayaan yang adil, dan kolaborasi lintas sektor yang konsisten, Indonesia memiliki modal untuk membangun ekosistem kesehatan mental yang ramah perempuan, menutup kesenjangan akses, dan mengubah niat baik menjadi dampak nyata. Simpul akhirnya sederhana sekaligus mendasar: setiap perempuan berhak mendapatkan dukungan yang aman, bermutu, dan sesuai budaya untuk pulih, tumbuh, dan menentukan arah hidupnya dengan bermartabat.

K. Referensi

- Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI. (2024). Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023: Lembar fakta – Depresi pada anak muda. <https://www.badankebijakan.kemkes.go.id/fact-sheet-survei-kesehatan-indonesia-ski-2023/>
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2019). Laporan nasional Riskesdas 2018. Kementerian Kesehatan RI. <https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/3514/1/Laporan%20Riskesdas%202018%20Nasional.pdf>
- Chisholm, D., Sweeny, K., Sheehan, P., Rasmussen, B., Smit, F., Cuijpers, P., & Saxena, S. (2016). Scaling-up treatment of depression and anxiety: A global return on investment analysis. *The Lancet Psychiatry*, 3(5), 415–424. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(16\)30024-4](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(16)30024-4)
- Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. <https://peraturan.bpk.go.id/details/258028/uu-no-17-tahun-2023>
- Kementerian Kesehatan RI. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/104033/Permenkes%20Nomor%2039%20Tahun%202016.pdf>
- Kementerian Kesehatan RI. (2024). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/347288/Permenkes%20Nomor%206%20Tahun%202024.pdf>
- Kementerian Kesehatan RI, Direktorat P2MKJN. (2020). Pedoman Penyelenggaraan

- Kesehatan Jiwa di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama. Kementerian Kesehatan RI. <https://repository.kemkes.go.id/book/1259>
- Kementerian PPN/Bappenas. (2019). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024: Buku I (Narasi). https://ditkumlas.bappenas.go.id/download/file/Narasi_RPJMN_2020-2024.pdf
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2021: Kekerasan terhadap perempuan. <https://ppid.kemenpppa.go.id/uploads/informasi/publik/1747205630.pdf>
- Presiden Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/94711/perpres-no-82-tahun-2018>
- Presiden Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/168225/Perpres%20Nomor%2072%20Tahun%202021.pdf>
- Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/202006/UU%20Nomor%2012%20Tahun%202022.pdf>
- Tyas, A. P., & Setyonaluri, D. (2022). Association between maternal mental health and child stunting in Indonesia. *KEMAS: Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 17(3), 381–388. <https://doi.org/10.15294/kemas.v17i3.27813>
- Saptarini, I., Rizkianti, A., & Arfines, P. P. (2019). Dampak depresi parental terhadap kejadian stunting di Indonesia. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 48(1), 1–10. <https://doi.org/10.22435/bpk.v48i1.2752>
- World Health Organization. (2016). mhGAP intervention guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health settings (Version 2.0). <https://www.who.int/publications/i/item/9789241549790>
- World Health Organization. (2016, April 13). Investing in treatment for depression and anxiety leads to fourfold return. <https://www.who.int/news/item/13-04-2016-investing-in-treatment-for-depression-and-anxiety-leads-to-fourfold-return>
- World Health Organization. (2022). Guide for integration of perinatal mental health in maternal and child health services. <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/362880/9789240057142-eng.pdf>
- World Health Organization. (2023, March 31). Depressive disorder (depression). <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression>

World Health Organization. (n.d.). Perinatal mental health. <https://www.who.int/teams/mental-health-and-substance-use/promotion-prevention/maternal-mental-health>

World Health Organization. (n.d.). SDG Target 3.4: Noncommunicable diseases and mental health. <https://www.who.int/data/gho/data/themes/topics/indicator-groups/indicator-group-details/GHO/sdg-target-3.4-noncommunicable-diseases-and-mental-health>

Kementerian Kesehatan RI. (2020/2022). Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020–2024 (dan perubahannya). <https://ppid.kemkes.go.id/toapsoot/2022/06/Renstra-Kemenkes-Tahun-2020-2024-1.pdf>

L. Glosarium

Aplikasi digital kesehatan mental: perangkat lunak pada gawai yang menyediakan materi swabantu, pemantauan gejala, pengingat, dan jalur konsultasi jarak jauh untuk pencegahan serta penanganan masalah kesehatan mental.

Analitik data skala besar (big data): pengolahan kumpulan data sangat besar dari berbagai sumber layanan untuk memetakan kebutuhan, kesenjangan akses, dan efektivitas intervensi kebijakan secara berkala.

Anggaran responsif gender: perencanaan dan penganggaran yang mempertimbangkan kebutuhan berbeda antara perempuan dan laki-laki agar alokasi sumber daya lebih adil serta berdampak.

Asesmen klinis komprehensif: pengkajian menyeluruh terhadap gejala, fungsi sosial, faktor risiko, kekuatan pasien, serta konteks keluarga dan pekerjaan sebagai dasar rencana tatalaksana.

Bantuan Operasional Kesehatan: dukungan dana operasional untuk Puskesmas dan jaringannya yang menunjang kegiatan promotif dan preventif termasuk edukasi, skrining, serta kunjungan rumah.

Depresi perinatal: depresi yang terjadi selama kehamilan hingga sekitar satu tahun setelah persalinan yang dapat mengganggu ikatan ibu dan bayi, menyusui, serta fungsi harian.

Depresi pascapersalinan: depresi setelah melahirkan yang ditandai suasana hati sedih berkepanjangan, hilang minat, rasa bersalah, kelelahan, gangguan tidur, dan risiko pikiran menyakiti diri.

Deteksi dini atau skrining: penjarangan cepat menggunakan instrumen tervalidasi untuk mengenali gejala awal depresi, kecemasan, atau kondisi lain sebelum menjadi berat.

Dukungan sebaya: bantuan emosional dan praktis dari individu dengan pengalaman serupa untuk mengurangi stigma dan meningkatkan keterlibatan pada terapi.

Gangguan mental emosional: istilah surveilans untuk gejala depresi dan kecemasan pada populasi yang diukur dengan instrumen standar.

Indikator input, proses, keluaran, hasil, dan dampak: rangkaian ukuran kinerja layanan yang menilai ketersediaan sumber daya, pelaksanaan layanan, jangkauan, perubahan klinis, dan perubahan pada tingkat populasi.

Jaminan Kesehatan Nasional: skema pembiayaan publik yang menanggung pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai ketentuan termasuk layanan kesehatan jiwa berjenjang.

Kehamilan dan masa nifas: periode mulai konsepsi hingga sekitar enam minggu setelah persalinan yang ditandai perubahan biologis dan psikososial intens serta peningkatan kerentanan gangguan mood.

Kesehatan mental: kondisi kesejahteraan ketika individu menyadari kemampuannya, mampu mengatasi tekanan hidup yang wajar, bekerja produktif, dan berkontribusi pada komunitas.

Kesenjangan akses layanan: ketidakmerataan kemampuan memperoleh layanan bermutu akibat faktor geografis, ekonomi, budaya, bahasa, atau keterbatasan tenaga dan sarana.

Kekerasan berbasis gender: tindakan kekerasan fisik, seksual, psikologis, atau ekonomi yang berakar pada relasi kekuasaan tidak setara dan berdampak langsung pada kesehatan mental perempuan.

Kelompok dukungan ibu dan bayi: pertemuan terstruktur di komunitas yang memperkuat ikatan ibu dan bayi, berbagi keterampilan pengasuhan responsif, serta mendeteksi dini masalah emosional pascapersalinan.

Klinik ramah remaja: layanan kesehatan yang menyesuaikan pendekatan, jadwal, dan privasi agar remaja mudah mengakses konseling, informasi kesehatan reproduksi, dan dukungan psikososial.

Konseling singkat terstruktur: intervensi psikososial durasi pendek dengan modul baku seperti pemecahan masalah atau kognitif perilaku dasar yang dapat diberikan di layanan primer dengan supervisi.

Konseling kelompok daring: konseling bermedia konferensi video atau percakapan daring untuk beberapa peserta dengan isu serupa guna meningkatkan keterjangkauan dan dukungan.

Konsultasi dan liaison psikiatri: layanan psikiatri di rumah sakit umum yang bekerja lintas departemen untuk kasus dengan komorbid medis seperti kebidanan atau penyakit tidak menular.

Literasi kesehatan mental: pengetahuan dan sikap yang membantu seseorang mengenali, mencegah, serta mencari pertolongan untuk masalah kesehatan mental secara tepat dan tanpa stigma.

Lokakarya mini Puskesmas: pertemuan berkala lintas program di Puskesmas untuk meninjau data, mengatasi hambatan operasional, dan menyepakati langkah perbaikan mutu termasuk jejaring rujukan.

Manajemen rujukan berjenjang: alur pengiriman pasien dari layanan primer ke spesialis dan kembali ke komunitas dengan informasi klinis memadai serta batas waktu respons yang jelas.

Model perawatan bertingkat: penataan layanan berdasarkan tingkat keparahan dan respons terapi, dimulai dari intervensi paling ringan yang efektif lalu meningkat bila diperlukan.

Norma, standar, prosedur, dan kriteria: kerangka teknis yang memastikan mutu serta keseragaman layanan kesehatan mental di semua jenjang.

Panduan intervensi mhGAP: pedoman Organisasi Kesehatan Dunia bagi layanan nonspesialis untuk menangani gangguan mental, neurologis, dan penggunaan zat di tingkat primer.

Pendekatan berbasis daur hidup: perencanaan layanan mengikuti tahapan kehidupan perempuan dari remaja, pra-nikah, hamil, nifas, hingga perimenopause.

Pendekatan berbasis trauma: cara kerja layanan yang memprioritaskan keselamatan, pilihan, dan pemberdayaan penyintas serta meminimalkan pemicu ulang pengalaman traumatis.

Penjaringan di Posyandu: kegiatan menemukan dini sasaran berisiko saat penimbangan, imunisasi, atau layanan keluarga lain untuk dipantau atau dirujuk.

Perimenopause: fase transisi menuju berhentinya haid yang ditandai fluktuasi hormon dan gejala fisik serta psikologis yang memengaruhi suasana hati dan tidur.

Peraturan perundangan kesehatan: payung hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan peraturan presiden yang menjadi dasar penyelenggaraan layanan kesehatan jiwa.

Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular: kegiatan komunitas untuk deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular yang dapat diintegrasikan dengan edukasi dan skrining kesehatan mental.

Posyandu keluarga: platform layanan kesehatan berbasis masyarakat yang menggabungkan layanan ibu dan anak dengan kegiatan keluarga, efektif untuk promosi dan penjaringan kesehatan mental.

Pusat kesehatan masyarakat: fasilitas pelayanan primer yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat serta menjadi simpul integrasi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Rencana keselamatan: dokumen praktis berisi tanda bahaya, langkah perlindungan diri, dan kontak darurat yang disusun bersama pasien untuk pencegahan krisis.

Rencana pemulihan pribadi: rencana tujuan hidup bermakna setelah terapi yang disusun pasien bersama tim layanan, mencakup pekerjaan, pendidikan, relasi, dan peran keluarga.

Rehabilitasi berbasis komunitas: dukungan berkelanjutan di lingkungan tempat tinggal untuk memulihkan fungsi sosial, kemandirian ekonomi, dan kualitas hidup setelah fase akut.

Return on investment kesehatan mental: perbandingan manfaat ekonomi dan kesehatan yang diperoleh dari investasi layanan kesehatan mental terhadap biaya yang dikeluarkan.

Riset kebijakan berbasis bukti: penelitian yang menjawab pertanyaan praktis pembuat kebijakan serta menghasilkan rekomendasi operasional yang diuji dan dipantau dampaknya.

Rujukan balik: pengembalian pasien dari fasilitas rujukan ke Puskesmas disertai ringkasan klinis dan rencana tindak lanjut untuk kesinambungan perawatan.

Skrining depresi dan kecemasan: penggunaan alat ukur ringkas tervalidasi pada titik kontak strategis seperti kunjungan kehamilan, masa nifas, layanan remaja, dan layanan penyakit tidak menular.

Standar Pelayanan Minimal kesehatan: batas mutu dan jenis layanan dasar yang wajib disediakan pemerintah daerah termasuk layanan kesehatan jiwa prioritas.

Survei Kesehatan Indonesia: survei nasional yang memotret indikator kesehatan penduduk, termasuk estimasi depresi serta pemanfaatan layanan.

Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional: survei yang mengukur prevalensi dan pola kekerasan terhadap perempuan, penting untuk memahami determinan sosial kesehatan mental.

Telekonseling: layanan konseling psikologis melalui telepon, obrolan, atau video dengan menjaga kerahasiaan dan fleksibilitas waktu.

Telemedicine: pelayanan medis jarak jauh yang aman untuk konsultasi, evaluasi, dan tindak lanjut dengan protokol kedaruratan yang jelas.

Terapi kognitif perilaku dasar: intervensi psikologis untuk mengenali pola pikir tidak adaptif dan mengubah perilaku agar gejala depresi atau kecemasan berkurang.

Tim kesehatan jiwa berbasis komunitas: tenaga lintas profesi di wilayah kerja Puskesmas yang melakukan kunjungan rumah, pemantauan kepatuhan, edukasi keluarga, serta penguatan rujukan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan target tiga titik empat: komitmen global yang menekankan promosi kesehatan mental dan kesejahteraan serta penurunan kematian dini akibat penyakit tidak menular.

PROFIL PENULIS



Bdn. Eny Siswati SST., M.Si, Lahir di Jombang, 18 Agustus 1979. Pertama kali menempuh Pendidikan Kesehatan di sekolah perawat Kesehatan Tahun 1998, Melanjutkan studi D4 kebidanan di Stikes Husada Jombang, Kemudian melanjutkan Studi Megister Sains Psikologi di Universitas Muhammadiyah Malang. Kemudian di tahun 2021 melanjutkan sekolah Bidan Profesi di Stikes Husada jombang. Perjalanan karir dimulai dengan bekerja di pelayaran Kesehatan, di mana saya memperoleh pengalaman berharga dalam dunia kesehatan. Penulis memutuskan untuk melanjutkan karir di bidang pendidikan, khususnya di bidang kebidanan untuk mejadi

Dosen, di Akademi Kebidanan Sukawati Lawang. Untuk saat ini Penulis sebagai dosen tetap di STIKES Husada Jombang. Selain itu, penulis juga aktif mengikuti Organisasi IBI dan menjadi Sekretasi IBI Ranting Sngosari. Penulis dapat dihubungi melalui email: enysiswanti18@gmail.com



Aminah, S.S.T., M.Kes Lahir di Pandeglang, 29 Maret 1989.. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIV pada Program Studi Kebidanan, Universitas UIMA tahun 2011. Kemudian melanjutkan Kembali pendidikan S2 pada Universitas UIMA dan lulus tahun pada tahun 2015. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2011 menjadi bidan Desa di salah satu Puskesmas di Kab. Pandeglang. Saat ini penulis bekerja di Universitas La Tansa Mashiro mengampu mata kuliah KKPK, Komunikasi Kebidanan, Asuhan Neonatus dan Promosi Kesehatan & Epidemiologi Stunting. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis

dapat dihubungi melalui e-mail: aminah.s.st14@gmail.com

Motto: "Jangan Takut Mencoba Hal yang Baru, Coba Saja, Biarkan Proses Menjawab Ketakutan Itu".

PROFIL PENULIS



Karolin Adhisty, S.Kep., Ns., M.Kep Lahir di Palembang, 08 Juli 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, Universitas Sriwijaya tahun 2007. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan S2 Keperawatan Peminatan Maternitas pada Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2017 sebagai Dosen Bagian Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya sampai dengan sekarang. Penulis mengampu mata kuliah Keperawatan Maternitas, Keperawatan Paliatif juga mata kuliah keperawatan dasar keperawatan. Penulis aktif

dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi jurnal nasional, seminar nasional dan internasional juga melakukan pengabdian kepada masyarakat. Penulis fokus untuk mengembangkan keperawatan maternitas bidang onkologi yang tercermin pada karya tulis ilmiah juga pengabdian kepada masyarakat. Penulis juga aktif dalam organisasi Profesi Keperawatan, yaitu Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Perawat Maternitas Indonesia (IPEMI) dan menjadi ketua dari Ikatan Alumni Keperawatan Universitas Sriwijaya (IKAPERSI). Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: karolin.adhisty@fk.unsri.ac.id

Sinopsis

Buku Bunga Rampai Kesehatan Mental Perempuan dalam Perspektif Kebidanan: Dari Menarke hingga Menopause menghadirkan pemahaman komprehensif tentang dinamika kesehatan mental perempuan sepanjang siklus hidupnya. Dimulai dari menarke sebagai tanda awal kedewasaan reproduktif, masa kehamilan dan persalinan yang penuh tantangan emosional, hingga fase menopause yang sarat perubahan biologis dan psikososial, setiap bab dalam buku ini menguraikan isu-isu penting yang sering dihadapi perempuan.

Bidan sebagai tenaga kesehatan yang paling dekat dengan perempuan memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan kesehatan mental pada setiap fase tersebut. Buku ini menyoroti bagaimana bidan dapat berperan melalui deteksi dini, konseling, edukasi, dukungan emosional, fasilitasi jejaring sosial, hingga advokasi kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan perempuan. Pendekatan ini diperkaya dengan kajian berbasis bukti ilmiah, pengalaman lapangan, serta perspektif kebidanan yang peka budaya dan kontekstual.

Disusun oleh akademisi dan praktisi yang berkompeten, buku ini tidak hanya ditujukan bagi mahasiswa dan dosen kebidanan, tetapi juga bagi tenaga kesehatan, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas yang peduli pada kesehatan perempuan. Dengan membaca buku ini, pembaca akan mendapatkan wawasan baru mengenai pentingnya integrasi aspek mental, sosial, dan biologis dalam layanan kebidanan. Lebih dari itu, buku ini diharapkan menjadi sumber inspirasi untuk memperkuat peran bidan sebagai agen perubahan dalam membangun perempuan yang sehat, tangguh, dan berdaya sepanjang siklus hidupnya.

Buku Bunga Rampai Kesehatan Mental Perempuan dalam Perspektif Kebidanan: Dari Menarke hingga Menopause menghadirkan pemahaman komprehensif tentang dinamika kesehatan mental perempuan sepanjang siklus kehidupannya. Dimulai dari menarke sebagai tanda awal kedewasaan reproduktif, masa kehamilan dan persalinan yang penuh tantangan emosional, hingga fase menopause yang sarat perubahan biologis dan psikososial, setiap bab dalam buku ini menguraikan isu-isu penting yang sering dihadapi perempuan.

Bidan sebagai tenaga kesehatan yang paling dekat dengan perempuan memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan kesehatan mental pada setiap fase tersebut. Buku ini menyoroti bagaimana bidan dapat berperan melalui deteksi dini, konseling, edukasi, dukungan emosional, fasilitasi jejaring sosial, hingga advokasi kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan perempuan. Pendekatan ini diperkaya dengan kajian berbasis bukti ilmiah, pengalaman lapangan, serta perspektif kebidanan yang peka budaya dan kontekstual.

Disusun oleh akademisi dan praktisi yang berkompeten, buku ini tidak hanya ditujukan bagi mahasiswa dan dosen kebidanan, tetapi juga bagi tenaga kesehatan, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas yang peduli pada kesehatan perempuan. Dengan membaca buku ini, pembaca akan mendapatkan wawasan baru mengenai pentingnya integrasi aspek mental, sosial, dan biologis dalam layanan kebidanan. Lebih dari itu, buku ini diharapkan menjadi sumber inspirasi untuk memperkuat peran bidan sebagai agen perubahan dalam membangun perempuan yang sehat, tangguh, dan berdaya sepanjang siklus hidupnya.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

